ΔΩΡΟ 3 / 5 · ΚΙΤ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

100 Πρακτικά Περιστατικά

Ταξινομημένα κατά βαθμό δυσκολίας. Πρώτα περιγράφετε εσείς, έπειτα συγκρίνετε με την πρότυπη περιγραφή και σε κάθε περιστατικό βλέπετε το πιο συχνό λάθος.

Περιεχόμενα

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Αρχάριο · Περιστατικά 1–35

Κλειδί απαντήσεων — Αρχάριο

Μέτριο · Περιστατικά 36–70

Κλειδί απαντήσεων — Μέτριο

Προχωρημένο · Περιστατικά 71–100

Κλειδί απαντήσεων — Προχωρημένο

Τετράδιο λαθών

Επόμενο βήμα

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Πώς να το χρησιμοποιήσετε

Αυτό το βιβλίο δεν είναι βιβλίο ανάγνωσης, αλλά τετράδιο προπόνησης. Κάθε περιστατικό είναι μια επανάληψη, κάθε λάθος ένα δεδομένο.

> *Πρώτα γράψτε εσείς, μετά κοιτάξτε. Κάθε περιστατικό στο οποίο δεν γράψατε τη δική σας περιγραφή πριν διαβάσετε την απάντηση είναι ένα περιστατικό που δεν μάθατε.*

Σε κάθε περιστατικό τα ίδια 5 βήματα

1. **Ξεκινήστε το χρονόμετρο** — Δώστε στον εαυτό σας ένα χρονικό όριο ανά περιστατικό (π.χ. 2–3 λεπτά). Και στην εφημερία ο χρόνος είναι περιορισμένος· η ταχύτητα έρχεται με την επανάληψη της σωστής σειράς.

2. **Περιγράψτε με τη μέθοδο των 4 βημάτων** — ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ (εξέταση, ποιότητα, προσανατολισμός) · ΣΑΡΩΣΤΕ (κάθε περιοχή, με την ίδια σειρά, χωρίς να σταματάτε στο πρώτο εύρημα) · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ (σωστός όρος, εντόπιση, όρια, σύγκριση) · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ (συμπερασματική πρόταση, διαφορική διάγνωση, σύσταση, επείγουσα ενημέρωση).

3. **Γράψτε στο πλαίσιο** — Γράψτε την περιγραφή σας σε γλώσσα γνωμάτευσης, με πλήρεις προτάσεις. Το «Υπάρχει πνευμονία» δεν είναι περιγραφή· η πυκνότητα, η εντόπιση και το περιεχόμενο είναι περιγραφή.

4. **Συγκρίνετε με το κλειδί απαντήσεων** — Στο τέλος κάθε ενότητας, με τον ίδιο αριθμό, υπάρχουν η πρότυπη περιγραφή, η διάγνωση και το πιο συχνό λάθος. Συγκρίνετε τους όρους, τη σειρά και τη συμπερασματική σας πρόταση.

5. **Σημειώστε το λάθος σας** — Στο «Τετράδιο λαθών» στο τέλος του βιβλίου γράψτε τον αριθμό του περιστατικού και τον τύπο του λάθους: αντίληψη (δεν το είδα), γνώση (δεν το ήξερα), όρος (λάθος λέξη), συμπέρασμα (λάθος ή ελλιπής σύνοψη).

Επίπεδα

Αρχάριο 1–35 · Μέτριο 36–70 · Προχωρημένο 71–100

Προχωρήστε με τη σειρά. Μην περάσετε στο επόμενο επίπεδο πριν μειωθούν τα λάθη σας στο τρέχον.

Φυσιολογικά περιστατικά

Σε κάθε επίπεδο υπάρχουν και φυσιολογικές εξετάσεις. Σε περιστατικό με ερώτηση «υπάρχει παθολογία;» η απάντηση μπορεί να είναι «όχι». Η υπερδιάγνωση είναι επίσης λάθος.

Οι αγκύλες

Στις πρότυπες περιγραφές, οι εκφράσεις μέσα σε [ ] είναι πεδία που πρέπει να συμπληρώσετε εσείς με βάση την εικόνα (πλευρά, επίπεδο, μέτρηση, ναι / όχι). Η ανάγνωσή τους από την εικόνα και η καταγραφή τους αποτελούν μέρος της άσκησης.

Μία εικόνα, μία τομή

Σε κάθε περιστατικό υπάρχει μία μόνο εικόνα ή τομή. Στην πραγματική πράξη εξετάστε ολόκληρη τη σειρά, όλες τις προβολές και τις προηγούμενες εξετάσεις, αν υπάρχουν. Οι περιγραφές εδώ είναι εκπαιδευτικά παραδείγματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

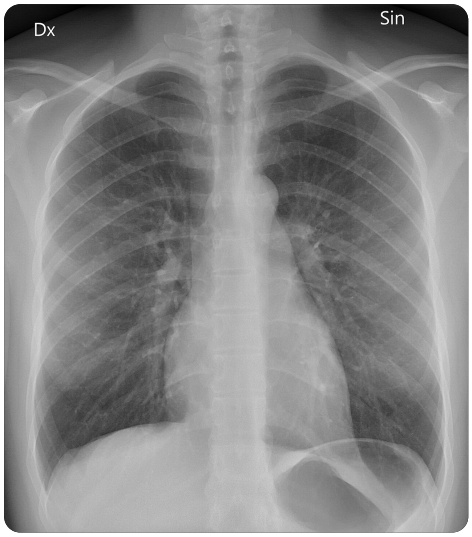
Αρχάριο

Περιστατικά 1–35. Συχνά, εμφανή ευρήματα και βασικά φυσιολογικά. Στόχος: να γίνει αυτόματη η σταθερή σειρά.

Περιστατικό 1

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Προεγχειρητικός έλεγχος ρουτίνας· ασυμπτωματικός.



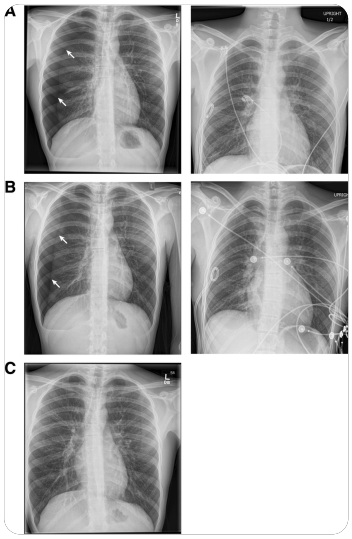
Περιστατικό 1 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Ερώτηση: Υπάρχει παθολογία σε αυτή την ακτινογραφία; Περιγράψτε συστηματικά.

Περιστατικό 2

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Αιφνίδιο θωρακικό άλγος και δύσπνοια.



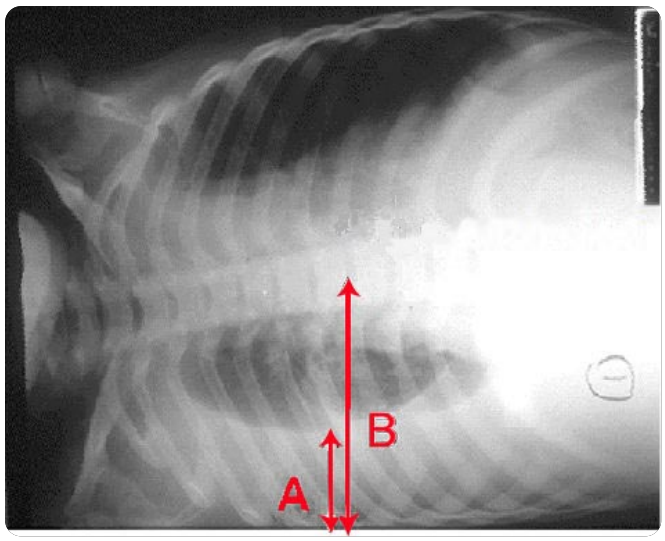
Περιστατικό 2 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Ερώτηση: Περιγράψτε το εύρημα και αναφέρετε τον βαθμό επείγοντος.

Περιστατικό 3

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Δύσπνοια που επιδεινώνεται εδώ και μερικές εβδομάδες.



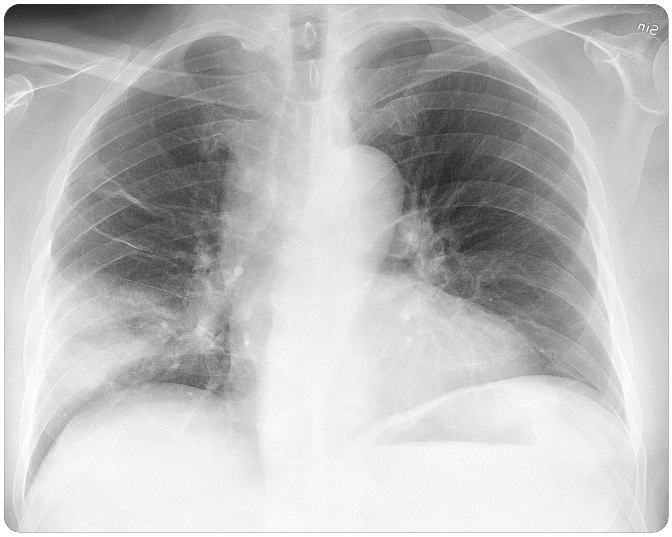
Περιστατικό 3 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Ερώτηση: Περιγράψτε το εύρημα· από ποιο χαρακτηριστικό καταλάβατε ότι πρόκειται για υγρό;

Περιστατικό 4

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Πυρετός, βήχας και απόχρεμψη.



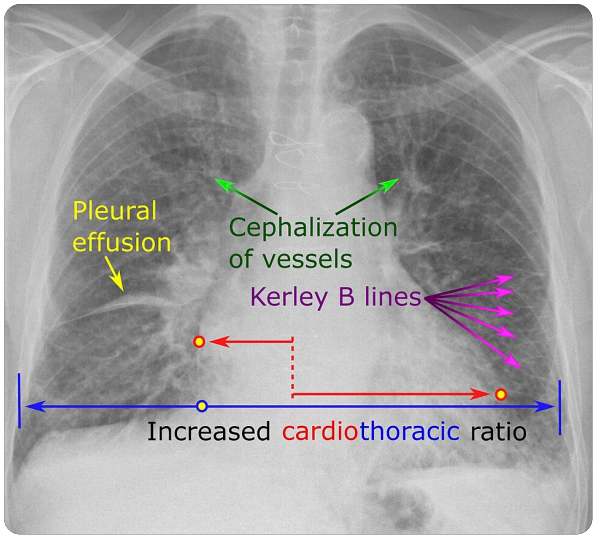
Περιστατικό 4 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Ερώτηση: Περιγράψτε τη σκίαση ως προς την πυκνότητα, τα όρια και το περιεχόμενο.

Περιστατικό 5

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Δύσπνοια προσπαθείας και οίδημα κάτω άκρων.



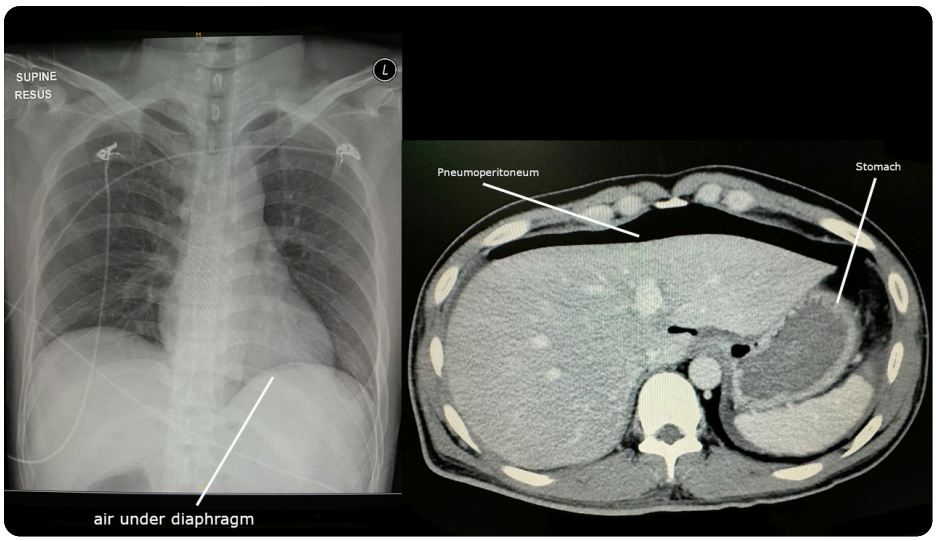
Περιστατικό 5 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Ερώτηση: Εκτιμήστε το μέγεθος της καρδιάς και γράψτε πώς το μετρήσατε.

Περιστατικό 6

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα σε όρθια θέση / απλή ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση ·
Κλινικές πληροφορίες: Αιφνίδιο έντονο κοιλιακό άλγος, σύσπαση κοιλιακού τοιχώματος.



Περιστατικό 6 · Ακτινογραφία θώρακα σε όρθια θέση / ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση

Ερώτηση: Εκτιμήστε την περιοχή κάτω από το διάφραγμα.

Περιστατικό 7

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία καρπού AP και πλάγια · **Κλινικές πληροφορίες:** Πτώση σε τεντωμένο χέρι.

Περιστατικό 7 · Ακτινογραφία καρπού AP και πλάγια

Ερώτηση: Περιγράψτε το κάταγμα: εντόπιση, παρεκτόπιση, γωνίωση, συμμετοχή άρθρωσης.

Περιστατικό 8

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία άκρας χειρός · **Κλινικές πληροφορίες:** Άλγος στο χέρι μετά από πτώση.

Περιστατικό 8 · Ακτινογραφία άκρας χειρός

Ερώτηση: Υπάρχει κάταγμα σε αυτή την ακτινογραφία;

Περιστατικό 9

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία πυέλου AP / ισχίου · **Κλινικές πληροφορίες:** Ηλικιωμένος ασθενής· άλγος ισχίου μετά από πτώση, αδυναμία φόρτισης.

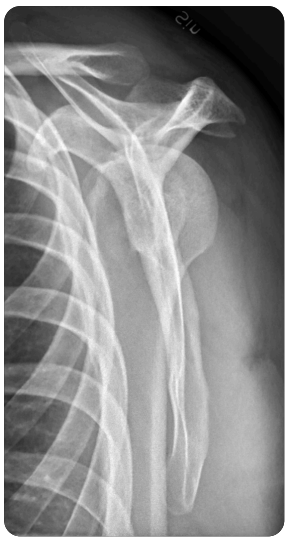
Περιστατικό 9 · Ακτινογραφία πυέλου AP / ισχίου

Ερώτηση: Περιγράψτε το κάταγμα και κάντε τη διάκριση ενδαρθρικού / εξωαρθρικού.

Περιστατικό 10

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία ώμου ΑΡ · **Κλινικές πληροφορίες:** Άλγος ώμου μετά από πτώση, αδυναμία κίνησης του άνω άκρου.



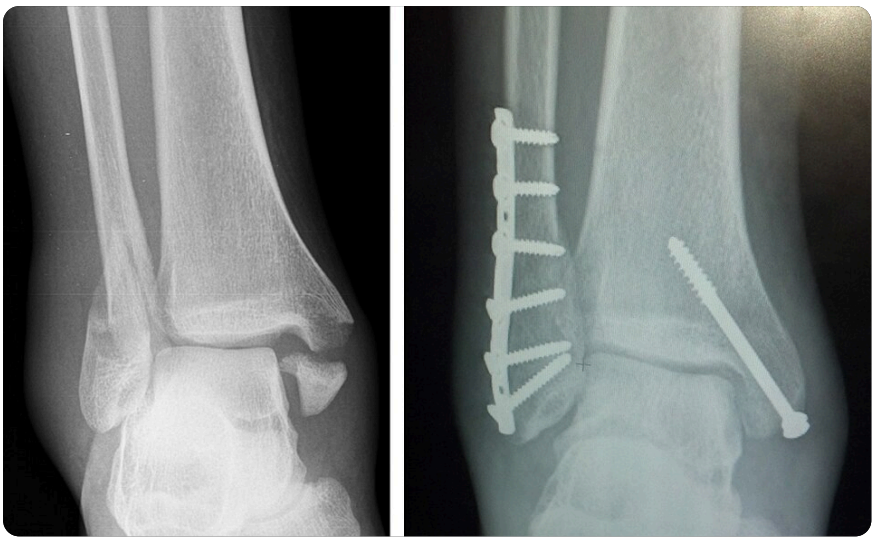
Περιστατικό 10 · Ακτινογραφία ώμου ΑΡ

Ερώτηση: Περιγράψτε τη σχέση της κεφαλής του βραχιονίου με την ωμογλήνη.

Περιστατικό 11

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφίες ποδοκνημικής AP, mortise και πλάγια · **Κλινικές πληροφορίες:** Άλγος και οίδημα μετά από διάστρεμμα.



Περιστατικό 11 · Ακτινογραφίες ποδοκνημικής AP, προβολή λαβίδας και πλάγια

Ερώτηση: Περιγράψτε το κάταγμα και εκτιμήστε τη σταθερότητα της άρθρωσης.

Περιστατικό 12

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία κνήμης (δύο προβολές) · **Κλινικές πληροφορίες:** Τροχαίο ατύχημα, παραμόρφωση του σκέλους.

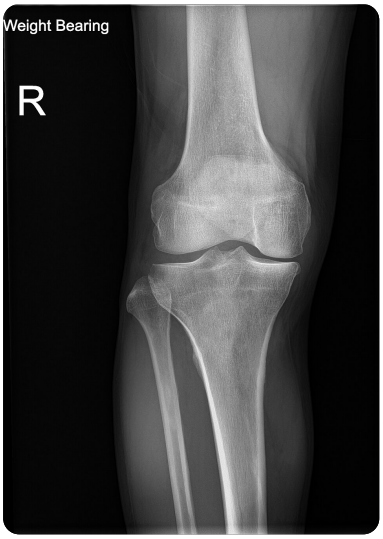
Περιστατικό 12 · Ακτινογραφία κνήμης (δύο προβολές)

Ερώτηση: Περιγράψτε το κάταγμα: θέση, τύπος, παρεκτόπιση.

Περιστατικό 13

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία γόνατος AP · **Κλινικές πληροφορίες:** Ηλικιωμένος ασθενής, χρόνιο άλγος γόνατος.



Περιστατικό 13 · Ακτινογραφία γόνατος AP

Ερώτηση: Καταγράψτε συστηματικά τα εκφυλιστικά ευρήματα.

Περιστατικό 14 ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία γόνατος · **Κλινικές πληροφορίες:** Διάστρεμμα γόνατος κατά την άθληση.

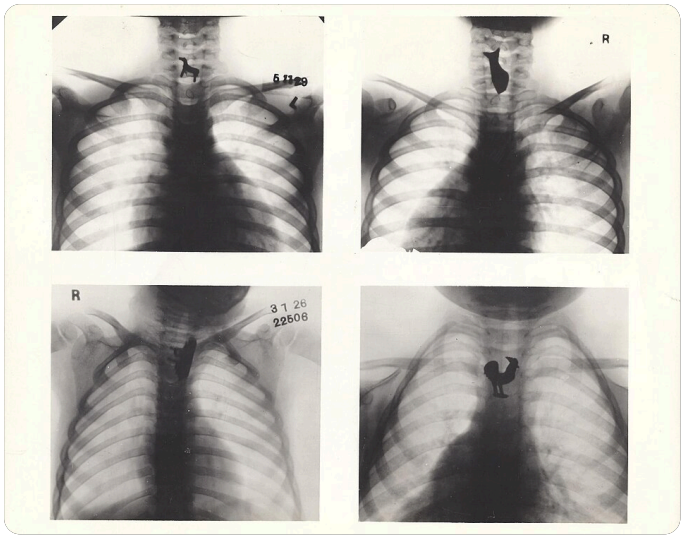
Περιστατικό 14 · Ακτινογραφία γόνατος

Ερώτηση: Υπάρχει παθολογία σε αυτή την ακτινογραφία;

Περιστατικό 15

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία τραχήλου και θώρακα · **Κλινικές πληροφορίες:** Παιδί· πιθανολογείται κατάποση νομίσματος.



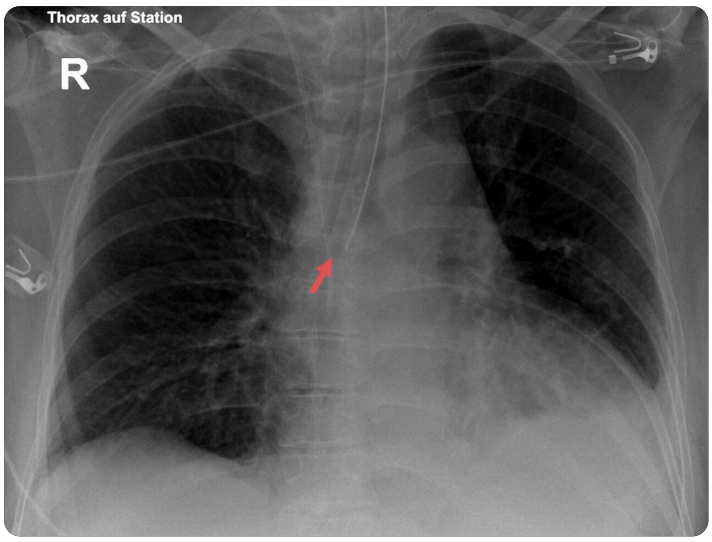
Περιστατικό 15 · Ακτινογραφία τραχήλου και θώρακα

Ερώτηση: Αναφέρετε τη θέση του ξένου σώματος και μέσα σε ποια δομή βρίσκεται.

Περιστατικό 16

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα AP στην κλίνη · **Κλινικές πληροφορίες:** ΜΕΘ· έλεγχος μετά από διασωλήνωση.



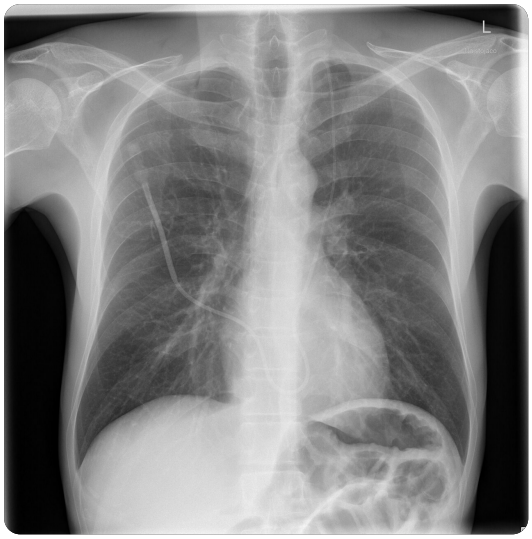
Περιστατικό 16 · Ακτινογραφία θώρακα AP στην κλίνη

Ερώτηση: Εκτιμήστε τη θέση του άκρου του ενδοτραχειακού σωλήνα.

Περιστατικό 17

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα AP · **Κλινικές πληροφορίες:** Έλεγχος μετά από τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα.



Περιστατικό 17 · Ακτινογραφία θώρακα AP

Ερώτηση: Περιγράψτε την πορεία και τη θέση του άκρου του καθετήρα· αναζητήστε επιπλοκές.

Περιστατικό 18

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Απλή ακτινογραφία ουροποιητικού (ΝΟΚ) · **Κλινικές πληροφορίες:** Οσφυϊκό άλγος και αιματουρία.

Περιστατικό 18 · Ακτινογραφία νεφρών-ουρητήρων-κύστης (ΝΟΚ)

Ερώτηση: Περιγράψτε τη σκίαση και αναφέρετε την πιθανή εντόπισή της.

Περιστατικό 19

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Απλή ακτινογραφία κοιλίας · **Κλινικές πληροφορίες:** Κοιλιακό άλγος.

Περιστατικό 19 · Ακτινογραφία κοιλίας

Ερώτηση: Υπάρχει παθολογία σε αυτή την ακτινογραφία;

Περιστατικό 20

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Απλή ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση · **Κλινικές πληροφορίες:** Προηγούμενη χειρουργική επέμβαση κοιλίας· έμετοι, αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων.

Περιστατικό 20 · Ακτινογραφία κοιλίας σε όρθια θέση

Ερώτηση: Περιγράψτε το πρότυπο των αερίων του εντέρου.

Περιστατικό 21

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Μακροχρόνιο ιστορικό καπνίσματος, απώλεια βάρους, αιμόπτυση.

Περιστατικό 21 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Ερώτηση: Περιγράψτε τη βλάβη και γράψτε σύσταση.

Περιστατικό 22

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Έφηβος· ασυμμετρία στην πλάτη.

Περιστατικό 22 · Ακτινογραφία ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης PA

Ερώτηση: Περιγράψτε το κύρτωμα· γράψτε τι πρέπει να μετρηθεί.

Περιστατικό 23

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Πυρετός και βήχας.

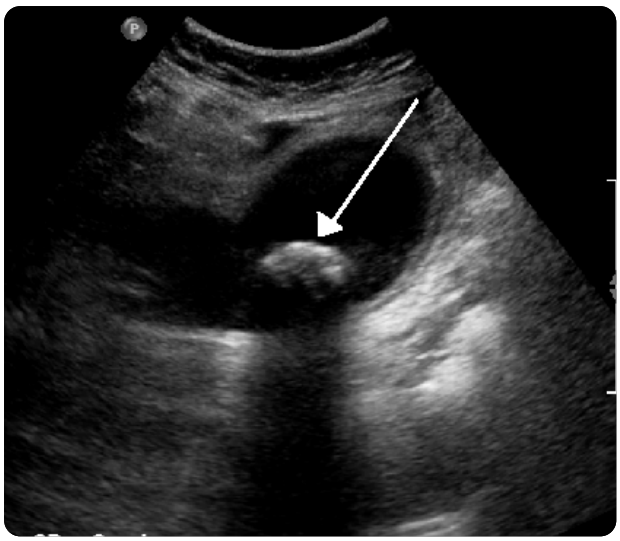
Περιστατικό 23 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Ερώτηση: Με ποιο σημείο προσδιορίσατε σε ποιον λοβό ανήκει η σκίαση;

Περιστατικό 24

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα κοιλίας (χοληδόχος κύστη) · **Κλινικές πληροφορίες:** Άλγος στο δεξιό άνω τεταρτημόριο μετά από λιπαρό γεύμα.



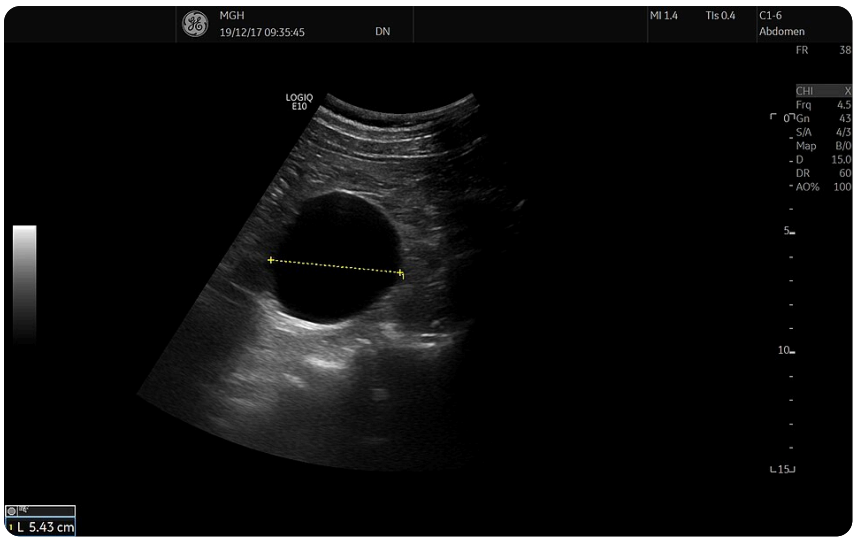
Περιστατικό 24 · Υπερηχογράφημα κοιλίας (χοληδόχος κύστη)

Ερώτηση: Περιγράψτε το εύρημα εντός της χοληδόχου κύστης.

Περιστατικό 25

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα νεφρών · **Κλινικές πληροφορίες:** Τυχαίο εύρημα σε υπερηχογράφημα που έγινε για άλλο λόγο.



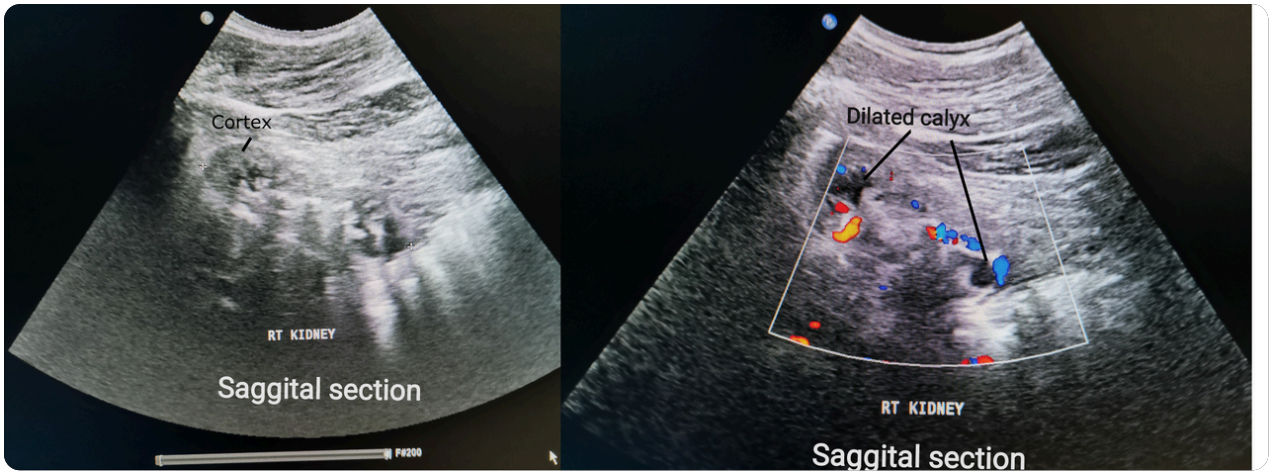
Περιστατικό 25 · Υπερηχογράφημα νεφρών

Ερώτηση: Περιγράψτε τη βλάβη και απαριθμήστε τα κριτήρια απλής κύστης.

Περιστατικό 26

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα νεφρών · **Κλινικές πληροφορίες:** Οσφυϊκό άλγος.



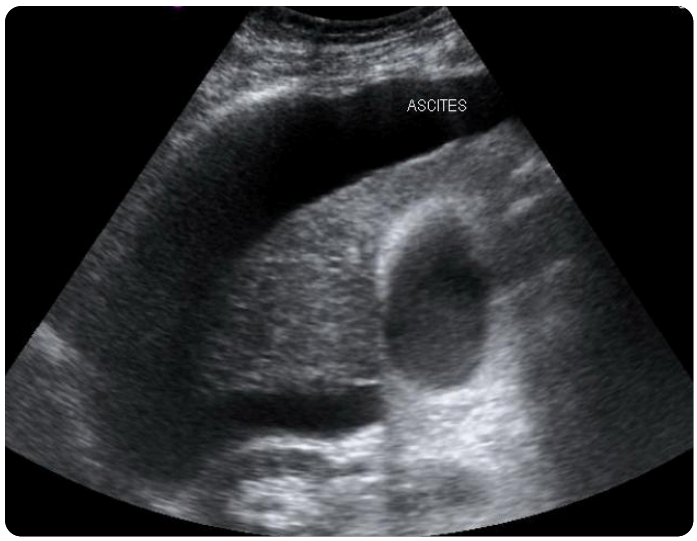
Περιστατικό 26 · Υπερηχογράφημα νεφρών

Ερώτηση: Περιγράψτε το αποχετευτικό σύστημα και ταξινομήστε τον βαθμό.

Περιστατικό 27

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα κοιλίας · **Κλινικές πληροφορίες:** Διόγκωση κοιλίας· ιστορικό χρόνιας ηπατοπάθειας.



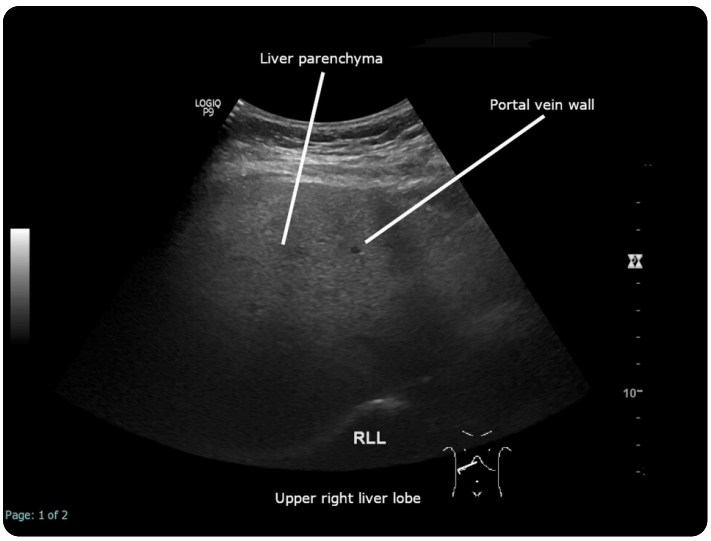
Περιστατικό 27 · Υπερηχογράφημα κοιλίας

Ερώτηση: Περιγράψτε το εύρημα· τι πρέπει να προσθέσετε στη γνωμάτευσή σας;

Περιστατικό 28

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα κοιλίας · **Κλινικές πληροφορίες:** Παχυσαρκία, αυξημένα ηπατικά ένζυμα.



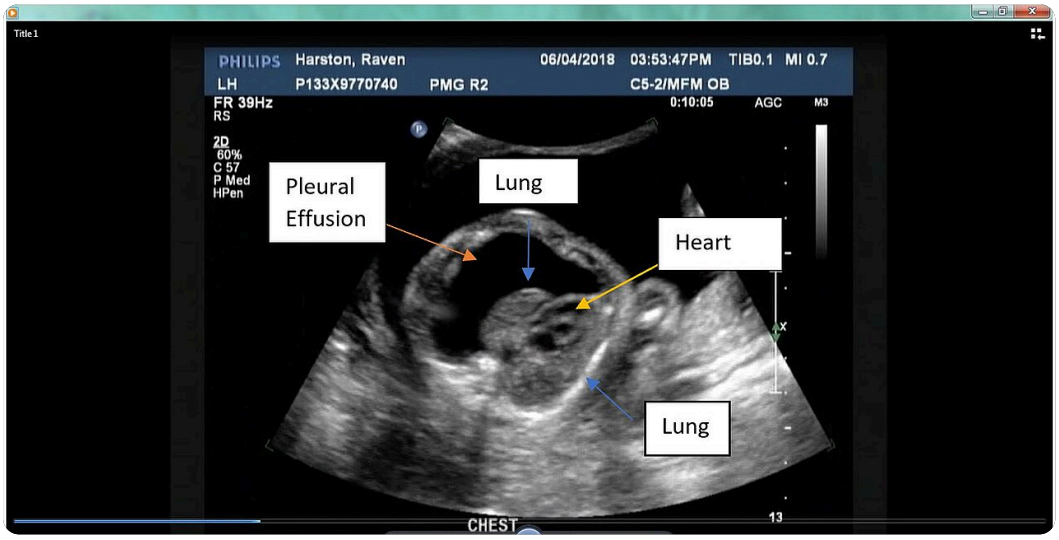
Περιστατικό 28 · Υπερηχογράφημα κοιλίας

Ερώτηση: Περιγράψτε την ηχογένεια του ήπατος.

Περιστατικό 29

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα θώρακα (POCUS) · **Κλινικές πληροφορίες:** Ασθενής ΜΕΘ· στην ακτινογραφία αμβλεία πλευροδιαφραγματική γωνία.



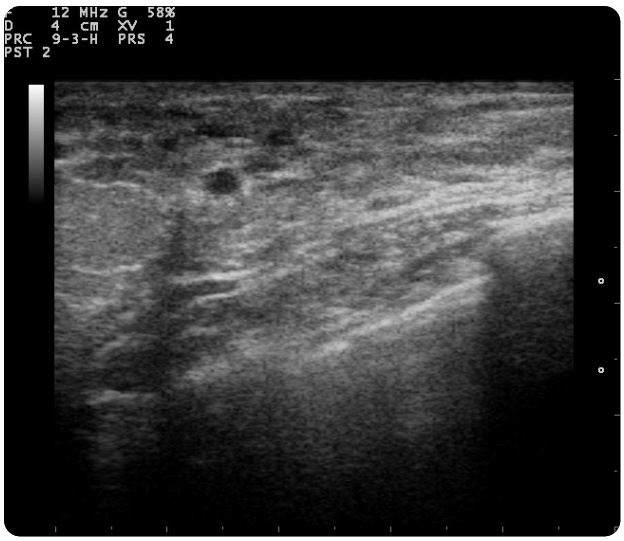
Περιστατικό 29 · Υπερηχογράφημα θώρακα (POCUS)

Ερώτηση: Περιγράψτε το εύρημα πάνω από το διάφραγμα.

Περιστατικό 30

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα μαστού · **Κλινικές πληροφορίες:** Ψηλαφητή μάζα που έγινε αντιληπτή από την ίδια.



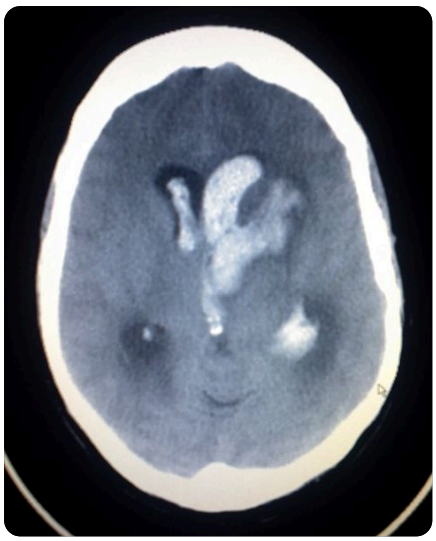
Περιστατικό 30 · Υπερηχογράφημα μαστού

Ερώτηση: Περιγράψτε τη βλάβη· είναι απλή κύστη;

Περιστατικό 31

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Ιστορικό υπέρτασης· αιφνίδια αδυναμία.



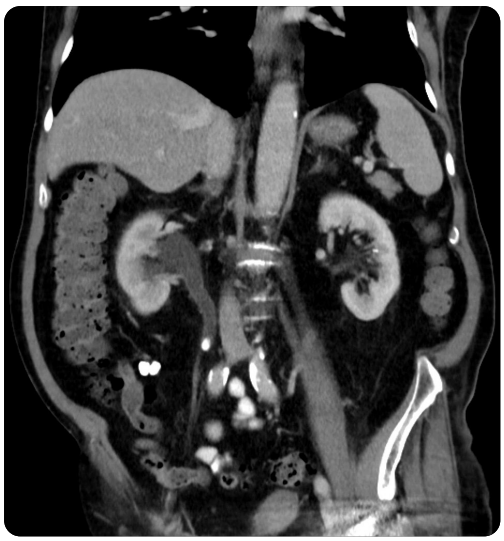
Περιστατικό 31 · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε τη βλάβη ως προς την πυκνότητα, την εντόπιση και το φαινόμενο μάζας.

Περιστατικό 32

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική χωρίς σκιαγραφικό (πρωτόκολλο λιθίασης) · **Κλινικές πληροφορίες:** Έντονο οσφυϊκό άλγος κολικοειδούς τύπου.



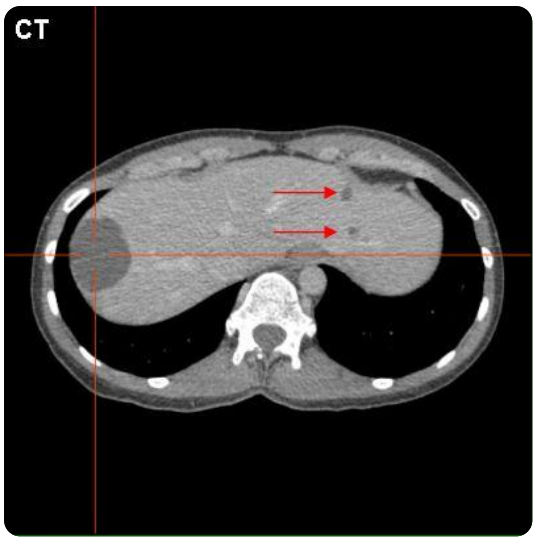
Περιστατικό 32 · Αξονική χωρίς σκιαγραφικό (πρωτόκολλο λιθίασης)

Ερώτηση: Περιγράψτε τον λίθο και τα δευτερογενή ευρήματα.

Περιστατικό 33

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Τυχαία ανευρεθείσα ηπατική βλάβη.



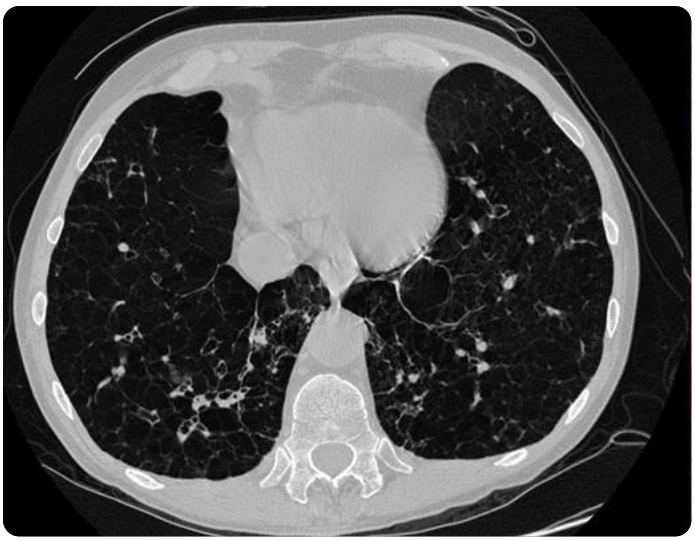
Περιστατικό 33 · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε τη βλάβη.

Περιστατικό 34

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική θώρακα, πνευμονικό παράθυρο · **Κλινικές πληροφορίες:** Μακροχρόνιο ιστορικό καπνίσματος, χρόνια δύσπνοια.



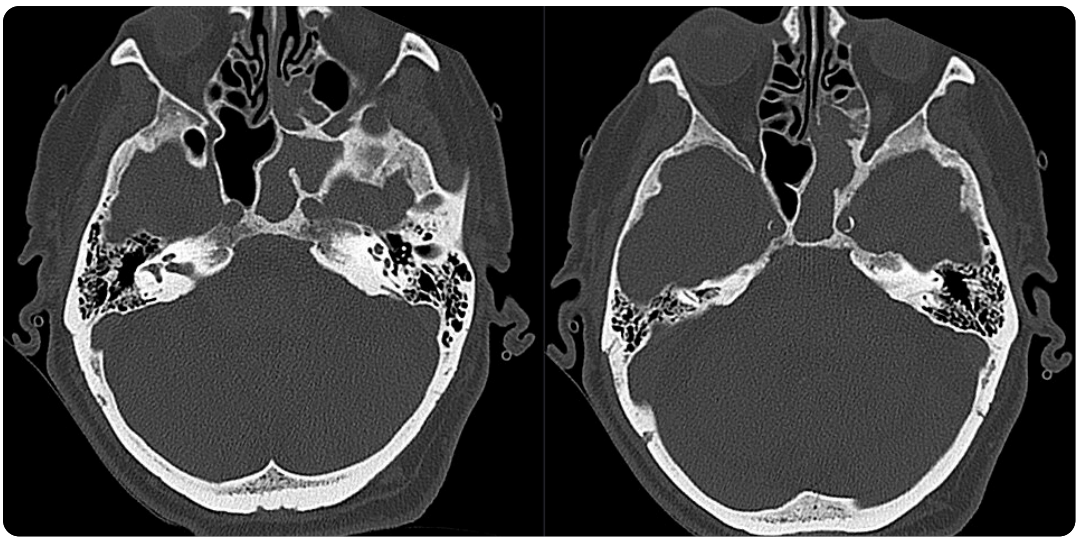
Περιστατικό 34 · Αξονική θώρακα, πνευμονικό παράθυρο

Ερώτηση: Περιγράψτε το εύρημα του παρεγχύματος.

Περιστατικό 35

ΑΡΧΑΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική παραρρινίων κόλπων · **Κλινικές πληροφορίες:** Ρινική συμφόρηση και άλγος προσώπου.



Περιστατικό 35 · Αξονική παραρρινίων κόλπων

Ερώτηση: Περιγράψτε τα ευρήματα των κόλπων.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 · ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κλειδί απαντήσεων — Αρχάριο

Περιστατικά 1–35. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε γράψει τη δική σας περιγραφή.

Περιστατικό 1

Πρότυπη περιγραφή: Τεχνικά επαρκής ακτινογραφία θώρακα PA, χωρίς σημαντική στροφή, με επαρκή εισπνοή. Το παρέγχυμα και των δύο πνευμόνων εμφανίζει φυσιολογικό αερισμό· δεν παρατηρήθηκαν πύκνωση, μάζα ή πνευμοθώρακας. Ο καρδιοθωρακικός δείκτης εντός φυσιολογικών ορίων, το μεσοθωράκιο στη μέση γραμμή. Οι πλευροδιαφραγματικές γωνίες ελεύθερες, τα περιγράμματα του διαφράγματος ομαλά· στις οστικές δομές δεν διαπιστώθηκε σημαντική παθολογία.

Διάγνωση: Φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα PA.

Το συχνότερο λάθος: Γνωματεύετε ως όζους τη σκιά της θηλής, τον μαζικό ιστό ή τις αποτιτανώσεις των πλευρικών χόνδρων· ή γράφετε «φυσιολογικό» χωρίς να κοιτάξετε τα τυφλά σημεία (κορυφές, πύλες, οπισθοκαρδιακή περιοχή, περιοχή κάτω από το διάφραγμα).

Περιστατικό 2

Πρότυπη περιγραφή: Στο αντίστοιχο ημιθωράκιο παρατηρείται λεπτή, σαφώς αφοριζόμενη γραμμή σπλαχνικού υπεζωκότα, περιφερικά της οποίας δεν διακρίνεται πνευμονική αγγείωση. Τα ευρήματα συνάδουν με πνευμοθώρακα. Η θέση του μεσοθωρακίου [εκτιμήθηκε: μετατόπιση ναι / όχι] όσον αφορά ευρήματα τάσης. Ενημερώθηκε ο κλινικός ιατρός.

Διάγνωση: Πνευμοθώρακας.

Το συχνότερο λάθος: Να εκλαμβάνεται το χείλος της ωμοπλάτης ή μια δερματική πτυχή ως υπεζωκοτική γραμμή. Η δερματική πτυχή συχνά εκτείνεται έξω από το θωρακικό τοίχωμα και πέρα από αυτήν η αγγειακή σκιαγράφηση συνεχίζεται.

Περιστατικό 3

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται ομοιογενής σκίαση που αμβλύνει την πλευροδιαφραγματική γωνία και επεκτείνεται προς τα πάνω κατά μήκος του πλάγιου θωρακικού τοιχώματος, με κοίλο άνω όριο (σχήμα μηνίσκου). Εντός της σκίασης δεν διακρίνεται αεροβρογχόγραμμα. Τα ευρήματα είναι συμβατά με πλευριτική συλλογή· το υποκείμενο παρέγχυμα δεν μπορεί να εκτιμηθεί πλήρως λόγω της συλλογής. Εφόσον χρειάζεται, συνιστάται εκτίμηση με υπερηχογράφημα.

Διάγνωση: Πλευριτική συλλογή.

Το συχνότερο λάθος: Περιγράφετε τη συλλογή ως πύκνωση (το σημείο του μηνίσκου και η απουσία αεροβρογχογράμματος τις διακρίνουν) ή γράφετε «φυσιολογικό» το παρέγχυμα που καλύπτει η συλλογή.

Περιστατικό 4

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται ομοιογενής περιοχή πύκνωσης που ακολουθεί τα όρια ενός λοβού, με όρια που οξύνονται κοντά στη μεσολόβιο σχισμή· εντός της διακρίνονται αεροβρογχογράμματα. Σαφές εύρημα απώλειας όγκου [δεν παρατηρήθηκε / παρατηρήθηκε]. Τα ευρήματα, σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, είναι συμβατά με λοβώδη πνευμονία· συνιστάται ακτινογραφία ελέγχου μετά τη θεραπεία για την τεκμηρίωση της υποχώρησης.

Διάγνωση: Λοβώδης πνευμονία (πύκνωση).

Το συχνότερο λάθος: Γράφετε ασαφώς, π.χ. «αύξηση πυκνότητας στο κάτω πεδίο», χωρίς να προσδιορίσετε την εντόπιση με το σημείο της σιλουέτας· δεν διακρίνετε την πύκνωση από την ατελεκτασία (στην ατελεκτασία υπάρχει απώλεια όγκου).

Περιστατικό 5

Πρότυπη περιγραφή: Στην PA ακτινογραφία ο καρδιοθωρακικός δείκτης (μέγιστη εγκάρσια διάμετρος της καρδιάς / μέγιστη εσωτερική διάμετρος του θώρακα) είναι μεγαλύτερος από 0,5· συνάδει με καρδιομεγαλία. Ευρήματα πνευμονικής φλεβικής συμφόρησης, διάμεσου οιδήματος και πλευριτικής συλλογής [δεν παρατηρούνται / παρατηρούνται].

Διάγνωση: Καρδιομεγαλία.

Το συχνότερο λάθος: Γνωματεύετε την καρδιά ως «μεγάλη» σε ακτινογραφία AP ή σε ύπτια θέση: στην προβολή AP η καρδιακή σκιά μεγεθύνεται και ο λόγος δεν είναι αξιόπιστος. Επίσης δεν αναφέρετε ότι η ακτινογραφία δεν μπορεί να διακρίνει την καρδιομεγαλία από το περικαρδιακό υγρό.

Περιστατικό 6

Πρότυπη περιγραφή: Κάτω από τον θόλο του διαφράγματος παρατηρείται ελεύθερος αέρας μηνοειδούς σχήματος· συμβατός με πνευμοπεριτόναιο. Το εύρημα είναι σημαντικό για διάτρηση κοίλου σπλάχνου· ανακοινώθηκε αμέσως στον θεράποντα ιατρό για επείγουσα χειρουργική εκτίμηση.

Διάγνωση: Πνευμοπεριτόναιο (ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα).

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε τα αέρια του θόλου του στομάχου ως ελεύθερο αέρα ή γνωματεύετε ως διάτρηση την παρεμβολή του παχέος εντέρου μεταξύ ήπατος και διαφράγματος (Chilaiditi): αναζητήστε κολικές κυψέλες. Δεν ρωτάτε για πρόσφατη χειρουργική επέμβαση κοιλίας.

Περιστατικό 7

Πρότυπη περιγραφή: Στη μετάφυση της άπω κερκίδας παρατηρείται καταγματική γραμμή που χαρακτηρίζεται από διακοπή της συνέχειας του φλοιού. Στην πλάγια ακτινογραφία [ραχιαία / παλαμιαία] γωνίωση και παρεκτόπιση του άπω τμήματος [ ]. Επέκταση της καταγματικής γραμμής στην κερκιδοκαρπική αρθρική επιφάνεια [ναι / όχι]· κάταγμα στυλοειδούς απόφυσης ωλένης [συνυπάρχει / δεν συνυπάρχει].

Διάγνωση: Κάταγμα άπω κερκίδας.

Το συχνότερο λάθος: Να γράφεται μόνο «υπάρχει κάταγμα» χωρίς να αναφέρονται η παρεκτόπιση, η γωνίωση και η συμμετοχή της άρθρωσης· να αρκείται κανείς σε μία προβολή.

Περιστατικό 8

Πρότυπη περιγραφή: Στην ακτινογραφία άκρας χειρός τα οστά έχουν φυσιολογική εικόνα· η συνέχεια του φλοιού διατηρείται, δεν παρατηρείται κάταγμα ή εξάρθρημα. Τα μεσάρθρια διαστήματα διατηρούνται. Δεν διακρίνεται σαφές οίδημα μαλακών μορίων ή ακτινοσκιερό ξένο σώμα. Αν η κλινική υποψία επιμένει, συνιστάται συμπληρωματική προβολή.

Διάγνωση: Φυσιολογική ακτινογραφία άκρας χειρός.

Το συχνότερο λάθος: Γνωματεύετε ως κάταγμα τα τροφοφόρα αγγειακά κανάλια, τα σησαμοειδή οστά ή τις ανοιχτές αυξητικές πλάκες στο παιδί.

Περιστατικό 9

Πρότυπη περιγραφή: Στο επίπεδο του αυχένα του μηριαίου παρατηρείται καταγματική γραμμή· συμβατή με ενδαρθρικό κάταγμα αυχένα μηριαίου. Βαθμός παρεκτόπισης [ ]. Έγινε σύγκριση με τη γραμμή Shenton και το αντίθετο ισχίο· επιπλέον κάταγμα στον πυελικό δακτύλιο [δεν παρατηρήθηκε / παρατηρήθηκε].

Διάγνωση: Κάταγμα αυχένα μηριαίου (ενδαρθρικό).

Το συχνότερο λάθος: Χάνετε το μη παρεκτοπισμένο κάταγμα αυχένα: συγκρίνετε τη συνέχεια των δοκίδων και το φλοιώδες περίγραμμα με την αντίθετη πλευρά· σε υποψία προτείνετε συμπληρωματική απεικόνιση.

Περιστατικό 10

Πρότυπη περιγραφή: Η κεφαλή του βραχιονίου δεν αρθρώνεται με την ωμογλήνη· συμβατό με γληνοβραχιόνιο εξάρθρημα. Η κατεύθυνση του εξαρθρήματος [πρόσθιο-κάτω / οπίσθιο] πρέπει να επιβεβαιωθεί με δεύτερη ορθογώνια προβολή (μασχαλιαία ή ωμοπλατιαία Y). Συνιστάται ακτινογραφία ελέγχου μετά την ανάταξη για συνοδό κάταγμα κεφαλής βραχιονίου ή χείλους ωμογλήνης.

Διάγνωση: Εξάρθρημα ώμου (γληνοβραχιόνιο).

Το συχνότερο λάθος: Να βασίζεστε σε μία μόνο ακτινογραφία AP: το οπίσθιο εξάρθρημα διαφεύγει εύκολα στην AP. Χωρίς δεύτερη προβολή δεν πρέπει να γράφεται «φυσιολογική».

Περιστατικό 11

Πρότυπη περιγραφή: Στο επίπεδο των σφυρών παρατηρείται καταγματική γραμμή [ποιο / ποια σφυρά]. Εκτιμήθηκε η συμμετρία του διαστήματος της ποδοκνημικής λαβίδας· μετατόπιση του αστραγάλου [δεν παρατηρήθηκε / παρατηρήθηκε]. Συνυπάρχει οίδημα μαλακών μορίων.

Διάγνωση: Κάταγμα ποδοκνημικής (σφυρών).

Το συχνότερο λάθος: Να εστιάζεται η προσοχή σε ένα μόνο κάταγμα και να διαφεύγει το κάταγμα του δεύτερου σφυρού ή η διεύρυνση της ταλοκνημιαίας λαβίδας· να μη διερευνάται η κεντρική περόνη όταν υπάρχει κάκωση στην έσω πλευρά.

Περιστατικό 12

Πρότυπη περιγραφή: Στην κνήμη παρατηρείται καταγματική γραμμή· τύπος κατάγματος [εγκάρσιο / λοξό / σπειροειδές / συντριπτικό], μεταξύ των τμημάτων υπάρχει [παρεκτόπιση, γωνίωση, βράχυνση]. Εκτιμήθηκαν η περόνη και οι αρθρώσεις του γόνατος και της ποδοκνημικής· συνοδό κάταγμα περόνης [ναι / όχι].

Διάγνωση: Κάταγμα κνήμης.

Το συχνότερο λάθος: Δεν αναφέρετε το κάταγμα της περόνης ή την επέκταση του κατάγματος στην αρθρική επιφάνεια· σε κάταγμα μακρού οστού δεν ζητάτε ακτινογραφία που να περιλαμβάνει και τις δύο αρθρώσεις.

Περιστατικό 13

Πρότυπη περιγραφή: Στην άρθρωση του γόνατος παρατηρούνται στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος [ποιο διαμέρισμα], οστεόφυτα στα όρια της άρθρωσης και υποχόνδρια σκλήρυνση· συμβατά με οστεοαρθρίτιδα. Δεν παρατηρείται κάταγμα ή λυτική βλάβη.

Διάγνωση: Οστεοαρθρίτιδα γόνατος.

Το συχνότερο λάθος: Να γράφεται μόνο «εκφυλιστικές αλλοιώσεις» χωρίς να αναφέρονται το προσβεβλημένο διαμέρισμα και τα ευρήματα (στένωση, οστεόφυτα, σκλήρυνση, υποχόνδριες κύστεις)· να επιχειρείται εκτίμηση του αρθρικού διαστήματος σε ακτινογραφία ύπτιας θέσης (προτιμάται λήψη με φόρτιση).

Περιστατικό 14

Πρότυπη περιγραφή: Στην ακτινογραφία γόνατος τα οστά είναι φυσιολογικά· δεν παρατηρείται κάταγμα, εξάρθρημα ή λυτική/σκληρυντική βλάβη. Τα μεσάρθρια διαστήματα διατηρούνται. Η υπεπιγονατιδική συλλογή [εκτιμήθηκε] στην πλάγια ακτινογραφία. Η φυσιολογική ακτινογραφία δεν αποκλείει κάκωση συνδέσμων και μηνίσκων.

Διάγνωση: Φυσιολογική ακτινογραφία γόνατος.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε τη fabella ή τη διμερή επιγονατίδα ως κάταγμα· δεν αναφέρετε ότι η φυσιολογική ακτινογραφία δεν αποκλείει κάκωση μαλακών μορίων.

Περιστατικό 15

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται ακτινοσκιερό, στρογγυλό ξένο σώμα· η εντόπισή του συνάδει με [οισοφάγο / τραχεία / στόμαχο]. Η εντόπιση πρέπει να επιβεβαιωθεί με πλάγια ακτινογραφία. Εικόνα διπλού δακτυλίου στο χείλος του σώματος [δεν παρατηρείται / παρατηρείται]· πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μπαταρίας τύπου κουμπιού.

Διάγνωση: Κατάποση ξένου σώματος (νόμισμα).

Το συχνότερο λάθος: Να γίνεται εντόπιση με μία μόνο προβολή και να μη διακρίνεται η μπαταρία τύπου κουμπιού (εικόνα διπλού δακτυλίου / σκαλοπατιού) από το νόμισμα: η μπαταρία τύπου κουμπιού απαιτεί επείγουσα αφαίρεση.

Περιστατικό 16

Πρότυπη περιγραφή: Το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα παρατηρείται εντός της τραχείας, [ ] cm πάνω από την τρόπιδα· θέση [κατάλληλη / συνιστάται διόρθωση]. Οι πνεύμονες εκτιμήθηκαν για πνευμοθώρακα και ατελεκτασία· λοιποί σωλήνες και καθετήρες [ ].

Διάγνωση: Ενδοτραχειακός σωλήνας — εκτίμηση θέσης.

Το συχνότερο λάθος: Να μη μετριέται το άκρο του σωλήνα σε σχέση με την τρόπιδα και να διαφεύγει σωλήνας που έχει προωθηθεί σε κύριο βρόγχο· να ξεχνιέται ο έλεγχος του υπόλοιπου πνεύμονα στη γνωμάτευση του σωλήνα.

Περιστατικό 17

Πρότυπη περιγραφή: Κεντρικός φλεβικός καθετήρας έχει τοποθετηθεί μέσω [σφαγίτιδας / υποκλειδίου] και το άκρο του παρατηρείται στο επίπεδο [άνω κοίλης φλέβας / κοιλοκολπικής συμβολής / δεξιού κόλπου]. Ευρήματα υπέρ πνευμοθώρακα και αιμοθώρακα [δεν παρατηρούνται / παρατηρούνται].

Διάγνωση: Κεντρικός φλεβικός καθετήρας — έλεγχος θέσης.

Το συχνότερο λάθος: Να ελέγχεται μόνο το άκρο του καθετήρα χωρίς αναζήτηση πνευμοθώρακα· να μην αναγνωρίζεται η απόκλιση του καθετήρα σε μη αναμενόμενη φλέβα ή στο αρτηριακό σύστημα.

Περιστατικό 18

Πρότυπη περιγραφή: Στην προβολή της νεφρικής σκιάς παρατηρείται ακτινοσκιερή σκίαση με σαφή όρια· μπορεί να είναι συμβατή με λίθο του ουροποιητικού. Επιπλέον σκίαση στην πορεία του ουρητήρα και στην προβολή της ουροδόχου κύστης [ ]. Για ακριβή εντόπιση και εκτίμηση απόφραξης συνιστάται υπερηχογράφημα ή αξονική χωρίς σκιαγραφικό.

Διάγνωση: Ακτινοσκιερός λίθος νεφρού.

Το συχνότερο λάθος: Να εκλαμβάνονται οι φλεβόλιθοι της πυέλου (στρογγυλοί, συχνά με κεντρική διαύγαση) ως λίθοι ουρητήρα· να γνωματεύεται ως λίθος το περιεχόμενο του εντέρου ή η επιπροβολή οστών.

Περιστατικό 19

Πρότυπη περιγραφή: Η κατανομή των αερίων του εντέρου έχει μη αποφρακτικό πρότυπο· δεν παρατηρείται διάταση λεπτού εντέρου ή επίπεδα αέρα-υγρού. Δεν διακρίνεται παθολογική αποτιτάνωση ή ακτινοσκιερός λίθος. Τα οστά είναι φυσιολογικά. Για την εκτίμηση ελεύθερου αέρα κάτω από το διάφραγμα απαιτείται ακτινογραφία σε όρθια θέση.

Διάγνωση: Φυσιολογική απλή ακτινογραφία κοιλίας.

Το συχνότερο λάθος: Ερμηνεύετε τα φυσιολογικά αέρια και κόπρανα του παχέος εντέρου ως «απόφραξη» ή «δυσκοιλιότητα»· δεν αναφέρετε ότι η φυσιολογική ακτινογραφία δεν αποκλείει διαγνώσεις όπως η σκωληκοειδίτιδα.

Περιστατικό 20

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρούνται κεντρικά εντοπιζόμενες, διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου και πολλαπλά υδραερικά επίπεδα· αέρας στο παχύ έντερο [μειωμένος / δεν παρατηρείται]. Τα ευρήματα συνάδουν με μηχανική απόφραξη λεπτού εντέρου. Για εκτίμηση του σημείου μετάπτωσης και ισχαιμίας συνιστάται αξονική με σκιαγραφικό.

Διάγνωση: Απόφραξη λεπτού εντέρου.

Το συχνότερο λάθος: Να μη διακρίνεται το λεπτό έντερο (κεντρικά, οι κυκλοτερείς πτυχές διασχίζουν όλο το εύρος του τοιχώματος) από το παχύ έντερο (περιφερικά, οι πτυχές των κολικών κυψελών δεν διασχίζουν πλήρως το τοίχωμα)· να μην εκτιμάται ο αέρας του παχέος εντέρου για διάκριση από τον παραλυτικό ειλεό.

Περιστατικό 21

Πρότυπη περιγραφή: Στο πνευμονικό παρέγχυμα παρατηρείται μάζα πυκνότητας μαλακών μορίων με [λεία / λοβωτά / ασαφή] όρια. Διεύρυνση πυλών ή μεσοθωρακίου, πλευριτική συλλογή και διάβρωση παρακείμενων οστών [ ]. Για την εκτίμηση κακοήθειας συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση με αξονική θώρακα με σκιαγραφικό.

Διάγνωση: Μάζα πνεύμονα (υποψία κακοήθειας).

Το συχνότερο λάθος: Να σταματά η αναζήτηση μόλις βρεθεί η πρώτη βλάβη και να διαφεύγει η δεύτερη (satisfaction of search)· να μη γίνεται σύγκριση με προηγούμενη ακτινογραφία.

Περιστατικό 22

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται πλάγια κύρτωση της σπονδυλικής στήλης· το κυρτό της καμπύλης κοιτά προς τα [ ] και η κορυφή της βρίσκεται στο επίπεδο [ ]. Η γωνία Cobb μετρήθηκε στους πλέον κεκλιμένους άνω και κάτω τελικούς σπονδύλους και βρέθηκε [ ]°. Ανωμαλία σπονδύλων (ημισπόνδυλος κ.λπ.) [δεν παρατηρείται / παρατηρείται].

Διάγνωση: Σκολίωση.

Το συχνότερο λάθος: Μετράτε τη γωνία Cobb από λάθος ακραίους σπονδύλους· δεν αναφέρετε την κατεύθυνση του κυρτού, την κορυφή και τις ανωμαλίες των σπονδύλων.

Περιστατικό 23

Πρότυπη περιγραφή: Στο άνω πνευμονικό πεδίο παρατηρείται ομοιογενής πύκνωση με όρια που οξύνονται πλησίον της μεσολοβίου σχισμής· εντός της διακρίνεται αεροβρογχόγραμμα. Τα ευρήματα συνάδουν με πνευμονία άνω λοβού. Συνιστάται ακτινογραφία ελέγχου μετά τη θεραπεία.

Διάγνωση: Πνευμονία άνω λοβού.

Το συχνότερο λάθος: Να μη διακρίνεται η σκίαση του άνω λοβού από πυλαία μάζα ή κορυφαία υπεζωκοτική πάχυνση· να μη συστήνεται ακτινογραφία ελέγχου σε ενήλικα για αποκλεισμό υποκείμενης κεντρικής αποφρακτικής βλάβης.

Περιστατικό 24

Πρότυπη περιγραφή: Στον αυλό της χοληδόχου κύστης παρατηρούνται ηχογενείς εστίες με οπίσθια ακουστική σκιά, που μετακινούνται με την αλλαγή θέσης [εκτιμήθηκε η κινητικότητα]· συνάδει με χολολιθίαση. Πάχος τοιχώματος κύστης [ ] mm, περιχολοκυστικό υγρό [όχι / ναι]· διάμετρος χοληδόχου πόρου [ ] mm.

Διάγνωση: Χολολιθίαση (λίθοι χοληδόχου κύστης).

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε τον πολύποδα που δεν δίνει ακουστική σκιά και δεν μετακινείται ως λίθο· δεν γνωματεύετε το πάχος του τοιχώματος της χοληδόχου κύστης και τη διάμετρο του χοληδόχου πόρου.

Περιστατικό 25

Πρότυπη περιγραφή: Στον νεφρό παρατηρείται άνηχη κυστική βλάβη με λεπτό και λείο τοίχωμα, με οπίσθια ακουστική ενίσχυση, χωρίς διαφραγμάτια, αποτιτανώσεις ή συμπαγές στοιχείο· συμβατή με απλή φλοιώδη κύστη.

Διάγνωση: Απλή νεφρική κύστη.

Το συχνότερο λάθος: Λέτε «απλή κύστη» χωρίς να εκτιμήσετε τοίχωμα, διαφραγμάτια, αποτιτάνωση και συμπαγές στοιχείο· σε επιπλεγμένη εικόνα δεν προτείνετε αξονική ή μαγνητική.

Περιστατικό 26

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται διάταση του νεφρικού πυελοκαλυκικού συστήματος· συμβατή με [ήπια / μέτρια / σοβαρή] υδρονέφρωση. Πάχος παρεγχύματος [διατηρημένο / λεπτυσμένο]. Διερευνήθηκαν ο εγγύς ουρητήρας και το πιθανό αίτιο απόφραξης (λίθος)· εκτιμήθηκε η ουροδόχος κύστη.

Διάγνωση: Υδρονέφρωση.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε την εξωνεφρική πύελο ή τις παραπυελικές κύστεις ως υδρονέφρωση (ελέγξτε αν οι κάλυκες είναι διατεταμένοι και αν επικοινωνούν μεταξύ τους)· δεν επανεκτιμάτε το εύρημα μετά την ούρηση όταν η ουροδόχος κύστη είναι πολύ γεμάτη.

Περιστατικό 27

Πρότυπη περιγραφή: Στην περιηπατική περιοχή, μεταξύ των εντερικών ελίκων και στην πύελο παρατηρείται ελεύθερο άνηχο υγρό εντός της κοιλίας· συμβατό με ασκίτη. Διαφραγμάτια ή ηχογενή σωματίδια εντός του υγρού [δεν παρατηρήθηκαν / παρατηρήθηκαν]. Το περίγραμμα και το παρέγχυμα του ήπατος εκτιμήθηκαν χωριστά.

Διάγνωση: Ασκίτης.

Το συχνότερο λάθος: Να μην αναφέρεται η ποσότητα και ο χαρακτήρας του υγρού (άνηχο / με διαφραγμάτια / με σωματίδια)· να μη σημειώνεται ο κατάλληλος θύλακος όταν σχεδιάζεται παρακέντηση.

Περιστατικό 28

Πρότυπη περιγραφή: Η ηχογένεια του ηπατικού παρεγχύματος είναι διάχυτα αυξημένη σε σχέση με τον φλοιό του νεφρού· παρατηρείται οπίσθια εξασθένηση του ήχου στο βαθύ παρέγχυμα και στο περίγραμμα του διαφράγματος. Τα ευρήματα είναι συμβατά με [ήπια / μέτρια / σοβαρή] ηπατική στεάτωση. Εστιακή βλάβη [δεν παρατηρήθηκε / παρατηρήθηκε].

Διάγνωση: Ηπατική στεάτωση (λιπώδης διήθηση ήπατος).

Το συχνότερο λάθος: Γράφετε την ηχογένεια χωρίς όργανο σύγκρισης (φλοιός νεφρού)· εκλαμβάνετε την εστιακή λιπώδη διήθηση ή τις περιοχές που έχουν διαφυλαχθεί από λίπος ως μάζα.

Περιστατικό 29

Πρότυπη περιγραφή: Πάνω από το διάφραγμα παρατηρείται άνηχο πλευριτικό υγρό· εντός του υγρού [διαφραγμάτια / σωματίδια / επιπλέων ατελεκτατικός πνεύμονας] [ ]. Τα ευρήματα είναι συμβατά με πλευριτική συλλογή.

Διάγνωση: Πλευριτική συλλογή.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε τον ασκίτη ή τον σπλήνα/ήπαρ ως συλλογή χωρίς να αναγνωρίσετε το διάφραγμα· δεν γνωματεύετε τα διαφραγμάτια και την ηχογένεια (πιθανότητα εξιδρώματος).

Περιστατικό 30

Πρότυπη περιγραφή: Στον μαζικό ιστό παρατηρείται ωοειδής, άνηχη βλάβη με σαφή όρια, με οπίσθια ακουστική ενίσχυση, χωρίς συμπαγές στοιχείο· συμβατή με απλή κύστη (BI-RADS 2).

Διάγνωση: Απλή κύστη μαστού.

Το συχνότερο λάθος: Να ταξινομείται μια επιπλεγμένη κύστη με εσωτερικές ηχώ ή μια συμπαγής βλάβη ως απλή κύστη· να μην εκτιμάται η βλάβη σε δύο επίπεδα και με Doppler.

Περιστατικό 31

Πρότυπη περιγραφή: Στο εγκεφαλικό παρέγχυμα παρατηρείται υπέρπυκνο ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα με εντόπιση [ ], συμβατό με οξεία αιμορραγία, και πέριξ υπόπυκνο οίδημα. Φαινόμενο μάζας και μετατόπιση μέσης γραμμής [ ] mm· επέκταση στις κοιλίες [ναι / όχι], υδροκέφαλος [ναι / όχι]. Τα ευρήματα ανακοινώθηκαν επειγόντως στον θεράποντα ιατρό.

Διάγνωση: Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία.

Το συχνότερο λάθος: Να μην αναγράφονται συνοδά ευρήματα όπως η διάνοιξη στις κοιλίες, ο εγκολεασμός και ο υδροκέφαλος· να μη συστήνεται αξονική αγγειογραφία ή μαγνητική για το υποκείμενο αίτιο (όγκος, αγγειακή δυσπλασία) σε άτυπη εντόπιση.

Περιστατικό 32

Πρότυπη περιγραφή: Στην πορεία του ουρητήρα παρατηρείται υπέρπυκνος λίθος· μέγεθος [ ] mm, επίπεδο [ ]. Κεντρικότερα, διάταση του ουρητήρα και του αποχετευτικού συστήματος και θόλωση του περινεφρικού λίπους [συνυπάρχουν / δεν συνυπάρχουν].

Διάγνωση: Λίθος ουρητήρα.

Το συχνότερο λάθος: Να εκλαμβάνονται οι φλεβόλιθοι της πυέλου ως λίθοι ουρητήρα: ακολουθώντας τις τομές, επιβεβαιώστε ότι η σκίαση βρίσκεται μέσα στον ουρητήρα (δακτύλιος μαλακών μορίων γύρω από τον λίθο· στον φλεβόλιθο εικόνα «ουράς κομήτη»).

Περιστατικό 33

Πρότυπη περιγραφή: Στο ήπαρ παρατηρείται ομοιογενής βλάβη με σαφή όρια, πυκνότητας υγρού, χωρίς πρόσληψη σκιαγραφικού και χωρίς διακριτό τοίχωμα· συμβατή με απλή κύστη.

Διάγνωση: Απλή ηπατική κύστη.

Το συχνότερο λάθος: Μετράτε λάθος την πυκνότητα σε μικρές βλάβες λόγω φαινομένου μερικού όγκου· ερμηνεύετε την πρόσληψη σκιαγραφικού χωρίς σύγκριση με την ακολουθία χωρίς σκιαγραφικό.

Περιστατικό 34

Πρότυπη περιγραφή: Στο πνευμονικό παρέγχυμα παρατηρούνται περιοχές χαμηλής πυκνότητας χωρίς διακριτό τοίχωμα· συμβατές με εμφύσημα. Αναφέρονται η κατανομή [κεντρολοβιακή / πανλοβιακή / παραδιαφραγματική] και η έκτασή τους. Όζος ή μάζα [δεν παρατηρήθηκε / παρατηρήθηκε].

Διάγνωση: Εμφύσημα.

Το συχνότερο λάθος: Δεν διακρίνετε το εμφύσημα (χωρίς τοίχωμα) από τις κύστεις και την εικόνα κηρήθρας (παχύ τοίχωμα, υποϋπεζωκοτικά, σε σειρές)· παραλείπετε την αναζήτηση όζων σε ασθενή με εμφύσημα.

Περιστατικό 35

Πρότυπη περιγραφή: Στους παραρρινίους κόλπους παρατηρούνται πάχυνση του βλεννογόνου και [υδραερικό επίπεδο]. Εκτιμήθηκε η βατότητα του οστεομεατικού συμπλέγματος. Ευρήματα υπέρ διάβρωσης των οστέινων τοιχωμάτων ή κογχικής / ενδοκράνιας επέκτασης [δεν παρατηρούνται / παρατηρούνται].

Διάγνωση: Φλεγμονώδης νόσος παραρρινίων κόλπων (ευρήματα συμβατά με ρινοκολπίτιδα).

Το συχνότερο λάθος: Γνωματεύετε την ήπια βλεννογονική πάχυνση από μόνη της ως «ιγμορίτιδα»: η ιγμορίτιδα είναι κλινική διάγνωση και το εύρημα της αξονικής ερμηνεύεται μαζί με την κλινική εικόνα. Δεν ελέγχετε για επιπλοκές στους οφθαλμικούς κόγχους και στα οστά.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

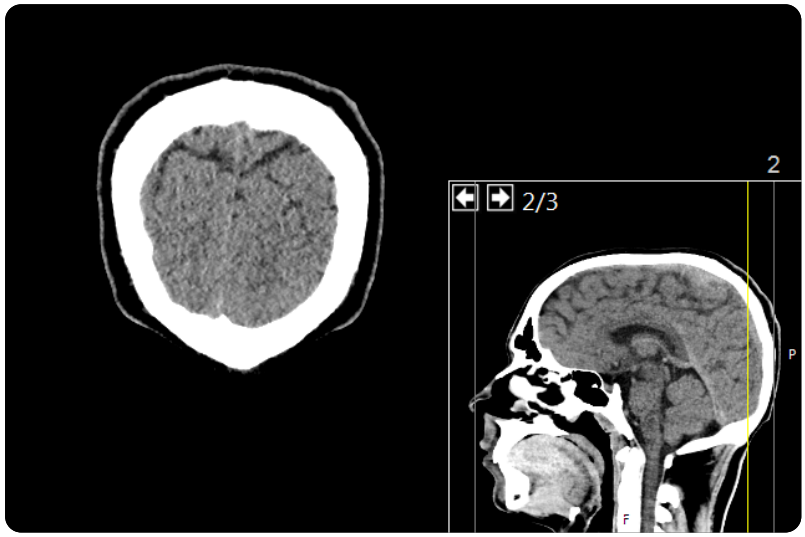
Μέτριο

Περιστατικά 36–70. Επείγουσες καταστάσεις της εφημερίας και λεπτότερες διακρίσεις. Στόχος: σωστός όρος και σωστός βαθμός επείγοντος.

Περιστατικό 36

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Κεφαλαλγία· φυσιολογική νευρολογική εξέταση.



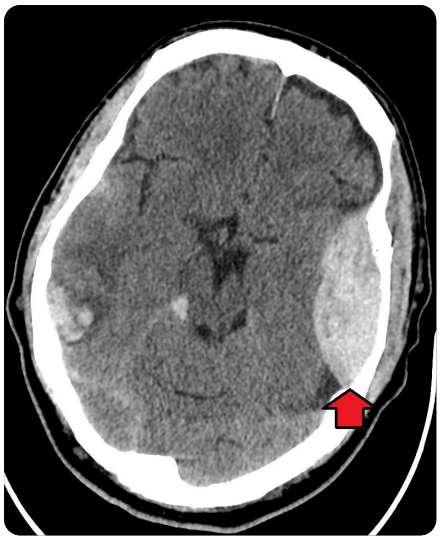
Περιστατικό 36 · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

Ερώτηση: Υπάρχει παθολογία σε αυτή την αξονική;

Περιστατικό 37

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Κρανιοεγκεφαλική κάκωση· σύντομη απώλεια συνείδησης, ανάκαμψη, στη συνέχεια επιδείνωση του επιπέδου συνείδησης.



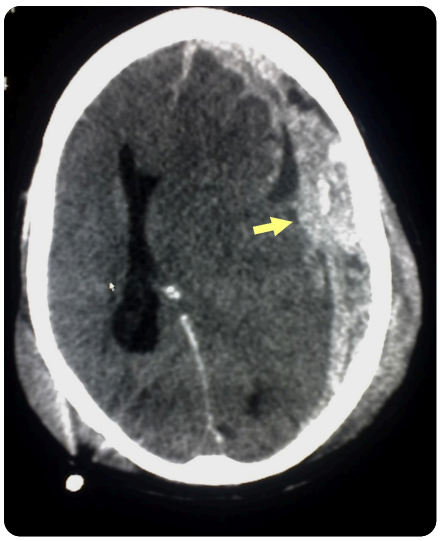
Περιστατικό 37 · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε την εξωαξονική συλλογή και προσδιορίστε τον τύπο της.

Περιστατικό 38

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Ηλικιωμένος ασθενής υπό αντιπηκτική αγωγή· πτώση.



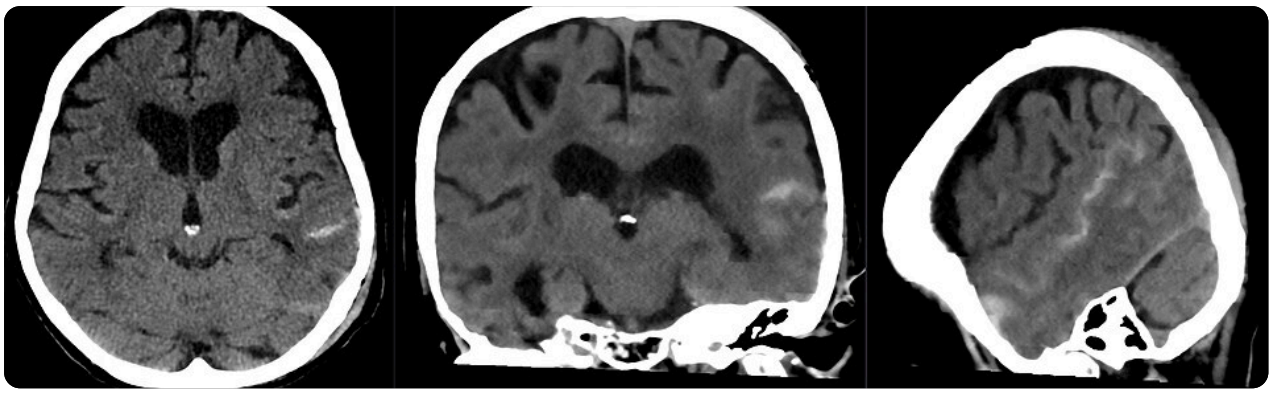
Περιστατικό 38 · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε τη συλλογή και προσδιορίστε το στάδιό της.

Περιστατικό 39

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** «Ο χειρότερος πονοκέφαλος της ζωής μου», αιφνίδια έναρξη.



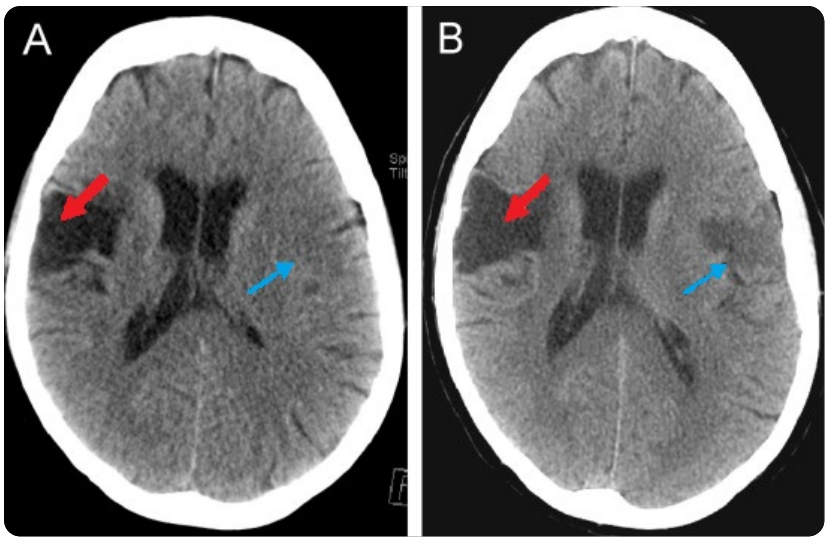
Περιστατικό 39 · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε την κατανομή της αιμορραγίας.

Περιστατικό 40

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Ημιπάρεση οξείας έναρξης· η αξονική έγινε ώρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.



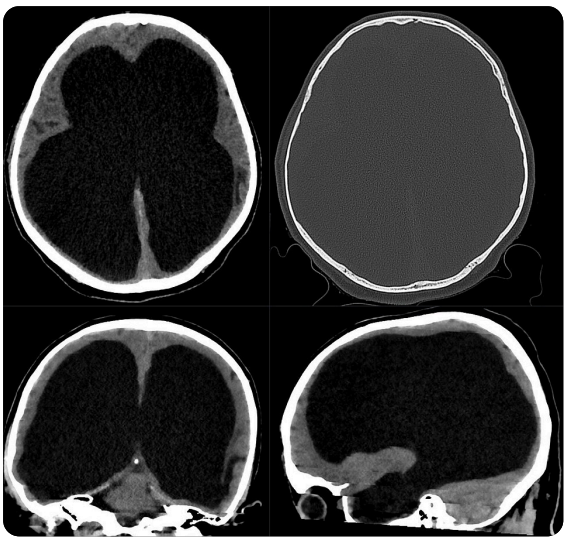
Περιστατικό 40 · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε την πυκνότητα του παρεγχύματος και προσδιορίστε την αγγειακή περιοχή.

Περιστατικό 41

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Κεφαλαλγία, ναυτία, διαταραχή βάδισης.



Περιστατικό 41 · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε το κοιλιακό σύστημα· σκεφτείτε το επίπεδο της απόφραξης.

Περιστατικό 42

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική εγκεφάλου · **Κλινικές πληροφορίες:** Πρωτοεμφανιζόμενη επιληπτική κρίση.

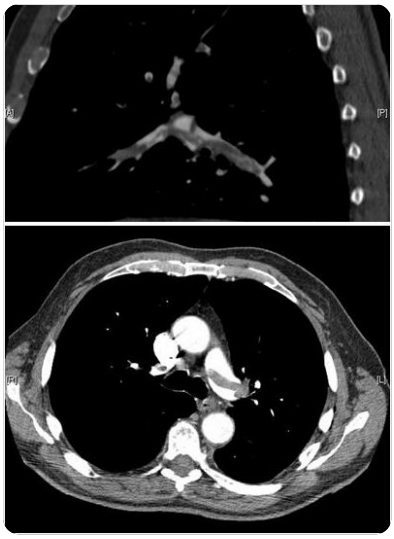
Περιστατικό 42 · Αξονική εγκεφάλου

Ερώτηση: Περιγράψτε τη βλάβη και την περιοχή γύρω της.

Περιστατικό 43

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική πνευμονική αγγειογραφία · **Κλινικές πληροφορίες:** Αιφνίδια δύσπνοια, ταχυκαρδία· πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.



Περιστατικό 43 · Αξονική πνευμονική αγγειογραφία

Ερώτηση: Περιγράψτε το έλλειμμα πλήρωσης και εκτιμήστε το φορτίο της δεξιάς καρδιάς.

Περιστατικό 44

ΜΕΤΡΙΟ

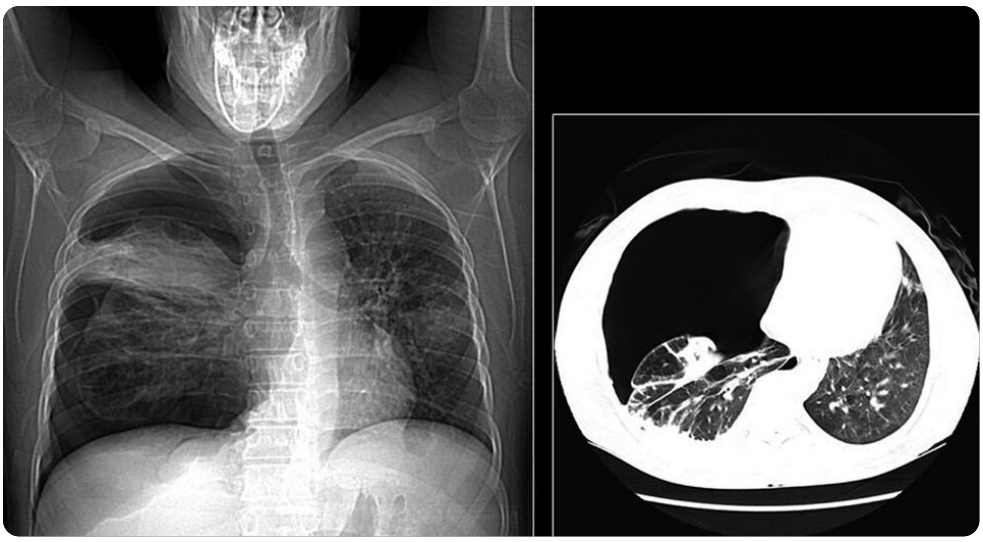
Εξέταση: Αξονική θώρακα · **Κλινικές πληροφορίες:** Τυχαίος όζος σε αξονική που έγινε για άλλο λόγο.

Περιστατικό 44 · Αξονική θώρακα

Ερώτηση: Περιγράψτε τον όζο και γράψτε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση.

Περιστατικό 45 ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική θώρακα, πνευμονικό παράθυρο · **Κλινικές πληροφορίες:** Πυρετός, βήχας, δύσπνοια.



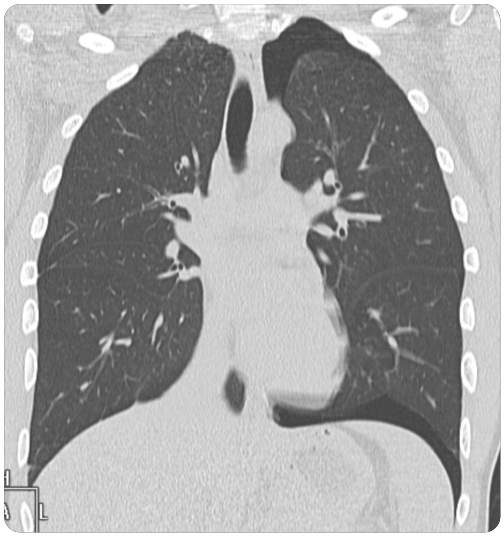
Περιστατικό 45 · Αξονική θώρακα, πνευμονικό παράθυρο

Ερώτηση: Περιγράψτε τον τύπο της σκίασης και απαριθμήστε τη διαφορική διάγνωση.

Περιστατικό 46

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική θώρακα · **Κλινικές πληροφορίες:** Κάκωση θώρακα.

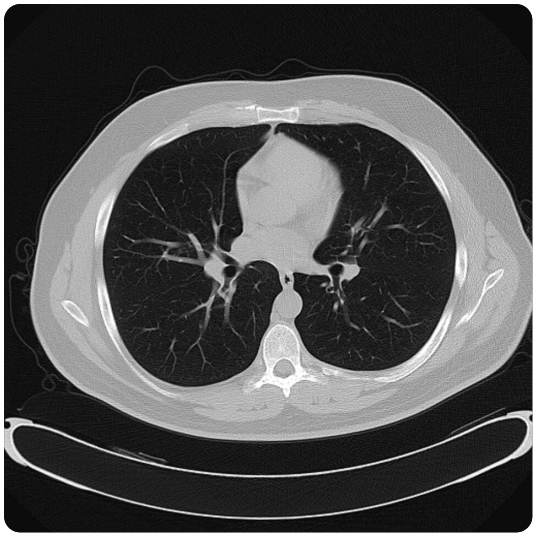


Περιστατικό 46 · Αξονική θώρακα

Ερώτηση: Περιγράψτε το εύρημα· εξηγήστε γιατί μπορεί να μη φάνηκε στην ακτινογραφία.

Περιστατικό 47 ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική θώρακα, πνευμονικό παράθυρο · **Κλινικές πληροφορίες:** Χρόνιος βήχας.



Περιστατικό 47 · Αξονική θώρακα, πνευμονικό παράθυρο

Ερώτηση: Υπάρχει παθολογία σε αυτή την τομή;

Περιστατικό 48

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Άλγος που μεταναστεύει από την περιομφαλική περιοχή στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο.

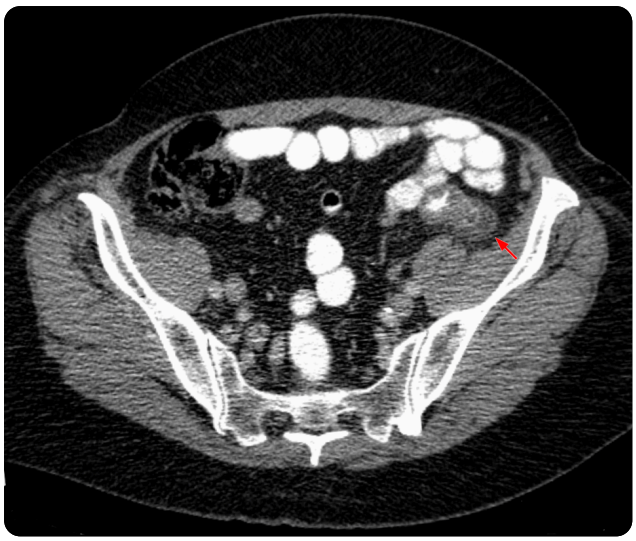
Περιστατικό 48 · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε τη σκωληκοειδή απόφυση και την περιοχή γύρω της.

Περιστατικό 49

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Άλγος στο κάτω τεταρτημόριο και πυρετός.



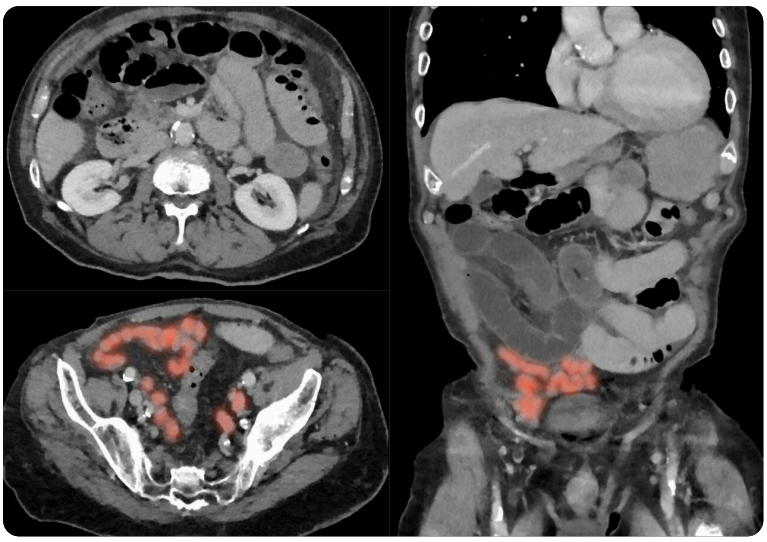
Περιστατικό 49 · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε τα ευρήματα και αναζητήστε επιπλοκές.

Περιστατικό 50

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Διάταση κοιλίας, έμετοι· προηγούμενη χειρουργική επέμβαση.



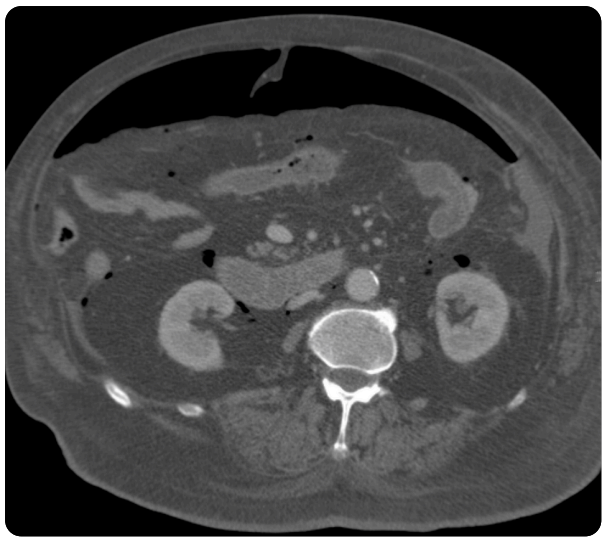
Περιστατικό 50 · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

Ερώτηση: Αναζητήστε το σημείο μετάβασης και ευρήματα ισχαιμίας.

Περιστατικό 51

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική κοιλίας · **Κλινικές πληροφορίες:** Ιστορικό πεπτικού έλκους· αιφνίδιο κοιλιακό άλγος.



Περιστατικό 51 · Αξονική κοιλίας

Ερώτηση: Περιγράψτε τον ελεύθερο αέρα και αναζητήστε την πιθανή πηγή του.

Περιστατικό 52

ΜΕΤΡΙΟ

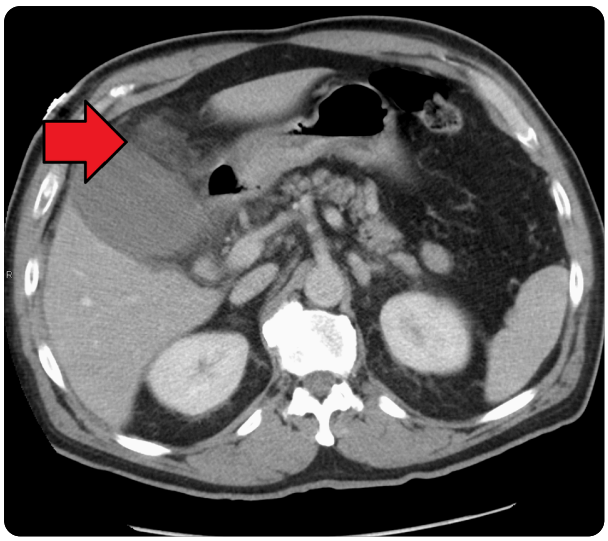
Εξέταση: Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Επιγαστρικό άλγος με αντανάκλαση στη ράχη, αυξημένη λιπάση.

Περιστατικό 52 · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε το πάγκρεας και την περιοχή γύρω του.

Περιστατικό 53 ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Πυρετός, άλγος δεξιού άνω τεταρτημορίου.



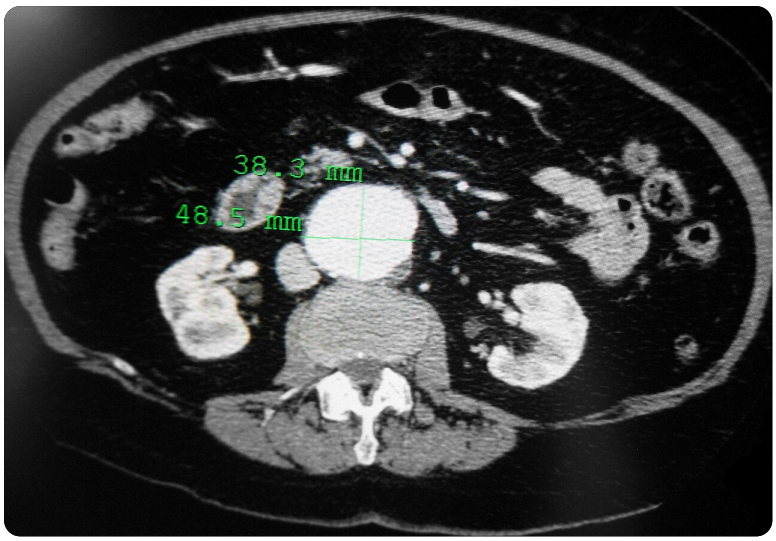
Περιστατικό 53 · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε τα ευρήματα της χοληδόχου κύστης.

Περιστατικό 54

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό / αξονική αγγειογραφία · **Κλινικές πληροφορίες:** Ηλικιωμένος ασθενής· κοιλιακό άλγος και άλγος ράχης.

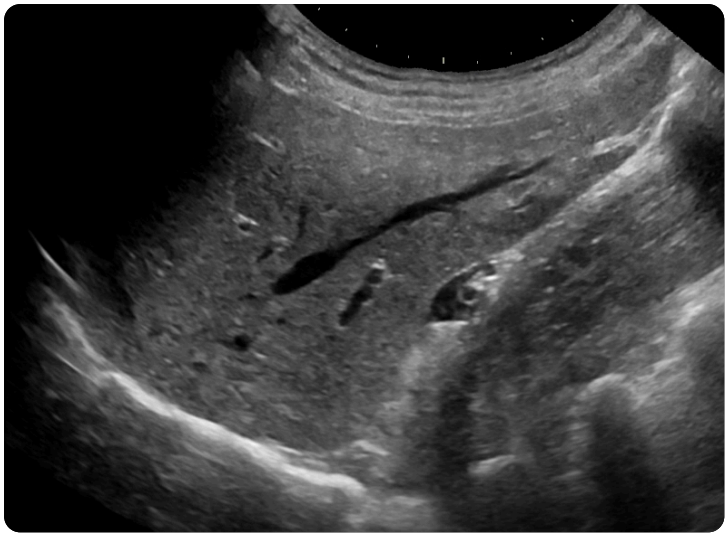


Περιστατικό 54 · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό / αξονική αγγειογραφία

Ερώτηση: Περιγράψτε την αορτή και αναζητήστε ευρήματα ρήξης.

Περιστατικό 55 ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα κοιλίας · **Κλινικές πληροφορίες:** Δυσπεψία.



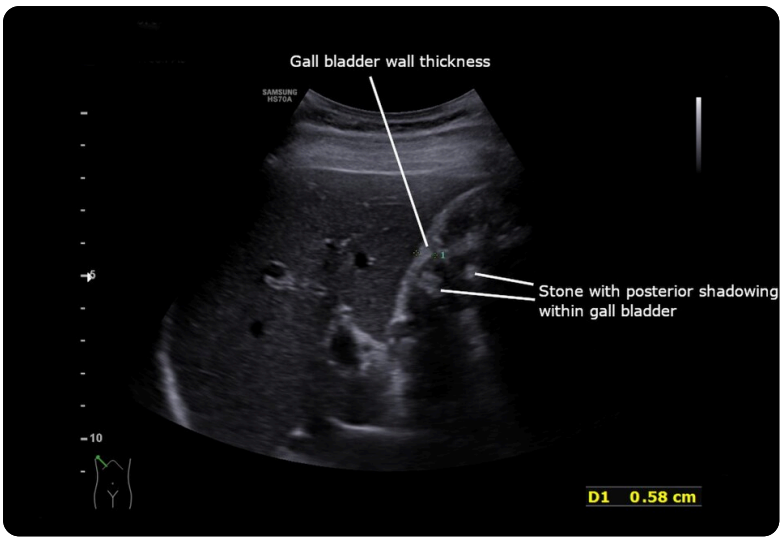
Περιστατικό 55 · Υπερηχογράφημα κοιλίας

Ερώτηση: Υπάρχει παθολογία σε αυτή την εικόνα;

Περιστατικό 56

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα κοιλίας · **Κλινικές πληροφορίες:** Πυρετός, άλγος δεξιού άνω τεταρτημορίου.



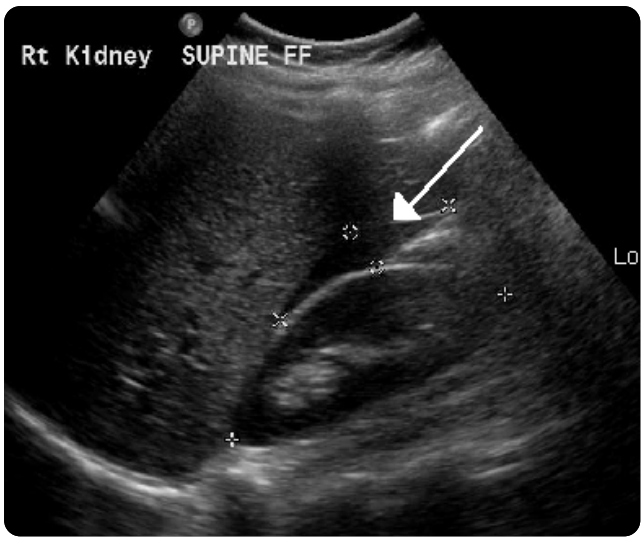
Περιστατικό 56 · Υπερηχογράφημα κοιλίας

Ερώτηση: Καταγράψτε με τη σειρά τα ευρήματα της οξείας χολοκυστίτιδας.

Περιστατικό 57

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: eFAST (ηπατονεφρικό παράθυρο) · **Κλινικές πληροφορίες:** Αμβλύ κοιλιακό τραύμα, υπόταση.



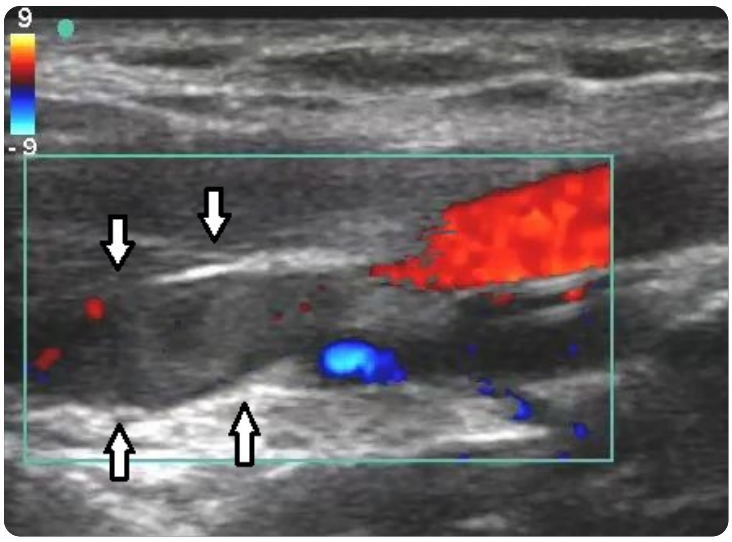
Περιστατικό 57 · eFAST (ηπατονεφρικό παράθυρο)

Ερώτηση: Εκτιμήστε το ηπατονεφρικό παράθυρο.

Περιστατικό 58

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα Doppler φλεβών κάτω άκρου · **Κλινικές πληροφορίες:** Οίδημα και άλγος στο ένα σκέλος.



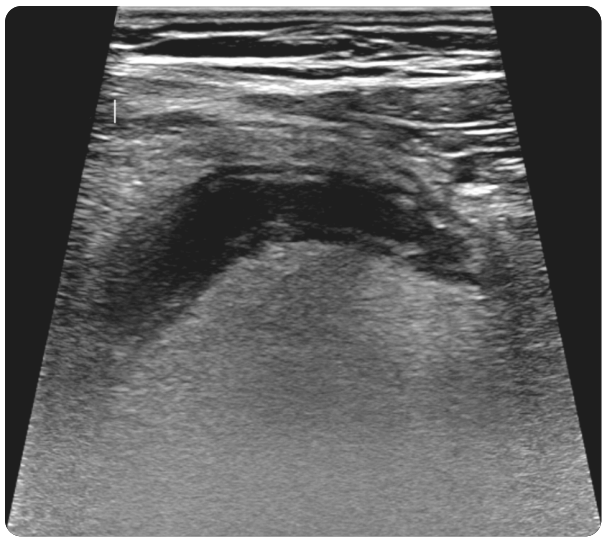
Περιστατικό 58 · Υπερηχογράφημα Doppler φλεβών κάτω άκρου

Ερώτηση: Περιγράψτε τη συμπιεσιμότητα και τον αυλό της φλέβας.

Περιστατικό 59

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα κοιλίας (δεξιό κάτω τεταρτημόριο) · **Κλινικές πληροφορίες:** Παιδί· άλγος στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο και πυρετός.



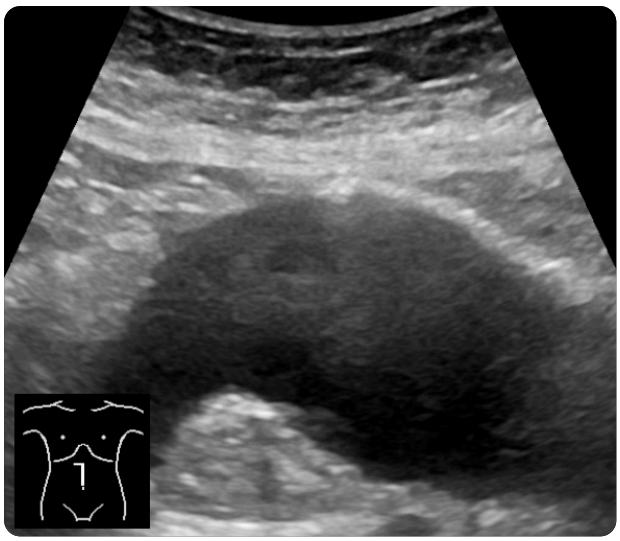
Περιστατικό 59 · Υπερηχογράφημα κοιλίας (δεξιό κάτω τεταρτημόριο)

Ερώτηση: Περιγράψτε τη σκωληκοειδή απόφυση.

Περιστατικό 60

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα κοιλίας / POCUS αορτής · **Κλινικές πληροφορίες:** Ηλικιωμένος ασθενής· σφύζουσα κοιλιακή μάζα.



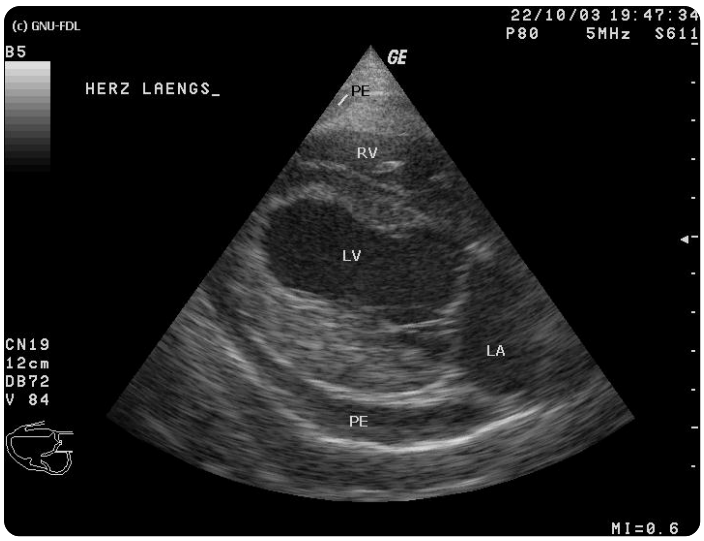
Περιστατικό 60 · Υπερηχογράφημα κοιλίας / POCUS αορτής

Ερώτηση: Μετρήστε και περιγράψτε την αορτή.

Περιστατικό 61

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Καρδιακό POCUS / υπερηχοκαρδιογράφημα · **Κλινικές πληροφορίες:** Δύσπνοια, υπόταση, διάταση σφαγιτίδων φλεβών.



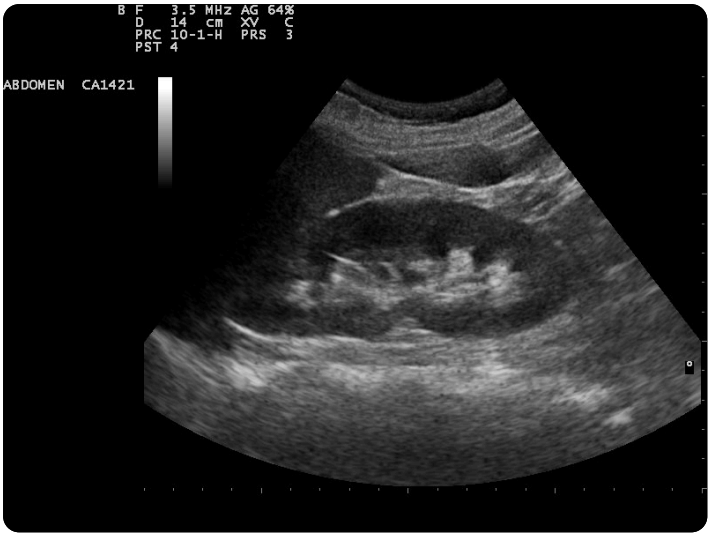
Περιστατικό 61 · Καρδιακό POCUS / υπερηχοκαρδιογράφημα

Ερώτηση: Περιγράψτε το εύρημα· τι πρέπει να ελεγχθεί για επιπωματισμό;

Περιστατικό 62

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα νεφρών · **Κλινικές πληροφορίες:** Ουρολοίμωξη.

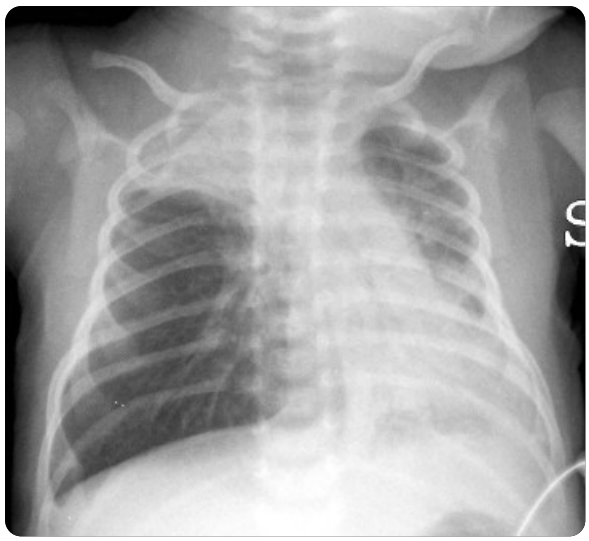


Περιστατικό 62 · Υπερηχογράφημα νεφρών

Ερώτηση: Υπάρχει παθολογία σε αυτή την εικόνα;

Περιστατικό 63 ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Δύσπνοια στη μετεγχειρητική περίοδο.

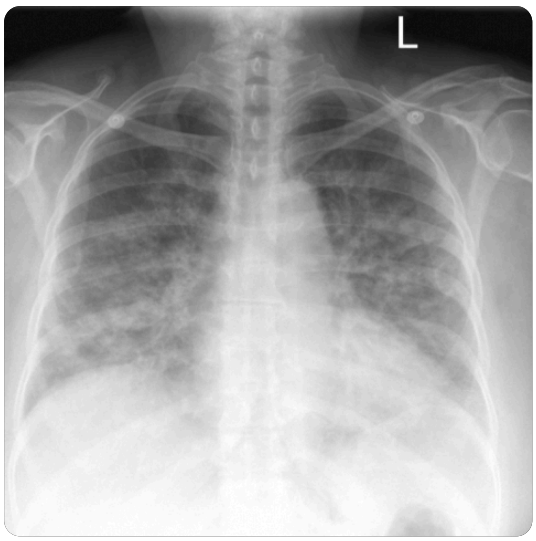


Περιστατικό 63 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Ερώτηση: Περιγράψτε τη σκίαση και γράψτε τα ευρήματα απώλειας όγκου.

Περιστατικό 64 ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα · **Κλινικές πληροφορίες:** Αιφνίδια δύσπνοια, ορθόπνοια· ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας.



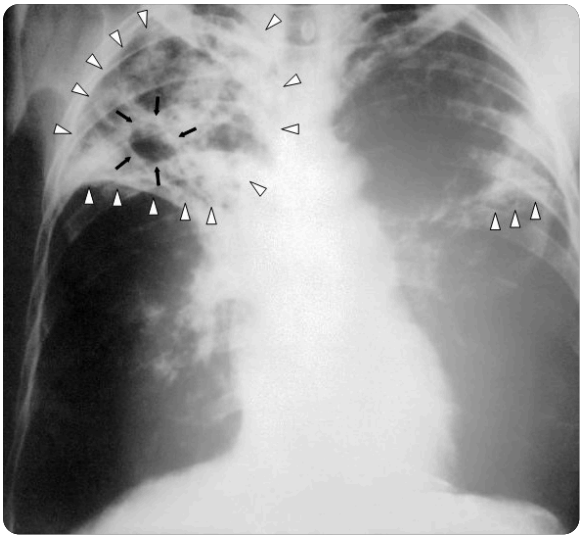
Περιστατικό 64 · Ακτινογραφία θώρακα

Ερώτηση: Περιγράψτε τα ευρήματα με τη σειρά των σταδίων.

Περιστατικό 65

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Βήχας εδώ και εβδομάδες, νυχτερινοί ιδρώτες, απώλεια βάρους.



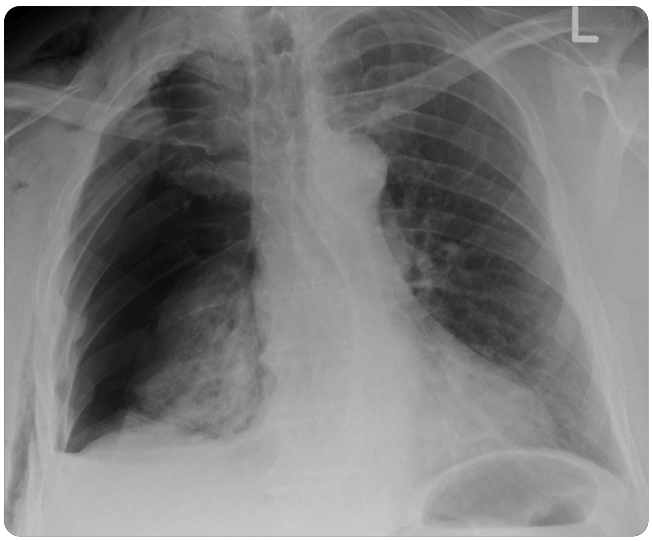
Περιστατικό 65 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Ερώτηση: Περιγράψτε τη βλάβη και γράψτε τη διαφορική διάγνωση.

Περιστατικό 66

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα / ακτινογραφία πλευρών · **Κλινικές πληροφορίες:** Κάκωση θώρακα.



Περιστατικό 66 · Ακτινογραφία θώρακα / ακτινογραφία πλευρών

Ερώτηση: Περιγράψτε το κάταγμα και αναζητήστε επιπλοκές.

Περιστατικό 67

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Απλή ακτινογραφία κοιλίας · **Κλινικές πληροφορίες:** Ηλικιωμένος ασθενής, χρόνια δυσκοιλιότητα, έντονη διάταση.

Περιστατικό 67 · Ακτινογραφία κοιλίας

Ερώτηση: Περιγράψτε το πρότυπο των αερίων.

Περιστατικό 68 ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία αγκώνα AP και πλάγια (παιδί) · **Κλινικές πληροφορίες:** Παιδί· πτώση σε τεντωμένο χέρι, οίδημα στον αγκώνα.

Περιστατικό 68 · Ακτινογραφία αγκώνα AP και πλάγια (παιδί)

Ερώτηση: Με ποια σημεία περιγράφετε το κάταγμα;

Περιστατικό 69

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας, οβελιαία και εγκάρσια T2 · **Κλινικές πληροφορίες:** Οσφυαλγία με αντανάκλαση στο σκέλος.

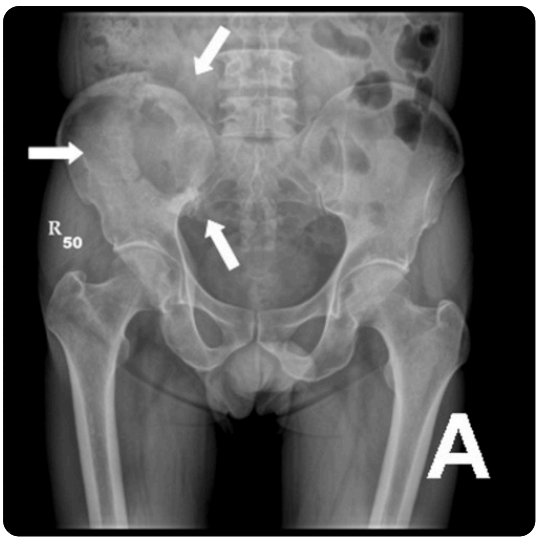
Περιστατικό 69 · Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας, οβελιαίες και εγκάρσιες T2

Ερώτηση: Περιγράψτε την παθολογία του δίσκου με τους σωστούς όρους.

Περιστατικό 70

ΜΕΤΡΙΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία οστού · **Κλινικές πληροφορίες:** Γνωστό ιστορικό κακοήθειας· οστικό άλγος.



Περιστατικό 70 · Ακτινογραφία οστού

Ερώτηση: Περιγράψτε τις βλάβες ως προς το πρότυπο, τα όρια και τη συμμετοχή του φλοιού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 · ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κλειδί απαντήσεων — Μέτριο

Περιστατικά 36–70. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε γράψει τη δική σας περιγραφή.

Περιστατικό 36

Πρότυπη περιγραφή: Στο εγκεφαλικό παρέγχυμα δεν παρατηρείται οξεία αιμορραγία, χωροκατακτητική βλάβη ή μεταβολή πυκνότητας ενδεικτική οξείας ισχαιμίας. Η διάκριση φαιάς-λευκής ουσίας διατηρείται. Το κοιλιακό σύστημα και οι αύλακες είναι αντίστοιχα της ηλικίας, οι δομές της μέσης γραμμής είναι κεντρικές. Στο οστικό παράθυρο δεν παρατηρείται κάταγμα.

Διάγνωση: Φυσιολογική αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε τις αποτιτανώσεις του χοριοειδούς πλέγματος, της επίφυσης ή των βασικών γαγγλίων ως αιμορραγία· σε κλινική υποψία εγκεφαλικού επεισοδίου δεν αναφέρετε ότι η φυσιολογική αξονική δεν αποκλείει την πρώιμη ισχαιμία.

Περιστατικό 37

Πρότυπη περιγραφή: Σε επαφή με την έσω πλάκα του θόλου του κρανίου παρατηρείται αμφίκυρτη (φακοειδής), υπέρπυκνη εξωαξονική συλλογή· συμβατή με επισκληρίδιο αιμάτωμα. Πάχος [ ] mm, μετατόπιση μέσης γραμμής [ ] mm. Στο οστικό παράθυρο παρακείμενο κάταγμα του θόλου [παρατηρήθηκε / δεν παρατηρήθηκε]. Ανακοινώθηκε για επείγουσα νευροχειρουργική εκτίμηση.

Διάγνωση: Επισκληρίδιο αιμάτωμα.

Το συχνότερο λάθος: Δεν διακρίνετε το επισκληρίδιο από το υποσκληρίδιο: το επισκληρίδιο αιμάτωμα είναι αμφίκυρτο και συνήθως δεν υπερβαίνει τις ραφές· το υποσκληρίδιο αιμάτωμα είναι μηνοειδές, υπερβαίνει τις ραφές αλλά όχι το δρέπανο και το σκηνίδιο.

Περιστατικό 38

Πρότυπη περιγραφή: Κατά μήκος της κυρτότητας του ημισφαιρίου παρατηρείται μηνοειδής εξωαξονική συλλογή· συμβατή με υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Πυκνότητα [υπέρπυκνο: οξύ / ισόπυκνο: υποξύ / υπόπυκνο: χρόνιο / μικτό]. Μέγιστο πάχος [ ] mm, μετατόπιση μέσης γραμμής [ ] mm.

Διάγνωση: Υποσκληρίδιο αιμάτωμα.

Το συχνότερο λάθος: Να διαφεύγει το ισόπυκνο (υποξύ) υποσκληρίδιο αιμάτωμα: ελέγξτε την εξάλειψη των αυλάκων και την προς τα έσω μετατόπιση του ορίου φαιάς-λευκής ουσίας· χρησιμοποιήστε ευρύ (υποσκληρίδιο) παράθυρο.

Περιστατικό 39

Πρότυπη περιγραφή: Στις βασικές δεξαμενές και στις αύλακες παρατηρείται υπέρπυκνο περιεχόμενο· συμβατό με υπαραχνοειδή αιμορραγία. Επέκταση στις κοιλίες [ναι / όχι], υδροκέφαλος [ναι / όχι]. Για τη

διερεύνηση ανευρύσματος συνιστάται αξονική αγγειογραφία. Το εύρημα ανακοινώθηκε επειγόντως.

Διάγνωση: Υπαραχνοειδής αιμορραγία.

Το συχνότερο λάθος: Χάνετε μικρή ποσότητα αιμορραγίας: κοιτάξτε ιδιαίτερα τη μεσοσκελική δεξαμενή, τις σχισμές του Sylvius και τα ινιακά κέρατα των πλάγιων κοιλιών. Δεν γνωματεύετε πρώιμο υδροκέφαλο.

Περιστατικό 40

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται υπόπυκνη περιοχή που αντιστοιχεί σε αρτηριακό έδαφος αιμάτωσης και αφορά τόσο τη φαιά όσο και τη λευκή ουσία· συμβατή με ισχαιμικό έμφρακτο στο έδαφος της [ ] αρτηρίας. Αιμορραγική μετατροπή [δεν παρατηρήθηκε / παρατηρήθηκε]· φαινόμενο μάζας [ ].

Διάγνωση: Ισχαιμικό έμφρακτο.

Το συχνότερο λάθος: Στην πρώιμη φάση, χωρίς χρήση παραθύρου εγκεφαλικού επεισοδίου, χάνετε την απώλεια διάκρισης φαιάς-λευκής ουσίας, την εξάλειψη της νησιωτικής ταινίας και του φακοειδούς πυρήνα· συγχέετε το έμφρακτο με οίδημα όγκου (το έμφρακτο αντιστοιχεί σε αγγειακό έδαφος και αφορά και τον φλοιό).

Περιστατικό 41

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται διάταση των πλάγιων κοιλιών [και της 3ης / 4ης κοιλίας]· οι αύλακες εμφανίζονται εξαλειμμένες σε αναλογία με το εύρος των κοιλιών. Περικοιλιακή υποπυκνότητα [ενδεικτική διεπενδυματικής διόδου ΕΝΥ] [ναι / όχι]. Για το επίπεδο απόφραξης εκτιμήθηκαν ο υδραγωγός και η 4η κοιλία· εφόσον χρειάζεται, συνιστάται μαγνητική.

Διάγνωση: Υδροκέφαλος.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε τη διάταση των κοιλιών λόγω ατροφίας ως υδροκέφαλο: στην ατροφία διευρύνονται αναλογικά και οι αύλακες· στον υδροκέφαλο τα κροταφικά κέρατα διευρύνονται νωρίς.

Περιστατικό 42

Πρότυπη περιγραφή: Στο εγκεφαλικό παρέγχυμα παρατηρείται χωροκατακτητική βλάβη με εντόπιση [ ] και πέριξ αγγειογενές οίδημα με δακτυλοειδείς προσεκβολές στη λευκή ουσία. Φαινόμενο μάζας και μετατόπιση μέσης γραμμής [ ]. Για τον χαρακτηρισμό συνιστάται μαγνητική εγκεφάλου με σκιαγραφικό.

Διάγνωση: Ενδοκράνια μάζα με αγγειογενές οίδημα.

Το συχνότερο λάθος: Να συγχέεται το αγγειογενές οίδημα (λευκή ουσία, δακτυλοειδές, σέβεται τον φλοιό) με το κυτταροτοξικό οίδημα (φαιά και λευκή ουσία, αγγειακή περιοχή).

Περιστατικό 43

Πρότυπη περιγραφή: Στους κλάδους της πνευμονικής αρτηρίας παρατηρούνται ελλείμματα πλήρωσης εντός του σκιαγραφημένου αυλού· συνάδει με οξεία πνευμονική εμβολή. Το πιο κεντρικό προσβεβλημένο επίπεδο [κύριο / λοβαίο / τμηματικό]. Λόγος διαμέτρων δεξιάς / αριστερής κοιλίας και θέση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος όσον αφορά την υπερφόρτωση της δεξιάς καρδιάς [ ]. Επαρκής σκιαγράφηση. Ενημερώθηκε επειγόντως.

Διάγνωση: Οξεία πνευμονική εμβολή.

Το συχνότερο λάθος: Να εκλαμβάνονται ως εμβολή η ανεπαρκής σκιαγράφηση, τα τεχνήματα αναπνοής ή οι πυλαίοι λεμφαδένες· να μη γνωματεύεται η τεχνική επάρκεια της εξέτασης.

Περιστατικό 44

Πρότυπη περιγραφή: Στο πνευμονικό παρέγχυμα παρατηρείται [συμπαγής / ημισυμπαγής / θολής υάλου] όζος· μέση διάμετρος [ ] mm, όρια [λεία / λοβωτά / ακιδωτά], αποτιτάνωση [ ]. Συνιστάται σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις και παρακολούθηση σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες, βάσει των παραγόντων κινδύνου.

Διάγνωση: Όζος πνεύμονα.

Το συχνότερο λάθος: Δεν γράφετε τον τύπο, το μέγεθος του όζου και τη σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση· δίνετε συγκεκριμένο διάστημα παρακολούθησης χωρίς να γνωρίζετε το προφίλ κινδύνου του ασθενούς.

Περιστατικό 45

Πρότυπη περιγραφή: Στο πνευμονικό παρέγχυμα παρατηρούνται περιοχές θολής υάλου, με τη μορφή αύξησης της πυκνότητας που δεν εξαλείφει τα περιγράμματα των αγγείων και των βρόγχων· κατανομή [περιφερική / κεντρική / κατά πλάκες / διάχυτη]. Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται λοίμωξη, οίδημα, αιμορραγία και φλεγμονώδεις διεργασίες· συνιστάται συσχέτιση με την κλινική εικόνα.

Διάγνωση: Θολή ύαλος.

Το συχνότερο λάθος: Συγχέετε τη θολή ύαλο με την πύκνωση (στην πύκνωση τα αγγεία δεν διακρίνονται)· εκλαμβάνετε την αύξηση πυκνότητας σε τομές που ελήφθησαν σε εκπνοή ως θολή ύαλο.

Περιστατικό 46

Πρότυπη περιγραφή: Στην υπεζωκοτική κοιλότητα, μεταξύ του πνευμονικού παρεγχύματος και του θωρακικού τοιχώματος, παρατηρείται ελεύθερος αέρας· συνάδει με πνευμοθώρακα. Ποσότητα και κατανομή [ ]. Συνοδά κατάγματα πλευρών, αιμοθώρακας και θλάση [ ]. Σε ασθενή σε ύπτια θέση ο αέρας συγκεντρώνεται πρόσθια και μπορεί να διαφύγει στην ακτινογραφία.

Διάγνωση: Πνευμοθώρακας (αξονική).

Το συχνότερο λάθος: Κοιτάτε στο παράθυρο μεσοθωρακίου και δεν περνάτε στο πνευμονικό παράθυρο· εκλαμβάνετε το πομφολυγώδες εμφύσημα ως πνευμοθώρακα.

Περιστατικό 47

Πρότυπη περιγραφή: Το πνευμονικό παρέγχυμα παρουσιάζει φυσιολογική αεροφορία· δεν παρατηρούνται όζος, πύκνωση, θολή ύαλος ή εμφύσημα. Η τραχεία και οι κύριοι βρόγχοι είναι βατοί. Δεν παρατηρείται πλευριτική συλλογή ή πνευμοθώρακας.

Διάγνωση: Φυσιολογική αξονική θώρακα (πνευμονικό παράθυρο).

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε τις διατομές αγγείων ως όζους (παρακολουθήστε σε διαδοχικές τομές: το αγγείο συνεχίζει διακλαδιζόμενο)· γνωματεύετε ως παθολογία την αύξηση πυκνότητας στις οπίσθιες περιοχές λόγω βαρύτητας.

Περιστατικό 48

Πρότυπη περιγραφή: Η σκωληκοειδής απόφυση είναι διατεταμένη, με πάχυνση τοιχώματος και αυξημένη σκιαγραφική ενίσχυση, ενώ παρατηρείται διήθηση του περισκωληκοειδούς λίπους· συμβατά με οξεία σκωληκοειδίτιδα. Κοπρόλιθος [υπάρχει / δεν υπάρχει]· ευρήματα διάτρησης (εξωαυλικός αέρας, απόστημα, έλλειμμα τοιχώματος) [ ].

Διάγνωση: Οξεία σκωληκοειδίτιδα.

Το συχνότερο λάθος: Να εκλαμβάνεται άλλη εντερική έλικα ως σκωληκοειδής απόφυση χωρίς να ακολουθηθεί η δομή με τυφλό άκρο που εκφύεται από το τυφλό· να μην αναφέρεται η παρουσία διάτρησης και αποστήματος.

Περιστατικό 49

Πρότυπη περιγραφή: Σε τμήμα του παχέος εντέρου παρατηρούνται εκκολπώματα, πάχυνση του παρακείμενου τοιχώματος και διήθηση του πέριξ λίπους· συμβατά με οξεία εκκολπωματίτιδα. Απόστημα, εξωαυλικός αέρας ή συρίγγιο [δεν παρατηρήθηκε / παρατηρήθηκε].

Διάγνωση: Οξεία εκκολπωματίτιδα.

Το συχνότερο λάθος: Δεν κάνετε τη διάκριση επιπλεγμένης / μη επιπλεγμένης· σε πάχυνση τοιχώματος μικρού μήκους με συνοδό λεμφαδένα δεν αναφέρετε την πιθανότητα όγκου και δεν προτείνετε εκτίμηση μετά την ίαση.

Περιστατικό 50

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρούνται διατεταμένες, πλήρεις υγρού έλικες λεπτού εντέρου και σημείο μετάβασης στο επίπεδο [ ], με συμπεπτωκυίες τις άπω έλικες· συμβατά με μηχανική απόφραξη λεπτού εντέρου. Ενίσχυση εντερικού τοιχώματος, οίδημα μεσεντερίου, ελεύθερο υγρό και πνευμάτωση όσον αφορά την ισχαιμία [ ]. Πιθανό αίτιο [συμφυτική ταινία / κήλη / μάζα].

Διάγνωση: Μηχανική απόφραξη λεπτού εντέρου.

Το συχνότερο λάθος: Δεν γνωματεύετε απόφραξη κλειστής έλικας και ευρήματα ισχαιμίας· δεν αναφέρετε το σημείο μετάβασης και το πιθανό αίτιο.

Περιστατικό 51

Πρότυπη περιγραφή: Εντός της κοιλίας, κάτω από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα και στην περιηπατική περιοχή, παρατηρείται ελεύθερος εξωαυλικός αέρας· συμβατός με πνευμοπεριτόναιο. Ευρήματα που υποδεικνύουν τη θέση της διάτρησης (έλλειμμα τοιχώματος, τοπική διήθηση λίπους, φυσαλίδες αέρα) [ ]. Ενημερώθηκε επειγόντως.

Διάγνωση: Πνευμοπεριτόναιο (αξονική).

Το συχνότερο λάθος: Χάνετε μικρή ποσότητα ελεύθερου αέρα στο παράθυρο μαλακών μορίων (περάστε σε πνευμονικό ή ευρύ παράθυρο)· εκλαμβάνετε τον ενδοαυλικό αέρα ως ελεύθερο αέρα.

Περιστατικό 52

Πρότυπη περιγραφή: Το πάγκρεας εμφανίζεται οιδηματώδες, ενώ στον περιπαγκρεατικό λιπώδη ιστό παρατηρούνται θόλωση και υγρό· συνάδει με οξεία παγκρεατίτιδα. Περιοχή παρεγχύματος χωρίς ενίσχυση (νέκρωση) [ ]· συλλογές και αγγειακές επιπλοκές [ ]. Όσον αφορά την αιτιολογία, εκτιμήθηκαν η χοληδόχος κύστη και τα χοληφόρα.

Διάγνωση: Οξεία παγκρεατίτιδα.

Το συχνότερο λάθος: Αγνοείτε ότι η νέκρωση μπορεί να μην έχει αναπτυχθεί πλήρως τις πρώτες ημέρες και βασίζεστε υπερβολικά στο εύρημα «χωρίς νέκρωση» της πρώιμης αξονικής· δεν εκτιμάτε τη χολολιθίαση ως αιτιολογία.

Περιστατικό 53

Πρότυπη περιγραφή: Η χοληδόχος κύστη είναι διατεταμένη, με παχυσμένο τοίχωμα, και στον περιχολοκυστικό λιπώδη ιστό παρατηρείται θόλωση [και υγρό]· συνάδει με οξεία χολοκυστίτιδα. Λίθοι εντός της κύστης [ ]· γάγγραινα, διάτρηση ή αέρας εντός του τοιχώματος [ ].

Διάγνωση: Οξεία χολοκυστίτιδα (αξονική).

Το συχνότερο λάθος: Αποκλείετε τη χολοκυστίτιδα επειδή δεν φάνηκαν λίθοι στην αξονική (ορισμένοι λίθοι μπορεί να μη φαίνονται στην αξονική)· ξεχνάτε ότι σε υποψία η εξέταση πρώτης επιλογής είναι το υπερηχογράφημα.

Περιστατικό 54

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται ανευρυσματική διάταση της κοιλιακής αορτής· μέγιστη εξωτερική διάμετρος [ ] mm, θέση σε σχέση με τις νεφρικές αρτηρίες [υπονεφρική / παρανεφρική / υπερνεφρική], τοιχωματικός θρόμβος [ ]. Οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα ή ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού [δεν παρατηρήθηκε / παρατηρήθηκε].

Διάγνωση: Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής.

Το συχνότερο λάθος: Να μη μετριέται η διάμετρος κάθετα στον άξονα του αγγείου (σε λοξή τομή υπερεκτιμάται) και από εξωτερικό σε εξωτερικό τοίχωμα· να μην αναγράφεται ρητά η παρουσία ή η απουσία ευρημάτων ρήξης.

Περιστατικό 55

Πρότυπη περιγραφή: Η ηχογένεια του ηπατικού παρεγχύματος είναι ομοιογενής και φυσιολογική· το περίγραμμα είναι λείο. Δεν παρατηρείται εστιακή βλάβη. Τα ενδοηπατικά χοληφόρα δεν είναι διατεταμένα· οι ηπατικές και η πυλαία φλέβα έχουν φυσιολογική εικόνα.

Διάγνωση: Φυσιολογικό υπερηχογράφημα ήπατος.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε ως βλάβη το λίπος γύρω από τον στρογγύλο και τον δρεπανοειδή σύνδεσμο ή τον κερκοφόρο λοβό· θεωρείτε ότι με μία τομή εκτιμήθηκε ολόκληρο το ήπαρ.

Περιστατικό 56

Πρότυπη περιγραφή: Η χοληδόχος κύστη είναι διατεταμένη, με παχυσμένο και οιδηματώδες τοίχωμα· λίθοι στον αυλό [ ] και ενσφηνωμένος λίθος στην περιοχή του αυχένα [ ]. Περιχολοκυστικό υγρό [ ]. Υπερηχογραφικό σημείο Murphy [θετικό / αρνητικό]. Τα ευρήματα συνάδουν με οξεία χολοκυστίτιδα.

Διάγνωση: Οξεία χολοκυστίτιδα.

Το συχνότερο λάθος: Θεωρείτε την πάχυνση τοιχώματος από μόνη της χολοκυστίτιδα: το τοίχωμα μπορεί να φαίνεται παχύ και σε ασκίτη, υπολευκωματιναιμία, ηπατίτιδα και σε μη νηστικό ασθενή. Δεν διερευνάτε το υπερηχογραφικό σημείο Murphy.

Περιστατικό 57

Πρότυπη περιγραφή: Στον ηπατονεφρικό χώρο (θύλακος του Morison) παρατηρείται άνηχο ελεύθερο υγρό· σε πλαίσιο τραύματος πρέπει να εκτιμηθεί ως ενδεικτικό αιμοπεριτοναίου. Τα περισπληνικά, πυελικά, περικαρδιακά και υπεζωκοτικά παράθυρα εκτιμήθηκαν χωριστά. Το εύρημα ανακοινώθηκε επειγόντως στην ομάδα τραύματος.

Διάγνωση: Θετικό FAST (ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison).

Το συχνότερο λάθος: Να εκλαμβάνεται το περινεφρικό λίπος ή η χοληδόχος κύστη ως ελεύθερο υγρό· να μην αναφέρεται ότι ένα αρνητικό FAST δεν αποκλείει κάκωση συμπαγούς οργάνου και οπισθοπεριτοναϊκή αιμορραγία.

Περιστατικό 58

Πρότυπη περιγραφή: Στη φλέβα [ ] δεν επιτυγχάνεται πλήρης συμπίεση με την πίεση του ηχοβολέα· στον αυλό παρατηρείται ηχογενές θρομβωτικό υλικό και στο έγχρωμο Doppler [έλλειμμα πλήρωσης / απουσία ροής]. Τα ευρήματα συνάδουν με εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Κεντρική επέκταση του θρόμβου [ ].

Διάγνωση: Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση.

Το συχνότερο λάθος: Παραλείπετε τη δοκιμασία συμπίεσης και βασίζεστε μόνο στο έγχρωμο Doppler· ο οξύς θρόμβος μπορεί να είναι άνηχος, και ο αυλός που φαίνεται «κενός» δεν αποκλείει θρόμβο.

Περιστατικό 59

Πρότυπη περιγραφή: Στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο παρατηρείται σωληνώδης δομή με τυφλό άκρο, χωρίς περισταλτισμό, που δεν συμπιέζεται με την πίεση του ηχοβολέα· εξωτερική διάμετρος [ ] mm (πάνω από 6 mm). Αυξημένη ηχογένεια του περιβάλλοντος λιπώδους ιστού [ ], σκωληκοειδόλιθος [ ]. Τα ευρήματα συνάδουν με οξεία σκωληκοειδίτιδα.

Διάγνωση: Οξεία σκωληκοειδίτιδα (υπερηχογράφημα).

Το συχνότερο λάθος: Όταν η σκωληκοειδής απόφυση δεν απεικονίζεται, γράφετε «δεν υπάρχει σκωληκοειδίτιδα» (το σωστό: «η σκωληκοειδής απόφυση δεν απεικονίστηκε»)· εκλαμβάνετε τον τελικό ειλεό ως σκωληκοειδή απόφυση (ο ειλεός εμφανίζει περισταλτισμό και δεν έχει τυφλό άκρο).

Περιστατικό 60

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται ανευρυσματική διάταση της κοιλιακής αορτής· μέγιστη προσθιοπίσθια διάμετρος από έξω τοίχωμα σε έξω τοίχωμα [ ] mm. Τοιχωματικός θρόμβος στον αυλό [ ]. Το υπερηχογράφημα δεν είναι αξιόπιστο για την εκτίμηση ρήξης· σε κλινική υποψία συνιστάται αξονική αγγειογραφία.

Διάγνωση: Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (υπερηχογράφημα).

Το συχνότερο λάθος: Να μετριέται η διάμετρος από τον εσωτερικό αυλό, αφήνοντας εκτός τον θρόμβο· να χαρακτηρίζεται «φυσιολογική» μια αορτή που δεν απεικονίζεται πλήρως λόγω αερίων του εντέρου.

Περιστατικό 61

Πρότυπη περιγραφή: Στον περικαρδιακό χώρο παρατηρείται άνηχο υγρό· συνάδει με περικαρδιακή συλλογή. Ποσότητα και κατανομή [ ]. Ευρήματα επιπωματισμού (διαστολική σύμπτωση του δεξιού κόλπου ή της δεξιάς κοιλίας, διάταση της κάτω κοίλης φλέβας και απώλεια της αναπνευστικής διακύμανσης) [ ]. Ενημερώθηκε ο κλινικός ιατρός.

Διάγνωση: Περικαρδιακή συλλογή.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε το επικαρδιακό λίπος ως συλλογή· το συγχέετε με αριστερή πλευριτική συλλογή (ελέγξτε τη θέση του υγρού σε σχέση με την κατιούσα αορτή στον παραστερνικό επιμήκη άξονα).

Περιστατικό 62

Πρότυπη περιγραφή: Η ηχογένεια του νεφρικού παρεγχύματος είναι φυσιολογική, η φλοιομυελική διαφοροποίηση διατηρείται. Δεν παρατηρείται διάταση, λίθος ή μάζα στο πυελοκαλυκικό σύστημα.

Διάγνωση: Φυσιολογικό υπερηχογράφημα νεφρών.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε τις υποηχογενείς μυελικές πυραμίδες (ιδίως σε νέους) ως υδρονέφρωση ή κύστεις· γνωματεύετε ως μάζα την εμβρυϊκή λοβίωση ή τη στήλη του Bertin.

Περιστατικό 63

Πρότυπη περιγραφή: Στον πνεύμονα παρατηρείται σκίαση που συνοδεύεται από απώλεια όγκου· συνυπάρχει μετατόπιση [μεσολοβίου σχισμής / πύλης / διαφράγματος / μεσοθωρακίου]. Τα ευρήματα είναι συμβατά με ατελεκτασία. Συνιστάται κλινική εκτίμηση για κεντρικό αποφρακτικό αίτιο.

Διάγνωση: Ατελεκτασία.

Το συχνότερο λάθος: Συγχέετε την ατελεκτασία με την πνευμονία: καθοριστικά είναι τα ευρήματα απώλειας όγκου (μετατόπιση μεσολοβίου σχισμής και πύλης, ανύψωση διαφράγματος, έλξη του μεσοθωρακίου προς την ίδια πλευρά).

Περιστατικό 64

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρούνται αγγειακή ανακατανομή, περιπυλαία ενίσχυση, ευρήματα διάμεσου οιδήματος (γραμμές Kerley B, περιβρογχική πάχυνση) και περιπυλαίες κυψελιδικές σκιάσεις. Πλευριτική συλλογή [ ], καρδιομεγαλία [ ]. Τα ευρήματα συνάδουν με πνευμονικό οίδημα.

Διάγνωση: Πνευμονικό οίδημα.

Το συχνότερο λάθος: Να γνωματεύεται η αμφοτερόπλευρη κυψελιδική σκίαση απευθείας ως «αμφοτερόπλευρη πνευμονία»· να μη λαμβάνεται υπόψη η διάκριση καρδιογενούς / μη καρδιογενούς με βάση το μέγεθος της καρδιάς, τη συλλογή και την κλινική εικόνα.

Περιστατικό 65

Πρότυπη περιγραφή: Στο πνευμονικό παρέγχυμα παρατηρείται κοιλωτική βλάβη με [λεπτό / παχύ] τοίχωμα· επίπεδο αέρα-υγρού εντός της [ ]. Διήθηση πέριξ και οζώδεις σκιάσεις σε άλλες περιοχές, ενδεικτικές διασποράς [ ]. Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται φυματίωση, πνευμονικό απόστημα και κοιλωτική κακοήθεια. Λόγω υποψίας ενεργού φυματίωσης ενημερώθηκε ο θεράπων ιατρός.

Διάγνωση: Κοιλωτική βλάβη (υποψία φυματίωσης).

Το συχνότερο λάθος: Συγχέετε την κοιλότητα με πομφόλυγα ή κύστη· δεν γράφετε το πάχος του τοιχώματος και τις συνοδές εστίες διασποράς· ξεχνάτε να ενημερώσετε τον θεράποντα ιατρό για τον έλεγχο λοιμώξεων.

Περιστατικό 66

Πρότυπη περιγραφή: Στην πλευρά παρατηρείται καταγματική γραμμή που χαρακτηρίζεται από διακοπή της συνέχειας του φλοιού [ποια πλευρά, ποιο τμήμα]. Συνοδός πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας, θλάση πνεύμονα και υποδόριο εμφύσημα [ ].

Διάγνωση: Κάταγμα πλευράς.

Το συχνότερο λάθος: Να βρίσκεται ένα κάταγμα και να σταματά η παρακολούθηση των υπόλοιπων πλευρών· να μη γνωματεύονται τα πολυτμηματικά κατάγματα σε διαδοχικές πλευρές (ασταθής θώρακας) και οι επιπλοκές.

Περιστατικό 67

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται έλικα παχέος εντέρου με έντονη διάταση, χωρίς κολικές κυψέλες, σε σχήμα ανεστραμμένου U («κόκκος καφέ»), που εκτείνεται από την πύελο προς την άνω κοιλία· συνάδει με συστροφή σιγμοειδούς. Διάταση του κεντρικότερου παχέος εντέρου [ ], ελεύθερος αέρας [ ]. Ενημερώθηκε επειγόντως.

Διάγνωση: Συστροφή σιγμοειδούς.

Το συχνότερο λάθος: Να μη γίνεται διάκριση από τη συστροφή τυφλού και την ψευδοαπόφραξη του παχέος εντέρου· να μη συστήνεται εκτίμηση για διάτρηση και ισχαιμία.

Περιστατικό 68

Πρότυπη περιγραφή: Στο άπω βραχιόνιο παρατηρείται καταγματική γραμμή σε υπερκονδύλιο επίπεδο. Στην πλάγια ακτινογραφία εκτιμήθηκαν το σημείο του οπίσθιου λιπώδους επιθέματος [ ] και η σχέση της πρόσθιας βραχιόνιας γραμμής με τον κεφαλοειδή λόβο [διέρχεται από το μέσο τριτημόριο του κεφαλοειδούς / διέρχεται μπροστά του]· παρεκτόπιση [ ].

Διάγνωση: Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου (παιδί).

Το συχνότερο λάθος: Παραλείπετε το σημείο του οπίσθιου λιπώδους επιθέματος όταν δεν φαίνεται σαφής καταγματική γραμμή (είναι πάντα παθολογικό)· εκλαμβάνετε τα φυσιολογικά κέντρα οστέωσης ως καταγματικά τμήματα.

Περιστατικό 69

Πρότυπη περιγραφή: Στο επίπεδο [ ] παρατηρείται κήλη του μεσοσπονδύλιου δίσκου με μορφή οπίσθιας [προβολής / εξώθησης]· υπάρχει στένωση του σπονδυλικού σωλήνα και [της πλάγιας εσοχής / του

μεσοσπονδυλίου τρήματος] με επαφή / πίεση στη ρίζα [ ]. Εκφυλιστικές αλλοιώσεις δίσκων στα άλλα επίπεδα [ ].

Διάγνωση: Κήλη οσφυϊκού μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Το συχνότερο λάθος: Να συγχέονται οι όροι «διόγκωση», «προβολή» και «εξώθηση»· να μην αναφέρονται το προσβεβλημένο επίπεδο και η νευρική ρίζα.

Περιστατικό 70

Πρότυπη περιγραφή: Στο οστό παρατηρείται [μία / πολλαπλές] λυτική βλάβη / βλάβες· όρια [ασαφή / με ευρεία ζώνη μετάβασης], υπάρχει [λέπτυνση / καταστροφή] του φλοιού. Περιοστική αντίδραση [ ]. Με το γνωστό ιστορικό κακοήθειας είναι συμβατά με μετάσταση· συνιστάται εκτίμηση του κινδύνου παθολογικού κατάγματος.

Διάγνωση: Λυτική οστική μετάσταση.

Το συχνότερο λάθος: Δεν γνωματεύετε τη συμμετοχή του φλοιού και τον κίνδυνο παθολογικού κατάγματος· δεν αναφέρετε στη διαφορική διάγνωση το πολλαπλούν μυέλωμα και τον πρωτοπαθή όγκο οστού.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

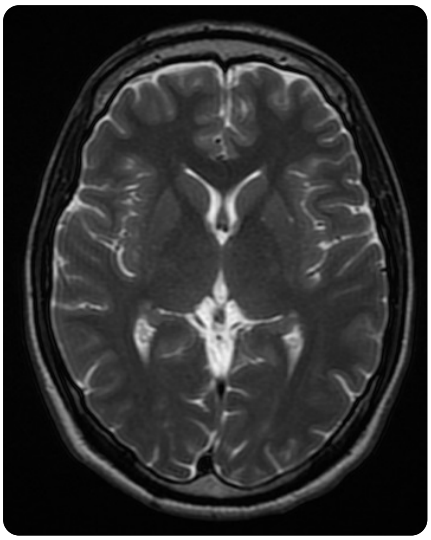
Προχωρημένο

Περιστατικά 71–100. Λεπτά ευρήματα, μαγνητική και περιστατικά που απαιτούν ακριβή διαφορική διάγνωση. Στόχος: να μη διαφεύγει τίποτα και να μη γίνεται υπερδιάγνωση.

Περιστατικό 71

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική εγκεφάλου, εγκάρσιες τομές · **Κλινικές πληροφορίες:** Ζάλη.

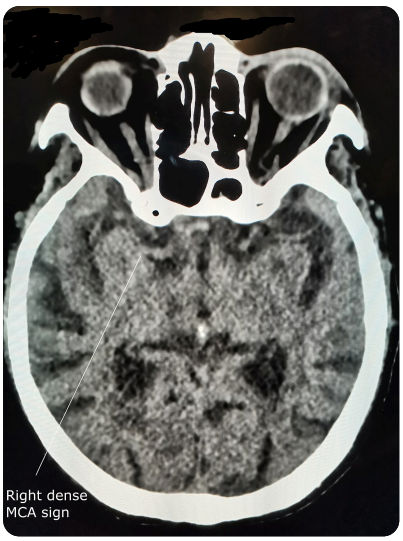


Περιστατικό 71 · Μαγνητική εγκεφάλου, εγκάρσιες τομές

Ερώτηση: Προσδιορίστε την ακολουθία· υπάρχει παθολογία;

Περιστατικό 72 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Αιφνίδια ημιπληγία και αφασία· λίγο μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

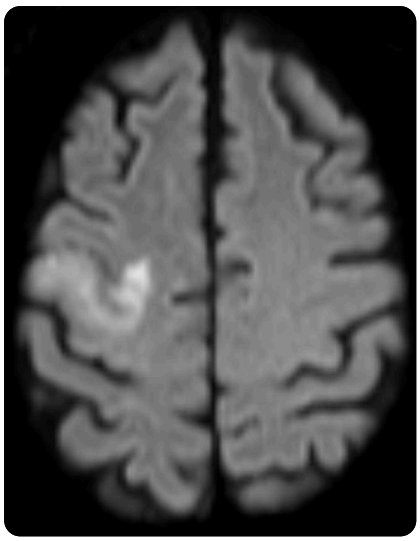


Περιστατικό 72 · Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό

Ερώτηση: Αναζητήστε πρώιμα ευρήματα εγκεφαλικού επεισοδίου.

Περιστατικό 73 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική εγκεφάλου, DWI και ADC · **Κλινικές πληροφορίες:** Αιφνίδια διαταραχή ομιλίας.

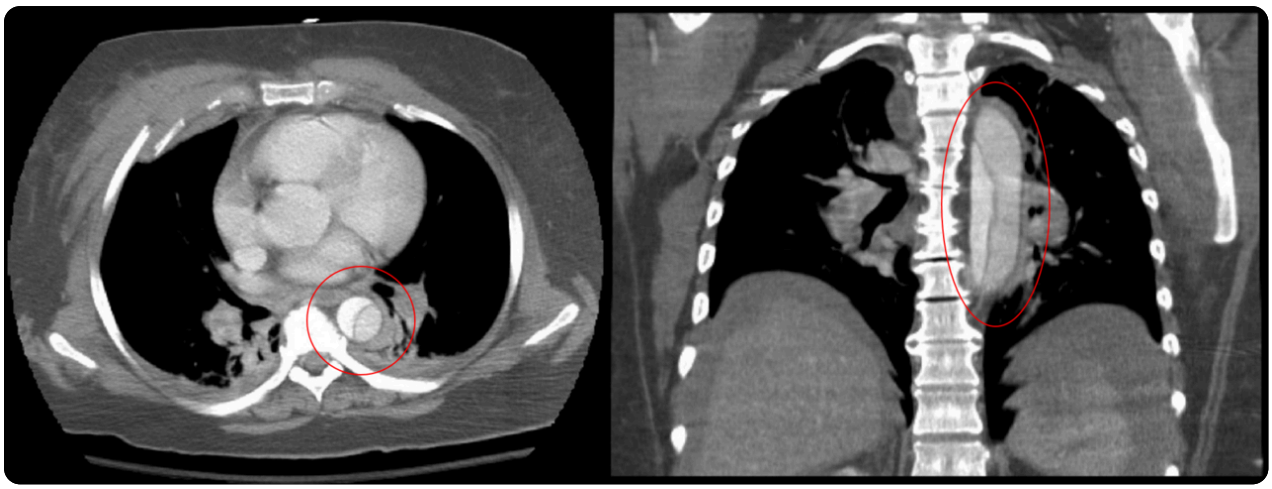


Περιστατικό 73 · Μαγνητική εγκεφάλου, DWI και ADC

Ερώτηση: Περιγράψτε το εύρημα στη διάχυση· τι επιβεβαιώνετε με το ADC;

Περιστατικό 74 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Αξονική αγγειογραφία, θώρακας · **Κλινικές πληροφορίες:** Θωρακικό άλγος σχιστικού τύπου με επέκταση στη ράχη· υπέρταση.

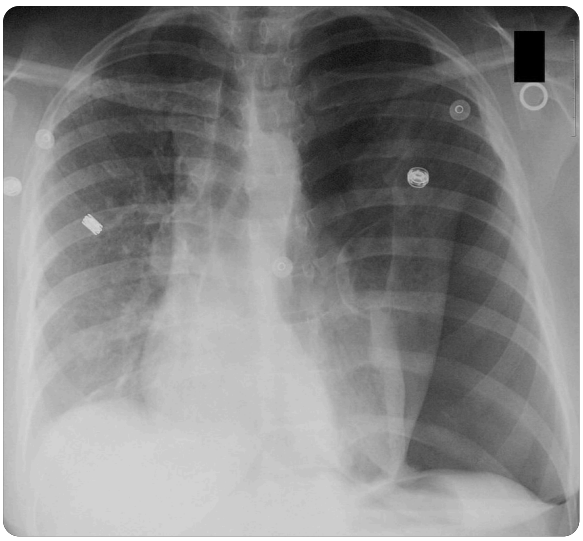


Περιστατικό 74 · Αξονική αγγειογραφία θώρακα

Ερώτηση: Περιγράψτε και ταξινομήστε τον διαχωρισμό.

Περιστατικό 75 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα · **Κλινικές πληροφορίες:** Αιφνίδιος αποκορεσμός και υπόταση σε μηχανικό αερισμό.

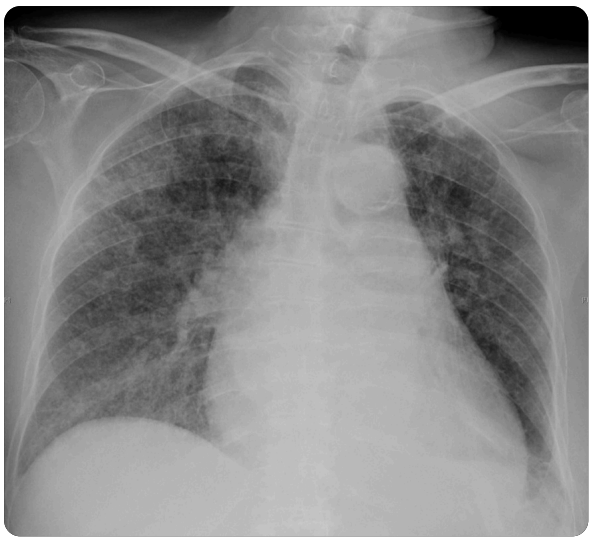


Περιστατικό 75 · Ακτινογραφία θώρακα

Ερώτηση: Περιγράψτε τα ευρήματα· σε αυτή την περίπτωση πρέπει η θεραπεία να περιμένει την ακτινογραφία;

Περιστατικό 76 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία θώρακα PA · **Κλινικές πληροφορίες:** Πυρετός, καταβολή, απώλεια βάρους· ανοσοκαταστολή.

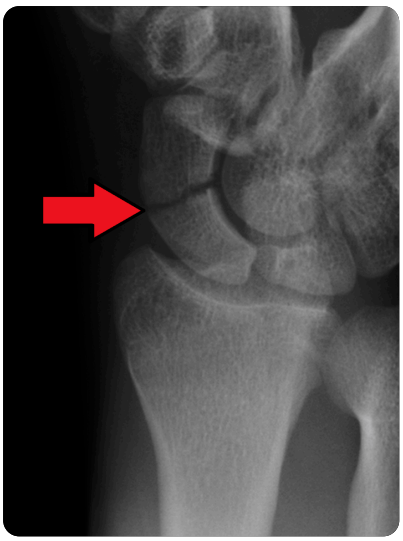


Περιστατικό 76 · Ακτινογραφία θώρακα PA

Ερώτηση: Περιγράψτε το πρότυπο του παρεγχύματος.

Περιστατικό 77 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Ακτινογραφίες καρπού για το σκαφοειδές · **Κλινικές πληροφορίες:** Ευαισθησία στην ανατομική ταμπακοθήκη μετά από πτώση.



Περιστατικό 77 · Ακτινογραφίες σκαφοειδούς καρπού

Ερώτηση: Εκτιμήστε το σκαφοειδές· αν φαινόταν φυσιολογικό, τι θα συστήνατε;

Περιστατικό 78 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Ακτινογραφία κρανίου · **Κλινικές πληροφορίες:** Κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

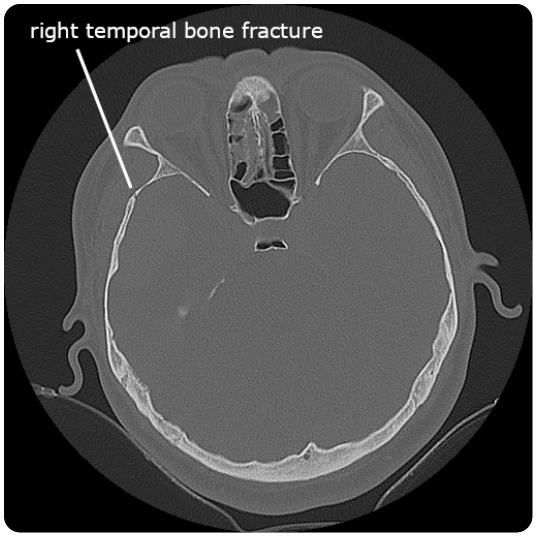
Περιστατικό 78 · Ακτινογραφία κρανίου

Ερώτηση: Διακρίνετε τη διαυγαστική γραμμή: κάταγμα, ραφή ή αγγειακή αύλακα.

Περιστατικό 79

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Αξονική, οστικό παράθυρο · **Κλινικές πληροφορίες:** Πτώση από ύψος.



Περιστατικό 79 · Αξονική, οστικό παράθυρο

Ερώτηση: Περιγράψτε το κάταγμα στο οστικό παράθυρο.

Περιστατικό 80

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Αξονική σπονδυλικής στήλης · **Κλινικές πληροφορίες:** Τραύμα υψηλής ενέργειας, άλγος ράχης.

Περιστατικό 80 · Αξονική σπονδυλικής στήλης

Ερώτηση: Περιγράψτε το κάταγμα και αναζητήστε ευρήματα αστάθειας.

Περιστατικό 81

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική σπονδυλικής στήλης · **Κλινικές πληροφορίες:** Γνωστή κακοήθεια· νεοεμφανιζόμενη αδυναμία κάτω άκρων.

Περιστατικό 81 · Μαγνητική σπονδυλικής στήλης

Ερώτηση: Περιγράψτε το αίτιο της πίεσης και τον νωτιαίο μυελό.

Περιστατικό 82

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας, οβελιαία T2 · **Κλινικές πληροφορίες:** Μηχανική οσφυαλγία.

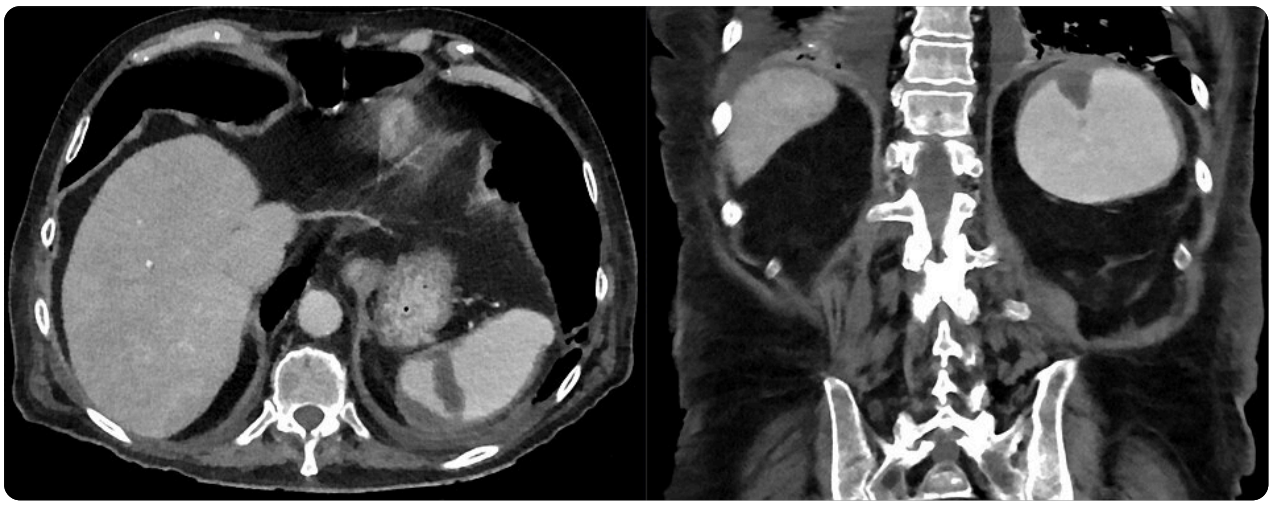
Περιστατικό 82 · Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας, οβελιαία T2

Ερώτηση: Υπάρχει παθολογία; Πώς διακρίνετε ένα εύρημα που σχετίζεται με την ηλικία από την παθολογία;

Περιστατικό 83

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό (πρωτόκολλο τραύματος) · **Κλινικές πληροφορίες:** Αμβλύ κοιλιακό τραύμα, άλγος αριστερού άνω τεταρτημορίου.



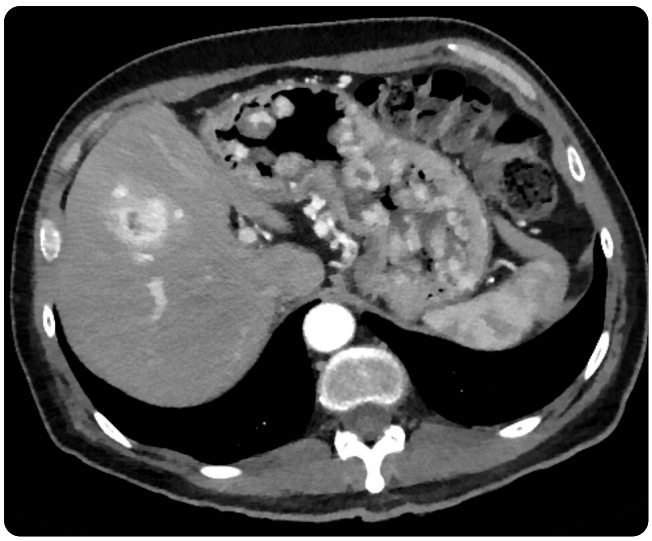
Περιστατικό 83 · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό (πρωτόκολλο τραύματος)

Ερώτηση: Περιγράψτε την κάκωση οργάνου και αναζητήστε ενεργό αιμορραγία.

Περιστατικό 84

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό, πυλαία φλεβική φάση · **Κλινικές πληροφορίες:** Ιστορικό καρκίνου παχέος εντέρου· σταδιοποίηση.



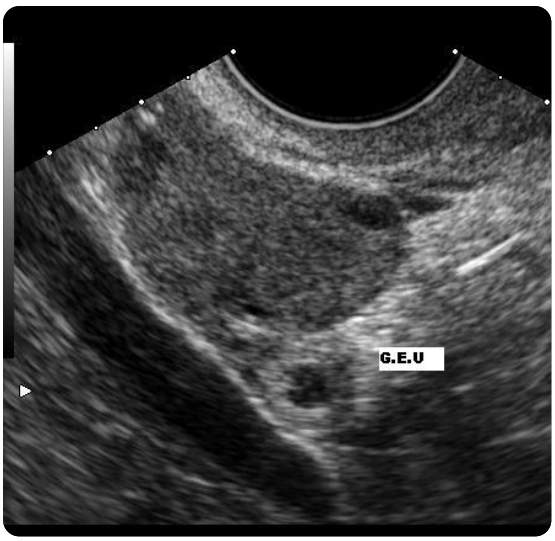
Περιστατικό 84 · Αξονική κοιλίας με σκιαγραφικό, πυλαία φλεβική φάση

Ερώτηση: Περιγράψτε τις βλάβες.

Περιστατικό 85

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα πυέλου / διακολπικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Θετικό τεστ κύησης, πυελικό άλγος, κολπική αιμορραγία.

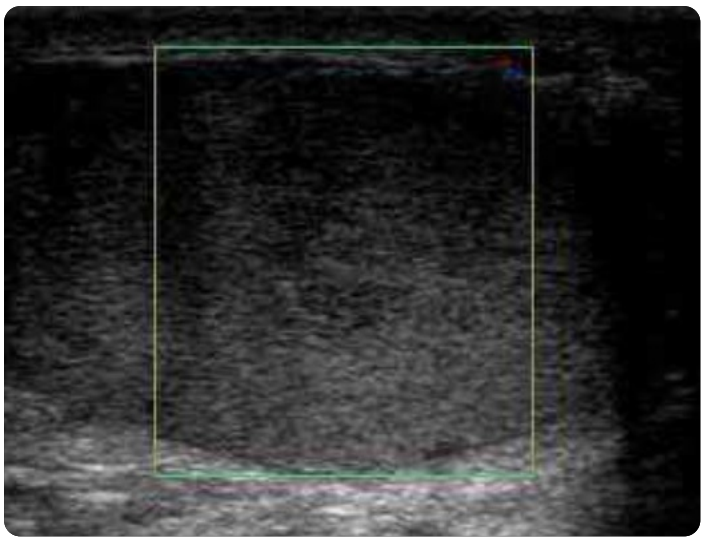


Περιστατικό 85 · Υπερηχογράφημα πυέλου / διακολπικό

Ερώτηση: Εκτιμήστε τη μήτρα και τα εξαρτήματα.

Περιστατικό 86 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα οσχέου · **Κλινικές πληροφορίες:** Έφηβος· αιφνίδιο έντονο άλγος όρχεως.



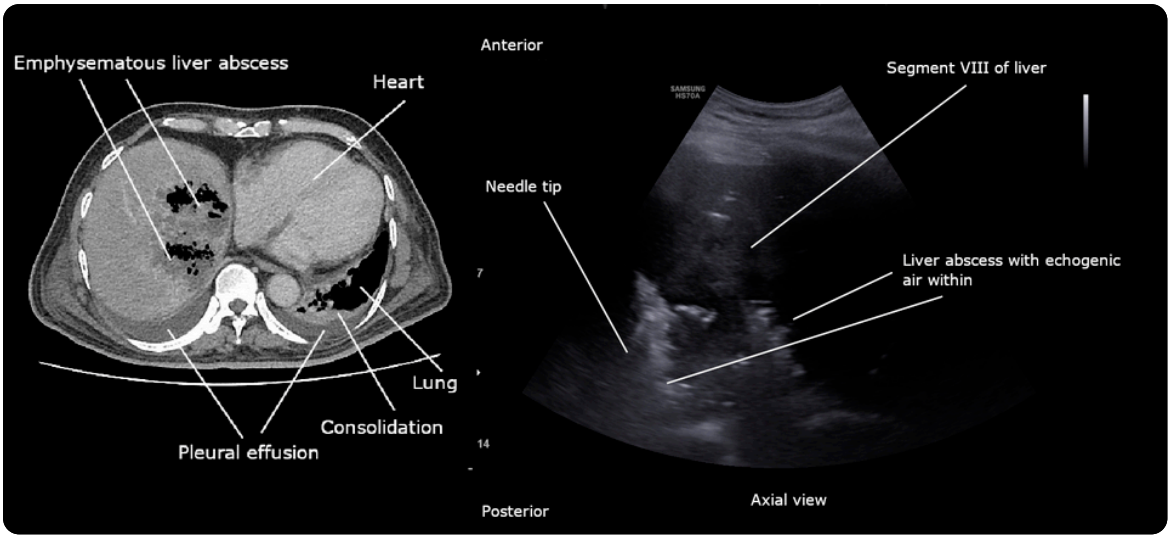
Περιστατικό 86 · Έγχρωμο Doppler υπερηχογράφημα οσχέου

Ερώτηση: Εκτιμήστε το παρέγχυμα του όρχεως και την αιματική ροή συγκρίνοντας τις δύο πλευρές.

Περιστατικό 87

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα κοιλίας · **Κλινικές πληροφορίες:** Πυρετός, άλγος δεξιού άνω τεταρτημορίου, λευκοκυττάρωση.



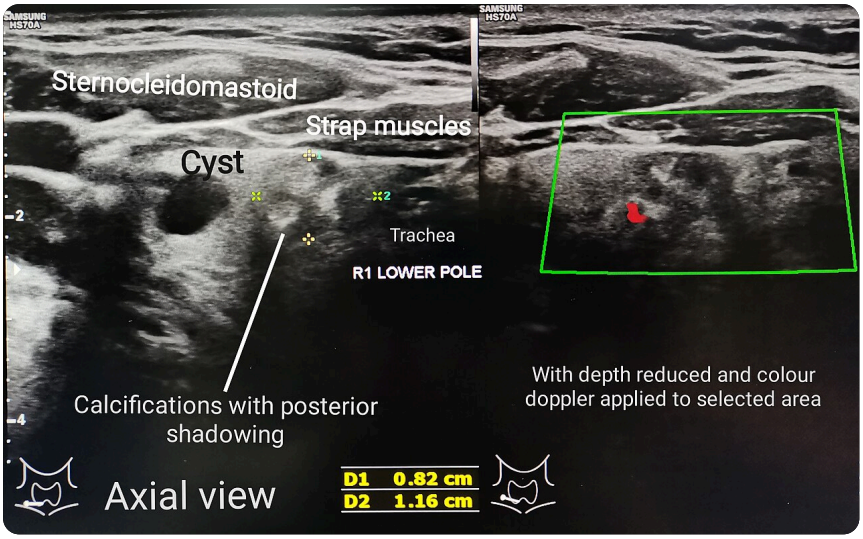
Περιστατικό 87 · Υπερηχογράφημα κοιλίας

Ερώτηση: Περιγράψτε τη βλάβη και γράψτε τη διαφορική διάγνωση.

Περιστατικό 88

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς · **Κλινικές πληροφορίες:** Ψηλαφητή διόγκωση στον τράχηλο.



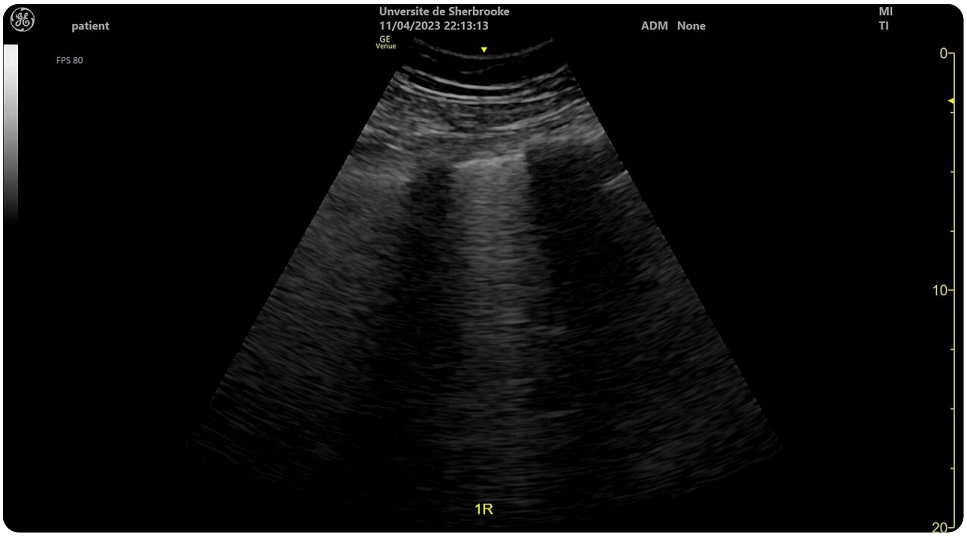
Περιστατικό 88 · Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Ερώτηση: Περιγράψτε τον όζο με τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ταξινόμηση κινδύνου.

Περιστατικό 89

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Υπερηχογράφημα πνεύμονα (POCUS) · **Κλινικές πληροφορίες:** Δύσπνοια στη ΜΕΘ.



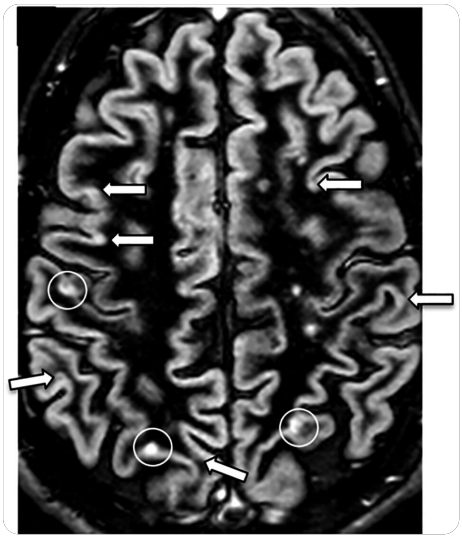
Περιστατικό 89 · Υπερηχογράφημα πνευμόνων (POCUS)

Ερώτηση: Περιγράψτε το τέχνημα και γράψτε τι σημαίνει.

Περιστατικό 90

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική εγκεφάλου, FLAIR / T2 · **Κλινικές πληροφορίες:** Νέος ασθενής· παροδικό θάμπωμα όρασης στο παρελθόν, αιμωδία άκρου.



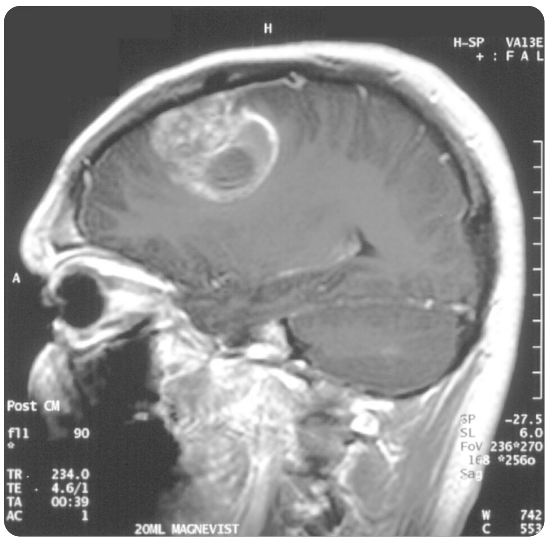
Περιστατικό 90 · Μαγνητική εγκεφάλου, FLAIR / T2

Ερώτηση: Περιγράψτε τις βλάβες με βάση την εντόπιση και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά.

Περιστατικό 91

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική εγκεφάλου, T1 με σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Κεφαλαλγία, αλλαγή προσωπικότητας.



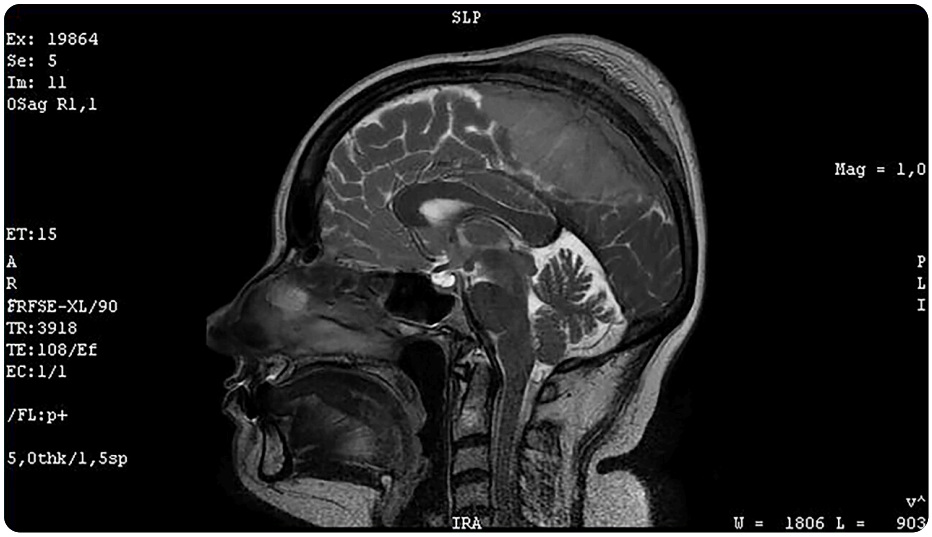
Περιστατικό 91 · Μαγνητική εγκεφάλου, T1 με σκιαγραφικό

Ερώτηση: Περιγράψτε το πρότυπο ενίσχυσης της μάζας.

Περιστατικό 92

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική εγκεφάλου, T1 με σκιαγραφικό · **Κλινικές πληροφορίες:** Κεφαλαλγία.



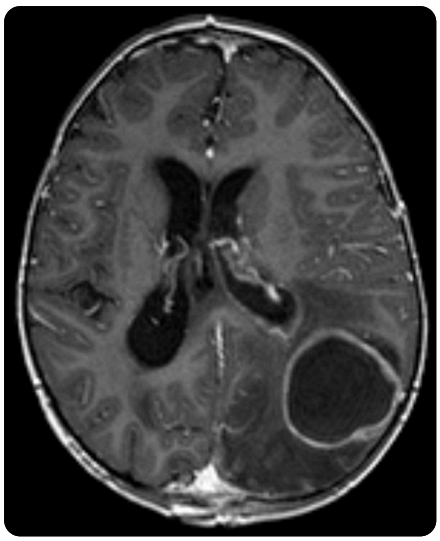
Περιστατικό 92 · Μαγνητική εγκεφάλου, T1 με σκιαγραφικό

Ερώτηση: Με ποια ευρήματα λέτε ότι η βλάβη είναι εξωαξονική;

Περιστατικό 93

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική εγκεφάλου, T1 με σκιαγραφικό και DWI · **Κλινικές πληροφορίες:** Πυρετός, κεφαλαλγία· ιστορικό ιγμορίτιδας ή ωτίτιδας.



Περιστατικό 93 · Μαγνητική εγκεφάλου, T1 με σκιαγραφικό και DWI

Ερώτηση: Περιγράψτε το εύρημα που διακρίνει το απόστημα από τον όγκο.

Περιστατικό 94

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

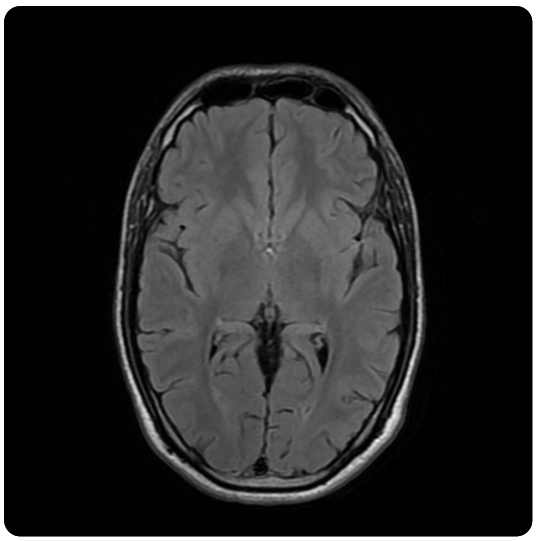
Εξέταση: Μαγνητική υπόφυσης (δυναμική με σκιαγραφικό) · **Κλινικές πληροφορίες:** Κεφαλαλγία· διαταραχή οπτικού πεδίου ή ορμονική διαταραχή.

Περιστατικό 94 · Μαγνητική υπόφυσης (δυναμική με σκιαγραφικό)

Ερώτηση: Περιγράψτε τη βλάβη και γράψτε τις σχέσεις της με τις γειτονικές δομές.

Περιστατικό 95 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική εγκεφάλου, εγκάρσια FLAIR · **Κλινικές πληροφορίες:** Κεφαλαλγία τύπου ημικρανίας.

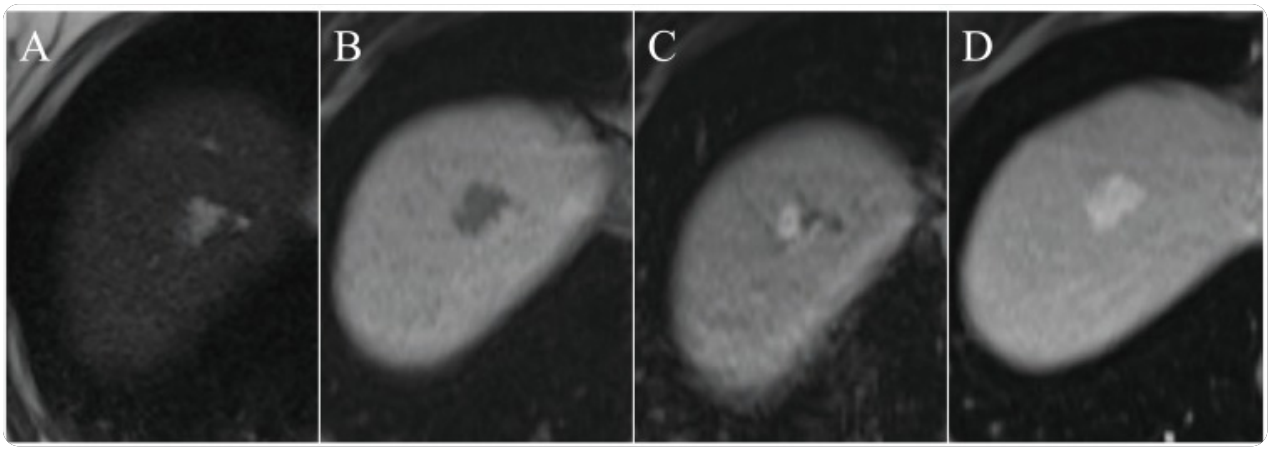


Περιστατικό 95 · Μαγνητική εγκεφάλου, εγκάρσια FLAIR

Ερώτηση: Προσδιορίστε την ακολουθία· υπάρχει παθολογία;

Περιστατικό 96 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική ήπατος (δυναμική με σκιαγραφικό) · **Κλινικές πληροφορίες:** Τυχαία ηπατική βλάβη στο υπερηχογράφημα.



Περιστατικό 96 · Μαγνητική ήπατος (δυναμική με σκιαγραφικό)

Ερώτηση: Περιγράψτε το σήμα και το πρότυπο ενίσχυσης της βλάβης.

Περιστατικό 97

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική γόνατος, οβελιαία PD / T2 · **Κλινικές πληροφορίες:** Στροφική κίνηση κατά την άθληση, ήχος «κρακ», αιμάρθρωση.

Περιστατικό 97 · Μαγνητική γόνατος, οβελιαία PD / T2

Ερώτηση: Περιγράψτε τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο· απαριθμήστε τα έμμεσα ευρήματα.

Περιστατικό 98

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική γόνατος, οβελιαία / στεφανιαία PD · **Κλινικές πληροφορίες:** Άλγος και «κλείδωμα» γόνατος.

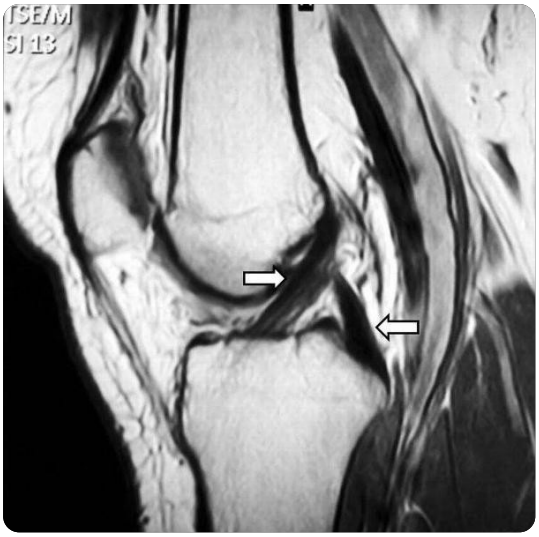
Περιστατικό 98 · Μαγνητική γόνατος, οβελιαία / στεφανιαία PD

Ερώτηση: Περιγράψτε το σήμα του μηνίσκου· γράψτε το κριτήριο ρήξης.

Περιστατικό 99

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική γόνατος · **Κλινικές πληροφορίες:** Άλγος γόνατος χωρίς τραυματισμό.



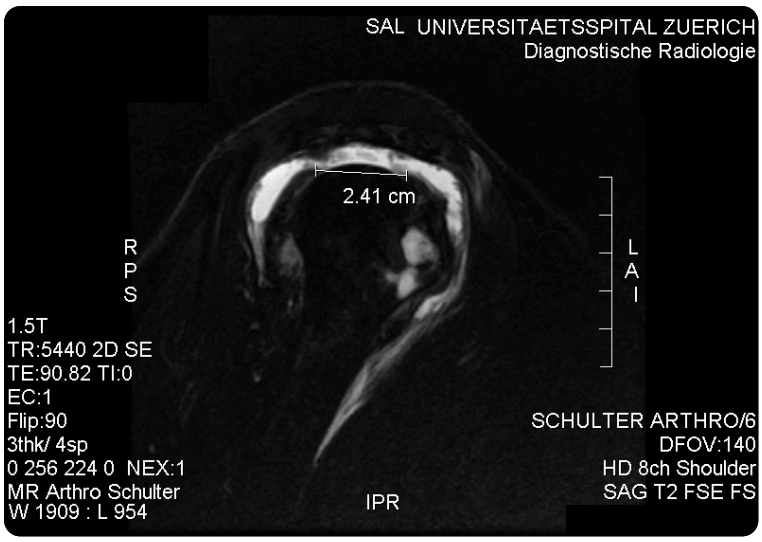
Περιστατικό 99 · Μαγνητική γόνατος

Ερώτηση: Εκτιμήστε με τη σειρά συνδέσμους, μηνίσκους και χόνδρο· υπάρχει παθολογία;

Περιστατικό 100

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

Εξέταση: Μαγνητική ώμου, στεφανιαία λοξή T2 / PD με καταστολή λίπους · **Κλινικές πληροφορίες:** Πόνος στον ώμο, αδυναμία κατά την ανύψωση του βραχίονα.



Περιστατικό 100 · Μαγνητική ώμου, στεφανιαία λοξή T2 / PD με καταστολή λίπους

Ερώτηση: Περιγράψτε το τενόντιο πέταλο των στροφέων· προσδιορίστε τον τύπο της ρήξης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 · ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κλειδί απαντήσεων — Προχωρημένο

Περιστατικά 71–100. Βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχετε γράψει τη δική σας περιγραφή.

Περιστατικό 71

Πρότυπη περιγραφή: Στις εγκάρσιες τομές T2 στάθμισης το ΕΝΥ είναι υπερέντονο. Στο εγκεφαλικό παρέγχυμα δεν παρατηρήθηκε παθολογική μεταβολή σήματος ή χωροκατακτητική βλάβη· οι κοιλίες και οι αύλακες είναι ανάλογες της ηλικίας, οι δομές της μέσης γραμμής βρίσκονται στη θέση τους.

Διάγνωση: Φυσιολογική μαγνητική εγκεφάλου (T2).

Το συχνότερο λάθος: Να ερμηνεύεται το σήμα χωρίς να προσδιοριστεί η ακολουθία· να εκλαμβάνονται οι περιαγγειακοί χώροι (Virchow-Robin) ως κενοτόπια ή πλάκες (σε όλες τις ακολουθίες έχουν το ίδιο σήμα με το ΕΝΥ).

Περιστατικό 72

Πρότυπη περιγραφή: Στην πορεία της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας παρατηρείται έντονη υπερπυκνότητα σε σύγκριση με την αρτηρία της αντίθετης πλευράς (σημείο υπέρπυκνης MCA)· μπορεί να συνάδει με οξύ θρόμβο. Πρώιμα ευρήματα ισχαιμίας στο παρέγχυμα [ ]. Αιμορραγία [δεν παρατηρείται]. Για επιβεβαίωση της απόφραξης συνιστάται αξονική αγγειογραφία· ενημερώθηκε επειγόντως η ομάδα αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.

Διάγνωση: Σημείο υπέρπυκνης MCA (υποψία οξείας απόφραξης MCA).

Το συχνότερο λάθος: Να εκλαμβάνεται ως θρόμβος η αμφοτερόπλευρη συμμετρική υπερπυκνότητα λόγω υψηλού αιματοκρίτη ή αποτιτάνωσης του αγγειακού τοιχώματος: συγκρίνετε πάντα με την αντίθετη πλευρά.

Περιστατικό 73

Πρότυπη περιγραφή: Στις εικόνες σταθμισμένες στη διάχυση παρατηρείται υπερέντονη περιοχή που αντιστοιχεί στο έδαφος της [ ] αρτηρίας, ενώ στον χάρτη ADC το αντίστοιχο χαμηλό σήμα επιβεβαιώνει τον περιορισμό της διάχυσης. Τα ευρήματα είναι συμβατά με οξύ ισχαιμικό έμφρακτο.

Διάγνωση: Οξύ ισχαιμικό έμφρακτο (περιορισμός διάχυσης).

Το συχνότερο λάθος: Θεωρείτε την υπερένταση στο DWI οξύ έμφρακτο χωρίς να ελέγξετε το ADC (φαινόμενο T2 shine-through)· δεν αναφέρετε το αγγειακό έδαφος του εμφράκτου.

Περιστατικό 74

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται ενδοτοιχωματικός κρημνός που διαχωρίζει τον αληθή από τον ψευδή αυλό της αορτής· συμβατό με διαχωρισμό αορτής. Συμμετοχή ανιούσας αορτής [ναι: Stanford A / όχι: Stanford B]· εγγύς και άπω επέκταση, συμμετοχή κλάδων και περικαρδιακό υγρό [ ]. Ενημερώθηκε επειγόντως.

Διάγνωση: Διαχωρισμός αορτής.

Το συχνότερο λάθος: Δεν γράφετε ρητά τη συμμετοχή της ανιούσας αορτής (καθορίζει την απόφαση για επείγουσα χειρουργική)· εκλαμβάνετε το τέχνημα καρδιακής κίνησης ως κρημνό.

Περιστατικό 75

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται εκτεταμένος πνευμοθώρακας χωρίς αγγειακή σκιαγράφηση πέραν της υπεζωκοτικής γραμμής, με παρεκτόπιση του μεσοθωρακίου προς την αντίθετη πλευρά, επιπέδωση του ομόπλευρου ημιδιαφράγματος και διεύρυνση των μεσοπλεύριων διαστημάτων. Τα ευρήματα συνάδουν με πνευμοθώρακα υπό τάση· ενημερώθηκε αμέσως.

Διάγνωση: Πνευμοθώρακας υπό τάση.

Το συχνότερο λάθος: Να ξεχνιέται ότι ο πνευμοθώρακας υπό τάση είναι κλινική διάγνωση: σε αιμοδυναμική αστάθεια η θεραπεία γίνεται χωρίς να αναμένεται ακτινογραφία. Όταν φανεί στην ακτινογραφία, να αφήνεται η γνωμάτευση στη συνήθη ροή αντί για επείγουσα ενημέρωση.

Περιστατικό 76

Πρότυπη περιγραφή: Και στους δύο πνεύμονες παρατηρούνται πολυάριθμοι χιλιοστομετρικοί όζοι, διάχυτοι και ομοιόμορφα κατανεμημένοι· συμβατοί με κεγχροειδές πρότυπο. Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται κεγχροειδής φυματίωση, αιματογενείς μεταστάσεις και μυκητιασική λοίμωξη. Συνιστάται κλινική συσχέτιση και αξονική.

Διάγνωση: Κεγχροειδές πρότυπο (υποψία κεγχροειδούς φυματίωσης).

Το συχνότερο λάθος: Να εκλαμβάνεται το λεπτό οζώδες πρότυπο ως φυσιολογική αγγείωση ή θόρυβος εικόνας· να περιγράφεται το εύρημα μόνο με έναν ασαφή όρο όπως «αύξηση της διάμεσης σκιαγράφησης».

Περιστατικό 77

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται λεπτή καταγματική γραμμή στο επίπεδο [μέσης / κεντρικού πόλου / περιφερικού πόλου] του σκαφοειδούς· παρεκτόπιση [ ]. Λόγω κινδύνου ψευδάρθρωσης και άσηπτης νέκρωσης συνιστάται ορθοπαιδική παρακολούθηση.

Διάγνωση: Κάταγμα σκαφοειδούς.

Το συχνότερο λάθος: Να αποκλείεται κάταγμα σκαφοειδούς επειδή δεν φαίνεται στην πρώτη ακτινογραφία: όταν υπάρχει κλινική υποψία, πρέπει να συστήνεται ακινητοποίηση και ακτινογραφία ελέγχου ή μαγνητική / αξονική.

Περιστατικό 78

Πρότυπη περιγραφή: Στον θόλο του κρανίου παρατηρείται διαυγαστική καταγματική γραμμή με σαφή όρια, χωρίς διακλαδώσεις· συμβατή με [γραμμοειδές / εμπιεστικό] κάταγμα κρανίου. Για την εκτίμηση ενδοκράνιας κάκωσης συνιστάται αξονική.

Διάγνωση: Κάταγμα κρανίου.

Το συχνότερο λάθος: Δεν διακρίνετε το κάταγμα (σαφώς διαυγαστικό, οξύ, χωρίς σκληρυντικό χείλος) από τις ραφές (οδοντωτές, συμμετρικές, σε τυπική θέση) και τις αγγειακές αύλακες (διακλαδιζόμενες, με σκληρυντικά χείλη)· δεν αναφέρετε ότι η ακτινογραφία δεν αποκλείει ενδοκράνια κάκωση.

Περιστατικό 79

Πρότυπη περιγραφή: Στο οστικό παράθυρο παρατηρείται καταγματική γραμμή στο [ ] οστό, που χαρακτηρίζεται από διακοπή της συνέχειας του φλοιού. Παρεκτόπιση των τμημάτων και επέκταση στην αρθρική επιφάνεια [ ]. Στο παράθυρο μαλακών μορίων συνοδό αιμάτωμα [ ].

Διάγνωση: Κάταγμα (αξονική, οστικό παράθυρο).

Το συχνότερο λάθος: Αναζητάτε το κάταγμα στο παράθυρο μαλακών μορίων· κοιτάτε μόνο τις εγκάρσιες τομές και παραλείπετε τις στεφανιαίες και οβελιαίες ανασυνθέσεις.

Περιστατικό 80

Πρότυπη περιγραφή: Στο σώμα του σπονδύλου [ ] παρατηρείται κάταγμα· απώλεια ύψους [ ], συμμετοχή του οπίσθιου τοιχώματος και οπισθοπροωθημένο τεμάχιο προς τον σωλήνα [ ], κάταγμα οπίσθιων στοιχείων [ ]. Τα ευρήματα συνάδουν με [συμπιεστικό / εκρηκτικό] κάταγμα. Για εκτίμηση κάκωσης νωτιαίου μυελού και συνδέσμων συνιστάται μαγνητική.

Διάγνωση: Κάταγμα σπονδύλου.

Το συχνότερο λάθος: Γνωματεύετε το εκρηκτικό κάταγμα ως απλό συμπιεστικό χωρίς να εκτιμήσετε το οπίσθιο τοίχωμα και τα οπίσθια στοιχεία· χάνετε δεύτερο, μη συνεχόμενο κάταγμα σε άλλο επίπεδο (σαρώστε ολόκληρη τη σπονδυλική στήλη).

Περιστατικό 81

Πρότυπη περιγραφή: Στο επίπεδο [ ] παρατηρείται συμπίεση του νωτιαίου μυελού λόγω [επισκληρίδιας μάζας / οστικού τεμαχίου / δίσκου] που εκτείνεται στον σπονδυλικό σωλήνα· μεταβολή σήματος στον νωτιαίο μυελό [ ]. Τα ευρήματα συνάδουν με συμπίεση νωτιαίου μυελού· ενημερώθηκε επειγόντως.

Διάγνωση: Συμπίεση νωτιαίου μυελού.

Το συχνότερο λάθος: Να ελέγχεται μόνο το συμπτωματικό επίπεδο (σε μεταστατική νόσο πρέπει να ελέγχεται ολόκληρη η σπονδυλική στήλη)· να μην ερμηνεύεται το σήμα του νωτιαίου μυελού και να παραλείπεται η επείγουσα ενημέρωση.

Περιστατικό 82

Πρότυπη περιγραφή: Τα ύψη των σωμάτων των οσφυϊκών σπονδύλων και η ευθυγράμμισή τους διατηρούνται· το σήμα του μυελού των οστών είναι φυσιολογικό. Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι έχουν σήμα [αντίστοιχο της ηλικίας]· δεν παρατηρείται σαφής κήλη δίσκου, στένωση του νωτιαίου σωλήνα ή των τρημάτων. Ο μυελικός κώνος στο πεδίο λήψης έχει φυσιολογικό σήμα.

Διάγνωση: Φυσιολογική μαγνητική οσφυϊκής μοίρας σπονδυλικής στήλης.

Το συχνότερο λάθος: Γνωματεύετε ήπια ευρήματα δίσκων που είναι συχνά και σε ασυμπτωματικά άτομα (αφυδάτωση, διόγκωση) σαν κλινικά σημαντική παθολογία· δεν αναφέρετε τη συσχέτιση του ευρήματος με την κλινική εικόνα.

Περιστατικό 83

Πρότυπη περιγραφή: Στο σπληνικό παρέγχυμα παρατηρείται γραμμοειδής / ανώμαλη υπόπυκνη περιοχή χωρίς ενίσχυση (ρήξη) και [υποκάψιο / περισπληνικό] αιμάτωμα. Ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού [ ] (συγκρίθηκε με την καθυστερημένη φάση). Αιμοπεριτόναιο [ ]. Τα ευρήματα είναι συμβατά με κάκωση σπλήνα· πρέπει να διαβαθμιστεί σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα τραύματος.

Διάγνωση: Ρήξη σπλήνα.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε την ετερογενή («ζέβρα») ενίσχυση του σπλήνα στην αρτηριακή φάση ως ρήξη (εκτιμήστε στην πυλαία φλεβική φάση)· δεν γνωματεύετε την ενεργό διαφυγή σκιαγραφικού.

Περιστατικό 84

Πρότυπη περιγραφή: Στο ήπαρ παρατηρούνται πολυάριθμες συμπαγείς βλάβες, υπόπυκνες σε σχέση με το παρέγχυμα στην πυλαία φλεβική φάση, [με περιφερική δακτυλιοειδή ενίσχυση]· με το γνωστό ιστορικό κακοήθειας είναι συμβατές με μεταστάσεις. Μεγαλύτερη βλάβη [ ] mm, κατανομή ανά τμήμα [ ]. Σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση [ ].

Διάγνωση: Ηπατικές μεταστάσεις.

Το συχνότερο λάθος: Να ταξινομούνται αναγκαστικά πολύ μικρές υπόπυκνες βλάβες ως κύστεις ή μεταστάσεις (σωστό: «πολύ μικρές για να χαρακτηριστούν»)· να μη γίνεται σύγκριση με προηγούμενη εξέταση.

Περιστατικό 85

Πρότυπη περιγραφή: Στην ενδομήτρια κοιλότητα δεν παρατηρείται ενδομήτρια κύηση. Στο εξάρτημα, χωριστά από την ωοθήκη, παρατηρείται δομή συμβατή με έκτοπη κύηση με μορφή [ηχογενούς δακτυλίου / σάκου κύησης] και ελεύθερο υγρό στην πύελο [ ]. Ενημερώθηκε για επείγουσα γυναικολογική εκτίμηση.

Διάγνωση: Έκτοπη κύηση.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε το ενδομητρικό υγρό (ψευδοσάκος κύησης) ως ενδομήτρια κύηση· εκλαμβάνετε το ωχρό σωμάτιο ως έκτοπη μάζα (το ωχρό σωμάτιο βρίσκεται εντός της ωοθήκης).

Περιστατικό 86

Πρότυπη περιγραφή: Στον προσβεβλημένο όρχι, με έγχρωμο Doppler, η παρεγχυματική ροή [δεν παρατηρείται / είναι σαφώς μειωμένη σε σχέση με την αντίθετη πλευρά]· ο όρχις [είναι διογκωμένος, με ετερογενή ηχοδομή]. Εικόνα δίνης στον σπερματικό τόνο [ ]. Τα ευρήματα είναι συμβατά με συστροφή όρχεως· ανακοινώθηκε για επείγουσα ουρολογική εκτίμηση.

Διάγνωση: Συστροφή όρχεως.

Το συχνότερο λάθος: Λέτε «η ροή είναι μειωμένη» χωρίς να συγκρίνετε τις ρυθμίσεις Doppler με τον αντίθετο όρχι· δεν αναφέρετε ότι σε μερική συστροφή μπορεί να φαίνεται ροή και ότι το φυσιολογικό Doppler δεν αποκλείει πλήρως τη συστροφή.

Περιστατικό 87

Πρότυπη περιγραφή: Στο ήπαρ παρατηρείται σύμπλοκη κυστική / υποηχογενής βλάβη με ασαφή όρια, παχύ τοίχωμα και υπολείμματα εντός της. Σε συνδυασμό με τα κλινικά ευρήματα είναι συμβατή με ηπατικό απόστημα· στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται υδατίδα κύστη και νεκρωτική μετάσταση. Συνιστάται αξονική με σκιαγραφικό και κλινική συσχέτιση.

Διάγνωση: Ηπατικό απόστημα.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε το απόστημα πρώιμης φάσης ως συμπαγή μάζα· δεν εντάσσετε στη διαφορική διάγνωση την υδατίδα κύστη, που είναι συχνή στην Ελλάδα (σημαντική πριν από επεμβατική πράξη).

Περιστατικό 88

Πρότυπη περιγραφή: Στον θυρεοειδή αδένα παρατηρείται όζος. Σύσταση [συμπαγής / κυστική / μικτή], ηχογένεια [ ], σχήμα [ψηλότερο από φαρδύ / όχι], όρια [ ], ηχογενείς εστίες [ ]· διαστάσεις στα τρία επίπεδα [ ] mm. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρθηκε η κατηγορία κινδύνου [σύστημα TI-RADS που χρησιμοποιήθηκε] και διατυπώθηκε σύσταση. Εκτιμήθηκαν οι λεμφαδένες του τραχήλου.

Διάγνωση: Όζος θυρεοειδούς.

Το συχνότερο λάθος: Να αναγράφεται μόνο το μέγεθος χωρίς να γνωματεύονται η σύσταση, η ηχογένεια, το σχήμα, τα όρια και οι ηχογενείς εστίες· να μην εκτιμώνται οι λεμφαδένες του τραχήλου.

Περιστατικό 89

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρούνται κάθετα υπερηχογενή τεχνήματα (γραμμές B) που ξεκινούν από την υπεζωκοτική γραμμή και εκτείνονται χωρίς εξασθένηση έως το κάτω άκρο της οθόνης, εξαλείφουν τις γραμμές A και κινούνται με την ολίσθηση του υπεζωκότα. Τρεις ή περισσότερες γραμμές B σε ένα μεσοπλεύριο διάστημα συνηγορούν υπέρ διάμεσου συνδρόμου· η αμφοτερόπλευρη διάχυτη κατανομή εκτιμάται υπέρ πνευμονικού οιδήματος.

Διάγνωση: Γραμμές B (διάμεσο σύνδρομο).

Το συχνότερο λάθος: Να θεωρούνται παθολογικές μεμονωμένες γραμμές B (φυσιολογικά μπορεί να φαίνονται λίγες)· να εκλαμβάνονται βραχέα τεχνήματα που εξασθενούν ως γραμμές B· να μην αναγράφεται η κατανομή (εστιακή / διάχυτη).

Περιστατικό 90

Πρότυπη περιγραφή: Στη λευκή ουσία παρατηρούνται ωοειδείς βλάβες, υπερέντονες σε T2/FLAIR, με εντόπιση [περικοιλιακή / παραφλοιώδη / υποσκηνιδιακή]· ορισμένες έχουν προσανατολισμό κάθετο στις κοιλίες [ ]. Ενεργός βλάβη στις ακολουθίες με σκιαγραφικό [ ]. Τα ευρήματα, σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα, μπορεί να είναι συμβατά με απομυελινωτική νόσο.

Διάγνωση: Βλάβες συμβατές με απομυελινωτική νόσο (σκλήρυνση κατά πλάκας).

Το συχνότερο λάθος: Γνωματεύετε ως σκλήρυνση κατά πλάκας μη ειδικές βλάβες λευκής ουσίας λόγω νόσου μικρών αγγείων· δεν αναφέρετε χωριστά τις εντοπίσεις που έχουν σημασία στα διαγνωστικά κριτήρια (περικοιλιακή, παραφλοιώδης / φλοιώδης, υποσκηνιδιακή, νωτιαία).

Περιστατικό 91

Πρότυπη περιγραφή: Στο εγκεφαλικό παρέγχυμα παρατηρείται ενδοαξονική μάζα με ανώμαλη, παχιά δακτυλιοειδή ενίσχυση και κεντρική νέκρωση, με πέριξ αγγειογενές οίδημα· φαινόμενο μάζας [ ]. Τα ευρήματα μπορεί να είναι συμβατά με γλοιακό όγκο υψηλού βαθμού· στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται μετάσταση και απόστημα (απαιτείται εκτίμηση με διάχυση και αιμάτωση).

Διάγνωση: Γλοιακός όγκος υψηλής κακοήθειας (υποψία γλοιοβλαστώματος).

Το συχνότερο λάθος: Θεωρείτε όγκο κάθε βλάβη με δακτυλιοειδή ενίσχυση: διακρίνετε το απόστημα από τον περιορισμό διάχυσης εντός της κοιλότητας.

Περιστατικό 92

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται εξωαξονική μάζα με ευρεία βάση πρόσφυσης στη σκληρά μήνιγγα, με ομοιογενή και έντονη ενίσχυση· σημείο της σκληρομηνιγγικής ουράς [ ] και σχισμή ΕΝΥ μεταξύ βλάβης και παρεγχύματος [ ]. Πίεση και οίδημα του παρακείμενου παρεγχύματος [ ]. Τα ευρήματα είναι συμβατά με μηνιγγίωμα.

Διάγνωση: Μηνιγγίωμα.

Το συχνότερο λάθος: Ερμηνεύετε τη βλάβη ως ενδοαξονικό όγκο χωρίς να αναζητήσετε τα εξωαξονικά ευρήματα (σχισμή ΕΝΥ, έσω μετατόπιση της φαιάς ουσίας, σκληρομηνιγγική βάση).

Περιστατικό 93

Πρότυπη περιγραφή: Παρατηρείται βλάβη με λεπτό και ομαλό τοίχωμα και δακτυλιοειδή ενίσχυση, με περιβάλλον αγγειογενές οίδημα· το κέντρο της βλάβης εμφανίζει έντονο περιορισμό στις εικόνες διάχυσης. Τα ευρήματα συνάδουν με εγκεφαλικό απόστημα· όσον αφορά πηγή από γειτονικούς κόλπους και μαστοειδή [ ].

Διάγνωση: Εγκεφαλικό απόστημα.

Το συχνότερο λάθος: Χαρακτηρίζετε τη βλάβη νεκρωτικό όγκο χωρίς να κοιτάξετε την ακολουθία διάχυσης· δεν γνωματεύετε τον κίνδυνο ρήξης προς την κοιλία και την πιθανή πηγή.

Περιστατικό 94

Πρότυπη περιγραφή: Στην υπόφυση παρατηρείται βλάβη που ενισχύεται [αργότερα / λιγότερο] σε σχέση με τον φυσιολογικό αδενικό ιστό, συμβατή με αδένωμα· μέγεθος [ ] mm (κάτω από 10 mm μικροαδένωμα, 10 mm και άνω μακροαδένωμα). Σχέση με το οπτικό χίασμα, διήθηση του σηραγγώδους κόλπου και επέκταση στον σφηνοειδή κόλπο [ ].

Διάγνωση: Αδένωμα υπόφυσης.

Το συχνότερο λάθος: Να μην αναφέρεται η σχέση με το οπτικό χίασμα και η διήθηση του σηραγγώδους κόλπου· να εκλαμβάνεται ως αδένωμα η υπόφυση, που μπορεί να διογκωθεί φυσιολογικά στην εφηβεία και στην κύηση.

Περιστατικό 95

Πρότυπη περιγραφή: Στις τομές FLAIR το σήμα του ΕΝΥ είναι κατεσταλμένο. Στο παρέγχυμα δεν παρατηρείται παθολογική υπερένταση ή χωροκατακτητική βλάβη· οι κοιλίες και οι αύλακες είναι φυσιολογικές.

Διάγνωση: Φυσιολογική μαγνητική εγκεφάλου (FLAIR).

Το συχνότερο λάθος: Να εκλαμβάνονται ως βλάβες οι λεπτές υπερέντονες περιοχές γύρω από τα κέρατα των κοιλιών, που μπορεί να φαίνονται φυσιολογικά, ή τα τεχνήματα ροής ΕΝΥ.

Περιστατικό 96

Πρότυπη περιγραφή: Στο ήπαρ παρατηρείται βλάβη έντονα υπερέντονη στις T2 σταθμισμένες εικόνες, με περιφερική οζώδη (ασυνεχή) ενίσχυση στις δυναμικές ακολουθίες και κεντρομόλο πλήρωση στις όψιμες φάσεις· συμβατή με αιμαγγείωμα.

Διάγνωση: Αιμαγγείωμα ήπατος.

Το συχνότερο λάθος: Δεν διακρίνετε τη συνεχή δακτυλιοειδή ενίσχυση της μετάστασης από την περιφερική οζώδη ασυνεχή ενίσχυση του αιμαγγειώματος· εκλαμβάνετε το μικρό αιμαγγείωμα ταχείας πλήρωσης ως υπεραγγειακό όγκο.

Περιστατικό 97

Πρότυπη περιγραφή: Στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο παρατηρούνται απώλεια της συνέχειας των ινών και αύξηση του σήματος· συνάδει με [ολική / μερική] ρήξη. Έμμεσα ευρήματα: [οστικές θλάσεις τυπικής εντόπισης], [πρόσθια μετατόπιση της κνήμης], αρθρική συλλογή. Συνοδός κάκωση μηνίσκων και πλάγιων συνδέσμων [ ].

Διάγνωση: Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ).

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε φυσιολογικό σύνδεσμο ως ρήξη λόγω φαινομένου μερικού όγκου (παρακολουθήστε τον σύνδεσμο σε περισσότερα από ένα επίπεδα)· δεν γνωματεύετε συνοδές κακώσεις μηνίσκων και πλάγιων συνδέσμων.

Περιστατικό 98

Πρότυπη περιγραφή: Στον μηνίσκο [ ] παρατηρείται γραμμοειδής αύξηση σήματος που φτάνει στην αρθρική επιφάνεια· συμβατή με [οριζόντια / κάθετη / ακτινωτή / τύπου λαβής κάδου] ρήξη. Ως κριτήριο ρήξης χρησιμοποιήθηκε η επέκταση του σήματος στην αρθρική επιφάνεια σε τουλάχιστον δύο διαδοχικές τομές.

Διάγνωση: Ρήξη μηνίσκου.

Το συχνότερο λάθος: Γνωματεύετε ως ρήξη το ενδομηνισκικό (εκφυλιστικό) σήμα που δεν φτάνει στην αρθρική επιφάνεια· δεν αναζητάτε το παρεκτοπισμένο τμήμα σε ρήξη τύπου «λαβής κάδου».

Περιστατικό 99

Πρότυπη περιγραφή: Ο πρόσθιος και ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος καθώς και οι πλάγιοι σύνδεσμοι εμφανίζουν φυσιολογικό σήμα και συνέχεια· στους μηνίσκους δεν παρατηρήθηκε μεταβολή σήματος που να φθάνει στην αρθρική επιφάνεια. Ο αρθρικός χόνδρος και το σήμα του μυελού των οστών είναι φυσιολογικά· δεν παρατηρήθηκε σημαντική συλλογή.

Διάγνωση: Φυσιολογική μαγνητική γόνατος.

Το συχνότερο λάθος: Εκλαμβάνετε ως ρήξη το τέχνημα «μαγικής γωνίας» που εμφανίζεται στις ακολουθίες με βραχύ ΤΕ ή φυσιολογικές ανατομικές δομές (π.χ. εγκάρσιο μεσομηνίσκιο σύνδεσμο).

Περιστατικό 100

Πρότυπη περιγραφή: Στον τένοντα [προσβεβλημένος τένοντας] παρατηρείται σήμα υγρού συμβατό με [μερική / ολικού πάχους] ρήξη. Σε ρήξη ολικού πάχους, βαθμός απόσυρσης, μυϊκή ατροφία και λιπώδης εκφύλιση [ ].

Υγρό στον υπακρωμιακό-υποδελτοειδή θύλακο [ ].

Διάγνωση: Ρήξη τενοντίου πετάλου των στροφέων.

Το συχνότερο λάθος: Να συγχέεται η τενοντοπάθεια (μέτρια αύξηση σήματος) με ρήξη (σήμα υγρού)· να μη γνωματεύονται η απόσυρση και η μυϊκή ατροφία σε ρήξη ολικού πάχους.

ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τετράδιο λαθών

Ο συντομότερος δρόμος για να μην κάνετε το ίδιο λάθος δεύτερη φορά είναι να το καταγράψετε.

> *Καταγράψτε κάθε λανθασμένο περιστατικό σε μία γραμμή. Μετά από δέκα γραμμές μετρήστε τους τύπους λαθών σας: ο συχνότερος τύπος είναι το επόμενο θέμα μελέτης σας.*

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ	Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙ ΕΧΑΣΑ / ΤΙ ΕΓΡΑΨΑ ΛΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΛΑΘΟΥΣ	ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ	Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙ ΕΧΑΣΑ / ΤΙ ΕΓΡΑΨΑ ΛΑΘΟΣ	ΤΥΠΟΣ ΛΑΘΟΥΣ	ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ

Τύποι λαθών

- [ ] **Αντίληψη** — Το εύρημα ήταν στην εικόνα αλλά δεν το είδα (ελλιπής σειρά σάρωσης, σταμάτησα στο πρώτο εύρημα).
- [ ] **Γνώση** — Το είδα αλλά δεν ήξερα τι ήταν.
- [ ] **Όρος** — Είδα σωστά, έγραψα με λάθος ή ασαφή λέξη.
- [ ] **Συμπέρασμα** — Τα ευρήματα σωστά, λείπει η συμπερασματική πρόταση, η σύσταση ή η επείγουσα ενημέρωση.
- [ ] **Υπερδιάγνωση** — Έγραψα μια φυσιολογική δομή ή ένα τέχνημα ως παθολογία.

Πηγές εικόνων

Οι ιατρικές εικόνες αυτού του βιβλίου προέρχονται από τα Wikimedia Commons, με ανοιχτές άδειες που επιτρέπουν την εμπορική χρήση (CC0, κοινό κτήμα, CC BY, CC BY-SA). Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική τους μορφή, με μόνη αλλαγή την προσαρμογή μεγέθους ή την περικοπή. Ευχαριστούμε τους δημιουργούς τους.

1. Normal posteroanterior (PA) chest radiograph (X-ray).jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_posteroanterior_(PA)_chest_radiograph_(X-ray).jpg)
2. Chest X-ray of pneumothorax.png — Alex Bonilla, Alexander J. Blair, Suliman M. Alamro, Rebecca A. Ward, Michael B. Feldman, Richard A. Dutko, Theodora K. · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_of_pneumothorax.png)
3. Pleural effusion.jpg — User InvictaHOG on en.wikipedia Edited by InvictaHOG, all edits released into public domain Commons upload by Magnus Ma · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion.jpg)
4. X-ray of lobar pneumonia.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_lobar_pneumonia.jpg)
5. Chest radiograph with signs of congestive heart failure - annotated.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_with_signs_of_congestive_heart_failure_-_annotated.jpg)
6. Chest X-ray showing presence of free air under left diaphragm.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_X-ray_showing_presence_of_free_air_under_left_diaphragm.png)
7. Displaced distal radius fracture.jpg — Curtishand · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Displaced_distal_radius_fracture.jpg)
8. X-ray of normal hand by dorsoplantar projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_normal_hand_by_dorsoplantar_projection.jpg)
9. X-ray of a comminuted hip fracture.jpg — Rohan R. Memon, Drashtant Patel and Nishant Juva · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_comminuted_hip_fracture.jpg)
10. Shoulder dislocation, Y-projection after reduction.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shoulder_dislocation,_Y-projection_after_reduction.jpg)
11. Trimalleolar Ankle Fracture.jpg — Chaim Mintz · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trimalleolar_Ankle_Fracture.jpg)
12. Subtle tibia fracture - X-ray.jpg — Mohamed Jarraya, Daichi Hayashi, Frank W. Roemer, Michel D. Crema, Luis Diaz, Jane Conlin, Monica D. Marra, Nabil Jomaah · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subtle_tibia_fracture_-_X-ray.jpg)
13. Knee plain X-ray weight bearing.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Knee_plain_X-ray_weight_bearing.jpg)
14. X-ray of a normal knee by anteroposterior projection.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D. · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_a_normal_knee_by_anteroposterior_projection.jpg)
15. X-ray of Trinket Swallowed by a Child (FDA010) (6946959167).jpg — The U.S. Food and Drug Administration · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_Trinket_Swallowed_by_a_Child_(FDA010)_(6946959167).jpg)
16. Tubusspitze im rechten Hauptbronchus 64W - CR ap - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tubusspitze_im_rechten_Hauptbronchus_64W_-_CR_ap_-_001_-_Annotation.jpg)
17. Human chest x-ray, adult male, with central venous catheter.jpg — A medical image produced in the course of obtaining a diagnosis. Not a copyrightable work in the country of origin (Pola · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Human_chest_x-ray,_adult_male,_with_central_venous_catheter.jpg)
18. Kidney stones abdominal X-ray.jpg — Bill Rhodes from Asheville · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_stones_abdominal_X-ray.jpg)
19. Medical X-Ray imaging MEO05 nevit.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medical_X-Ray_imaging_MEO05_nevit.jpg)
20. 1. Bowel-obstruction-x-ray.jpg — Igboeze · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1._Bowel-obstruction-x-ray.jpg)
21. Pancoast Tumor 1.jpg — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pancoast_Tumor_1.jpg)
22. Scoliosis recklinghausen.jpg — Gkiokas A et al · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scoliosis_recklinghausen.jpg)
23. X-ray of cyst in pneumocystis pneumonia 2.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_cyst_in_pneumocystis_pneumonia_2.jpg)
24. Gallstones.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gallstones.PNG)
25. Renal cyst ultrasound 3.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Renal_cyst_ultrasound_3.jpg)
26. Ultrasound image of right kidney hydronephrosis with colour doppler.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_image_of_right_kidney_hydronephrosis_with_colour_doppler.png)
27. Ascites ultrasound 2.JPG — Samir · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ascites_ultrasound_2.JPG)

28. Ultrasound of upper right liver lobe showing fatty liver.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_upper_right_liver_lobe_showing_fatty_liver.jpg)
29. Pleural effusion editted.jpg — Harstonraven · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleural_effusion_editted.jpg)
30. Breast ultrasound 110315090418 0905260.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Breast_ultrasound_110315090418_0905260.jpg)
31. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
32. Proximaler Harnleiterstein 87M - CT coronar KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Proximaler_Harnleiterstein_87M_-_CT_coronar_KM_pv_-_001.jpg)
33. Leberzysten.jpg — Hg6996 · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leberzysten.jpg)
34. Emphysema CT.JPG — PLoS Medicine · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysema_CT.JPG)
35. Chronische Sinusitis sphenoidalis 86M - CT axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chronische_Sinusitis_sphenoidalis_86M_-_CT_axial_-_001.jpg)
36. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
37. EpiduralHematoma.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:EpiduralHematoma.jpg)
38. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
39. Subarachnoidalblutung traumatisch 83W - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subarachnoidalblutung_traumatisch_83W_-_CT_-_001.jpg)
40. 1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg — 0475ramosk · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:1-s2.0-S0967586810002766-gr2.jpg)
41. Langjaehrig bestehender Hydrocephalus 48M - CT - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langjaehrig_bestehender_Hydrocephalus_48M_-_CT_-_001.jpg)
42. CT brain tumor.jpg — Bobjgalindo · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_tumor.jpg)
43. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
44. CT of part solid lung nodule.png — Article authors: Annemie Snoeckx, Pieter Reyntiens, Damien Desbuquoit, Maarten J. Spinhoven, Paul E. Van Schil, Jan P. v · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_part_solid_lung_nodule.png)
45. X-ray and CT of ground glass opacities and pneumothorax in pneumocystis pneumonia.jpg — Carolyn M. Allen, Hamdan H. AL-Jahdali, Klaus L. Irion, Sarah Al Ghanem, Alaa Gouda, and Ali Nawaz Khan · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_and_CT_of_ground_glass_opacities_and_pneumothorax_in_pneumocystis_pneumonia.jpg)
46. 10-03-Pneumothorax CT coronar.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:10-03-Pneumothorax_CT_coronar.png)
47. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
48. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
49. 02-Sigmadivertikulitis CT ax 001 Umgebung.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:02-Sigmadivertikulitis_CT_ax_001_Umgebung.png)
50. Bridenileus mit Hungerdarm 75M - CT axial und coronar KM pv - 001 - Annotation.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bridenileus_mit_Hungerdarm_75M_-_CT_axial_und_coronar_KM_pv_-_001_-_Annotation.jpg)
51. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
52. Akute exsudative Pankreatitis - CT axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Akute_exsudative_Pankreatitis_-_CT_axial.jpg)
53. AcuteCholMark.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:AcuteCholMark.png)
54. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)
55. Ultrasonography of a normal liver.jpg — Mikael Häggström · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_a_normal_liver.jpg)
56. Acute cholecystitis as seen on ultrasound axial view.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acute_cholecystitis_as_seen_on_ultrasound_axial_view.jpg)
57. FluidMorisonsPouchEctop.PNG — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FluidMorisonsPouchEctop.PNG)
58. Doppler ultrasound in long-axis view of axillary and subclavian vein thrombosis - annotated.jpg — Tony Rosen, Betty Chang, Martha Kaufman, Mary Soderman and David C Riley · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doppler_ultrasound_in_long-axis_view_of_axillary_and_subclavian_vein_thrombosis_-_annotated.jpg)
59. Appendicitis ultrasound.png — Borbély Márton · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Appendicitis_ultrasound.png)

60. Ultrasonography of abdominal aortic aneurysm in sagittal plane.jpg — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasonography_of_abdominal_aortic_aneurysm_in_sagittal_plane.jpg)
61. Pericardial effusion.jpg — Kalumet · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pericardial_effusion.jpg)
62. Kidney ultrasound 110315132820 1329070.jpg — Nevit Dilmen (talk) · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kidney_ultrasound_110315132820_1329070.jpg)
63. Bronchiolitis chest X-ray.jpg — Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bronchiolitis_chest_X-ray.jpg)
64. Salt water aspiration syndrome chest x-ray, before treatment.png — Dr. Terence McManus · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salt_water_aspiration_syndrome_chest_x-ray,_before_treatment.png)
65. Tuberculosis-x-ray-1.jpg — Unknown authorUnknown author · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuberculosis-x-ray-1.jpg)
66. X-ray of rib fractures and pneumothorax.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_rib_fractures_and_pneumothorax.jpg)
67. Sigmoidvolvulus.jpg — Mont4nha · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sigmoidvolvulus.jpg)
68. Supracondylarfrac.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supracondylarfrac.png)
69. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 05.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_05.jpg)
70. Radiography pelvis with bone metastasis 01.jpg — Chih-Yu Chen, Yong-Te Hsueh, Tsung-Yu Lan, Wei-Hsin Lin, Karl Wu and Rong-Sen Yang · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radiography_pelvis_with_bone_metastasis_01.jpg)
71. Normal axial T2-weighted MR image of the brain.jpg — Novaksean · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_axial_T2-weighted_MR_image_of_the_brain.jpg)
72. Right dense MCA sign as seen on CT brain.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Right_dense_MCA_sign_as_seen_on_CT_brain.jpg)
73. DWI MRI of a cerebral infarction.jpg — Hellerhoff, isolation of DWI image by Mikael Häggström · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DWI_MRI_of_a_cerebral_infarction.jpg)
74. Descending (Type B Stanford) Aortic Dissection.PNG — JasonRobertYoungMD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Descending_(Type_B_Stanford)_Aortic_Dissection.PNG)
75. Pneumothorax CXR.jpg — Photographed by User Clinical Cases 00:42, 7 November 2006 · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pneumothorax_CXR.jpg)
76. Chest radiograph of miliary tuberculosis 1.jpg — Benjamín Herreros, Isabel Plaza, Rebeca García, Marta Chichón, Carmen Guerrero and Emilio Pintor · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chest_radiograph_of_miliary_tuberculosis_1.jpg)
77. X-ray of scaphoid fracture.png — Gilo1969 · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X-ray_of_scaphoid_fracture.png)
78. Chevallet fracture - x-ray lateral view of skull and neck.jpg — Own work · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chevallet_fracture_-_x-ray_lateral_view_of_skull_and_neck.jpg)
79. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
80. BurstSaL4LCT.png — James Heilman, MD · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BurstSaL4LCT.png)
81. Compressive myeolopathy C6C7.png — Jmarchn · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Compressive_myeolopathy_C6C7.png)
82. Lumbar MRI t2-tse-rst-sagittal 10.jpg — Stillwaterising · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lumbar_MRI_t2-tse-rst-sagittal_10.jpg)
83. Traumatische Milzruptur mit subkapsulaerem Haematom 81M - CT KM pv - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Traumatische_Milzruptur_mit_subkapsulaerem_Haematom_81M_-_CT_KM_pv_-_001.jpg)
84. Magen- und Lebermetastasen bei Nierenzellkarzinom 67jm - CT art axial - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magen-_und_Lebermetastasen_bei_Nierenzellkarzinom_67jm_-_CT_art_axial_-_001.jpg)
85. Ectopic pregnancy.JPG — X.Compagnion · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ectopic_pregnancy.JPG)
86. Scrotal ultrasonography of testicular torsion.jpg — Chee-Wai Mak and Wen-Sheng Tzeng · CC BY 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Scrotal_ultrasonography_of_testicular_torsion.jpg)
87. Emphysematous liver abscess as shown on CT and ultrasound in axial view.png — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emphysematous_liver_abscess_as_shown_on_CT_and_ultrasound_in_axial_view.png)
88. Ultrasound of thyroid showing right lower pole cyst and a calcified nodule.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ultrasound_of_thyroid_showing_right_lower_pole_cyst_and_a_calcified_nodule.jpg)
89. B lines on a lung ultrasound of a patient with fibrosis.jpg — Tinss · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:B_lines_on_a_lung_ultrasound_of_a_patient_with_fibrosis.jpg)
90. Axial DIR MRI of a brain with multiple sclerosis lesions.jpg — Article authors: Alice Favaretto, Davide Poggiali, Andrea Lazzarotto, Giuseppe Rolma, Francesco Causin, Paolo Gallo · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Axial_DIR_MRI_of_a_brain_with_multiple_sclerosis_lesions.jpg)
91. Glioblastoma - MR sagittal with contrast.jpg — Christaras A · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glioblastoma_-_MR_sagittal_with_contrast.jpg)

92. Meningioma of the sagittal sinus isolated.jpg — RASPBERRY VIBE · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meningioma_of_the_sagittal_sinus_isolated.jpg)
93. Brain abscess - MRI T1 KM axial.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brain_abscess_-_MRI_T1_KM_axial.jpg)
94. Acromegaly pituitary macroadenoma.JPEG — Philippe Chanson and Sylvie Salenave · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acromegaly_pituitary_macroadenoma.JPEG)
95. Mri Brain Flair Axial (10).jpg — 511KeV · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mri_Brain_Flair_Axial_(10).jpg)
96. Angioma epatico-RM.jpg — Nils Albiin · CC BY 2.5 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angioma_epatico-RM.jpg)
97. VKB-Riss MRT T1 PDW sag.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:VKB-Riss_MRT_T1_PDW_sag.jpg)
98. MRI meniscus tear.jpg — Ciernik M · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRI_meniscus_tear.jpg)
99. MRT ACL PCL 01.jpg — Marios G Lykissas, George I Mataliotakis, Nikolaos Paschos, Christos Panovrakos, Alexandros E Beris and Christos D Papag · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MRT_ACL_PCL_01.jpg)
100. 2 MRI. Complete tear and rupture of the supraspinatus tendon. Wide transmural damage (2.4 x 2.4 cm)..jpg — RSatUSZ · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2_MRI._Complete_tear_and_rupture_of_the_supraspinatus_tendon._Wide_transmural_damage_(2.4_x_2.4_cm)..jpg)

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Συνεχίστε με βάση τον συχνότερο τύπο λάθους στο τετράδιο λαθών σας. **Όρος** — αν κυριαρχούν αυτά τα λάθη, ανοίξτε «Το Αλφάβητο της Εικόνας: Όροι και Συντομογραφίες Γνωματεύσεων»· **συμπέρασμα** — αν κυριαρχούν αυτά τα λάθη, περάστε στα πρότυπα γνωματεύσεων με το «Τετράδιο Εξάσκησης: Από το Εύρημα στη Γνωμάτευση»· **αντίληψη** ή **γνώση** — αν κυριαρχούν αυτά τα λάθη, επιστρέψτε στον Τόμο της αντίστοιχης απεικονιστικής μεθόδου (Τόμοι 02–05).

Μία εβδομάδα αργότερα λύστε ξανά το ίδιο επίπεδο χωρίς να κοιτάξετε τις απαντήσεις και συγκρίνετε τον αριθμό των λαθών σας.